[ASN2026]

GLP-1, 비만을 넘어 신장질환 치료제로 새로운 축으로

#GLP-1 #비만치료제 #CVRM #신장질환 #적응증 확장



DB증권

이명선[제약/바이오]

2026.11.03.

Summary



고금리와 글로벌 금융시장 변동성 확대로 글로벌과 국내 헬스케어 주가는 다른 움직임이 있다. 그럼에도 제약 · 바이오 산업내 공통적인 성장축은 비만, 심혈관질환, 신장질환 및 대사질환을 포괄하는 통합적인 질병관리로 확장이라고 생각한다.

최근 GLP-1 치료제의 경쟁 영역이 체중감량에서 심혈관 · 신장 · 대사질환(CVRM)을 포괄하는 통합 질병 관리로 확대되고 있다. 비만은 당뇨병, 심혈관질환, 만성신장질환(CKD)으로 이어지는 주요 위험요인이며, GLP-1 계열 치료제는 체중 및 혈당 조절을 넘어 주요 임상시험에서 심혈관 · 신장 보호 효과를 입증하며 치료 패러다임의 변화를 이끌고 있다. SELECT에서 세마글루타이드는 주요 심혈관사건(MACE)을 20%, SOUL에서는 14% 감소시켰으며, FLOW에서는 제2형 당뇨병 동반 CKD 환자의 주요 신장 · 심혈관 복합평가변수 위험을 24% 낮췄다. 이러한 임상적 근거는 비만치료제의 시장을 단순 체중감량에서 장기적인 만성질환 관리 영역으로 확장시키고 있다. 다만 시장의 실질적인 성장은 임상적 유효성뿐 아니라 약가, 보험급여, 공급 능력 및 장기 치료 지속성에 의해 좌우될 전망이다.

글로벌 제약사들은 차세대 비만 · 대사질환 시장 선점을 위해 기술 도입과 인수합병을 적극적으로 확대하고 있으며, 경쟁의 중심도 단일 GLP-1 작용제에서 다중 기전과 병용요법으로 이동하고 있다. 한편 신장질환 시장에서는 기존 RAS 억제제와 SGLT2 억제제, MRA 중심의 보존적 치료를 넘어 당뇨병성 신증과 IgA 신증 등 질환별 병인을 직접 표적하는 치료제 개발이 활발해지고 있다. 특히 IgA 신증은 APRIL 및 BAFF/APRIL 억제제를 중심으로 경쟁이 본격화되면서 단백뇨 감소뿐 아니라 장기적인 eGFR 보존 여부가 차세대 치료제의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다.

ASN2026(미국신장학회)에서는 GLP-1 기반 치료제의 신장질환 확장 가능성을 뒷받침하는 추가 임상 및 실제 진료 데이터가 발표되었으며, 치료 가이드라인 역시 심혈관 · 신장 · 대사질환을 통합적으로 관리하는 방향으로 변화하고 있다. 노보와 일라이릴리는 꾸준히 신장 기능개선 등에 대한 임상결과를 발표하고 있으며, 비당뇨 CKD 및 투석 환자 대상 관찰연구도 새로운 환자군으로의 확장 가능성을 제시한다. 한편 KDIGO 2026 등 치료가이드라인 변화는 GLP-1 기반 치료의 심혈관 · 신장 보호 역할을 강화하는 흐름을 보여주고 있으며, AKI 발생 이후 AKD와 CKD로 이어지는 질병 연속성에 대한 예방 및 장기 관리의 중요성도 부각되고 있다.

국내에서는 한미약품 등 차세대 비만치료제 개발 기업과 지투지바이오의 장기지속형 제형 기술, 큐라클 · 인제니아테라퓨틱스의 신장 미세혈관 및 TIE2 표적 접근, 압타바이오의 NOX 억제제 APX-115 등 다양한 개발 전략이 진행되고 있다.

Contents

Ⅰ. 미국과 다른 국내 헬스케어 내 주가 흐름 4
거시환경 혼란 속 대사질환을 포괄하는 통합 질병 관리로 확장 중 4

Ⅱ. GLP-1 의 확장: 비만치료제에서 CVRM 치료제 7
비만치료제의 진화와 CVRM 시장의 등장 7
GLP-1 치료제의 적응증 확장에 따른 경제적 가치와 급여 딜레마 11
글로벌 기업들의 비만/대사질환 확장을 위한 노력 17

Ⅲ. 신장질환 치료 패러다임의 변화와 새로운 시장 기회 23
만성신장질환 치료 시장: 보존적 치료에서 질환 진행 억제로 23
당뇨병성 신증에서 IgA 신증까지: 질환 기전별 표적치료제 경쟁 확대 26
급성 신손상에서 만성 신장질환까지: AKI-AKD-CKD 연속성의 중요성 28

Ⅳ. 미국신장학회 ASN2026: 신장질환 지료 지형 변화 32
GLP-1 의 신장보호효과, 비당뇨 CKD 및 중증 환자로 확대 32
비당뇨 CKD 와 투석 환자: 새로운 환자군으로의 확장 39
KDIGO 가이드라인 변화와 신장질환 치료의 새로운 기준 41
국내 개발 현황 및 투자기회 45

Ⅴ. Coverage Recommendation 51
삼성바이오로직스(207940) 52
한미약품(128940) 59
HK 이노엔(195940) 68
압타바이오(293780) 72

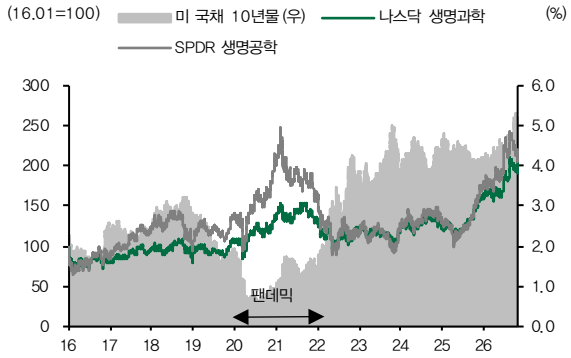
Ⅰ. 미국과 다른 국내 헬스케어 내 주가 흐름

거시환경 혼란 속 대사질환을 포괄하는 통합 질병 관리로 확장 중

고금리와 글로벌 금융시장 변동성 확대로 미국과 국내 바이오 섹터의 주가 흐름은 차별화되는 모습이다. 미국은 빅파마의 견조한 현금창출력과 특허만료(Patent Cliff)와 약가인하에 대응하기 위한 외부 파이프라인 확보 수요, 바이오텍의 IPO 및 M&A 시장 회복 등이 산업 전반의 투자 기반으로 작용하고 있다. 반면 국내는 임상 단계 바이오텍의 비중이 높고 기술이전 성과와 후속 개발 자금조달 가능성에 대한 의존도가 상대적으로 커 금리 상승에 따른 미래 현금흐름 할인과 투자심리 위축에 더 민감하다. 미국 바이오 시장 역시 대형 상업화 기업과 중소형 임상 기업 간 주가 차별화가 나타나고 있다는 점에서, 현재의 시장은 바이오 산업 전반에 대한 일률적인 투자보다 실질적인 임상 성과와 상업화 가능성을 중심으로 자금이 선별적으로 유입되는 국면으로 판단된다.

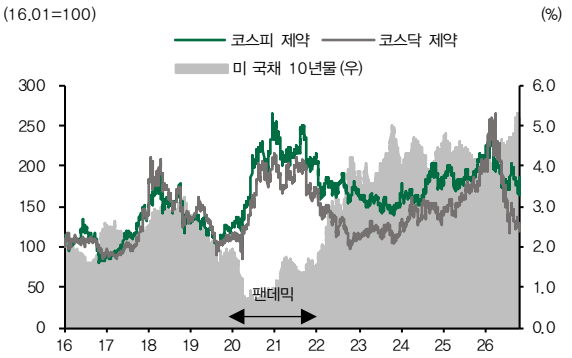
이러한 환경에서 주목할 변화는 제약·바이오 산업의 성장축이 비만, 심혈관질환, 신장질환 및 대사질환을 포괄하는 통합적인 질병관리로 확장되고 있다는 점이다. 특히 GLP-1 기반 치료제는 체중 감량을 넘어 심혈관 사건 감소와 신장기능 악화 지연 등 임상적 유효성을 축적하면서 기존 비만치료제의 시장 범위를 재정의하고 있다. 이는 단순히 새로운 적응증이 추가되는 문제가 아니다. 만성질환 환자의 치료 기간과 대상 환자군이 확대되고, 장기적인 의료비 절감 및 보험재정 측면에서도 경제적 가치가 발생할 수 있다는 의미다. 신장질환 분야에서 FLOW, SELECT, SOUL 등 주요 임상은 GLP-1 치료의 심혈관·신장 보호 효과를 뒷받침하는 근거를 축적하고 있으며, 비만·당뇨병 중심으로 형성됐던 시장이 CKD 및 CVRM 영역으로 확장되는 전환점에 있다.

도표 1. 미국 국채 10년물 금리 변동에 따른 미국 헬스케어 주가 변동



자료: Bloomberg, DB증권

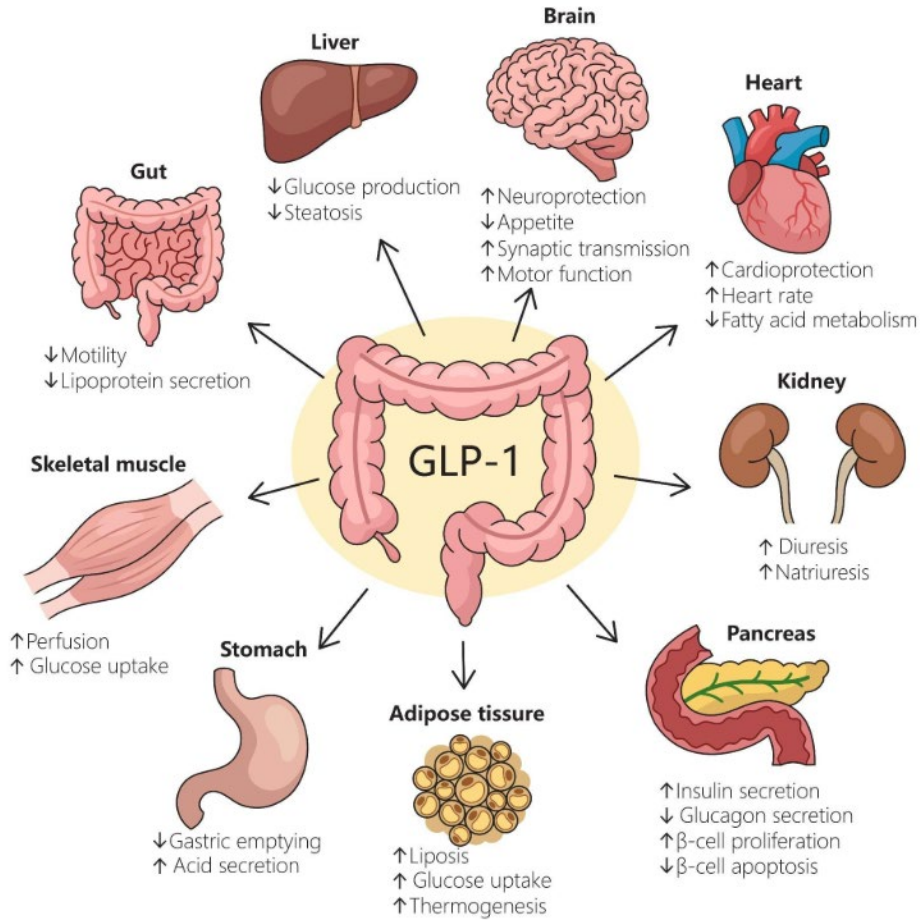
도표 2. 미국 국채 10년물 금리 변동에 따른 한국 헬스케어 주가 변동



자료: Bloomberg, DB증권

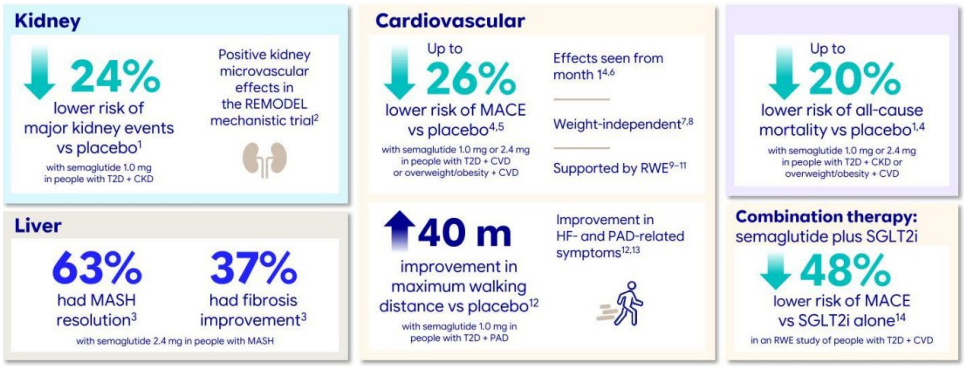
결국 향후 바이오 섹터의 기업가치 재평가는 금리 하락에 따른 유동성 회복만으로 설명되기보다 글로벌 헬스케어 패러다임 변화가 실제 치료 범위와 의료시장 확대로 연결되는지에 달려 있다. 빅파마 입장에서는 GLP-1 기반 치료제의 적응증 확장이 장기적인 매출 성장과 시장 지배력 확보의 기회이며, 국내 기업에는 장기지속형 제형, 병용요법, 차세대 인크레틴 및 신장질환 치료제 등 새로운 기술수요가 형성될 수 있다. 다만 글로벌 시장의 성장성이 국내 기업의 기업가치 상승으로 직결되는 것은 아니다. 임상적 차별성, 글로벌 파트너사의 개발 의지, 기술이전의 실질적인 계약금 및 후속 개발 단계, 상업화 가능성을 구분해 평가해야 한다. 따라서 GLP-1의 신장질환 적응증 확장이 의료적 · 경제적으로 갖는 의미를 살펴보고, 이를 바탕으로 글로벌 빅파마의 전략 변화와 국내 바이오 기업의 사업 기회를 함께 분석해볼 필요가 있다.

도표 3. 비만치료제의 진화: 체중감량에서 CVRM 보호로



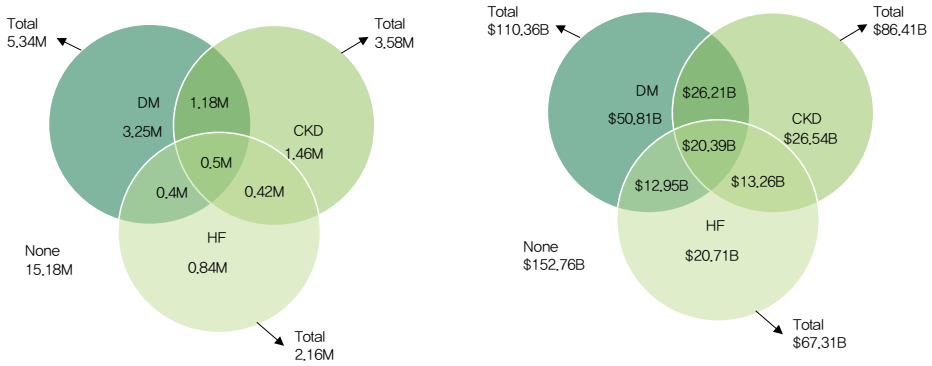
자료: 기사, DB증권

도표 4. 비만 동반 만성질환(CVOT, CKD 등) 적응증 확대을 위한 임상적 근거



자료: 노보노디스크, DB증권

도표 5. 2022년 만성 신장 질환, 당뇨병 및 심부전을 가진 노인층의 유병률 및 연간 지출 분포 (대상자 23.24M, 연간 지출액 $323.65B)



자료: USRDS, DB증권

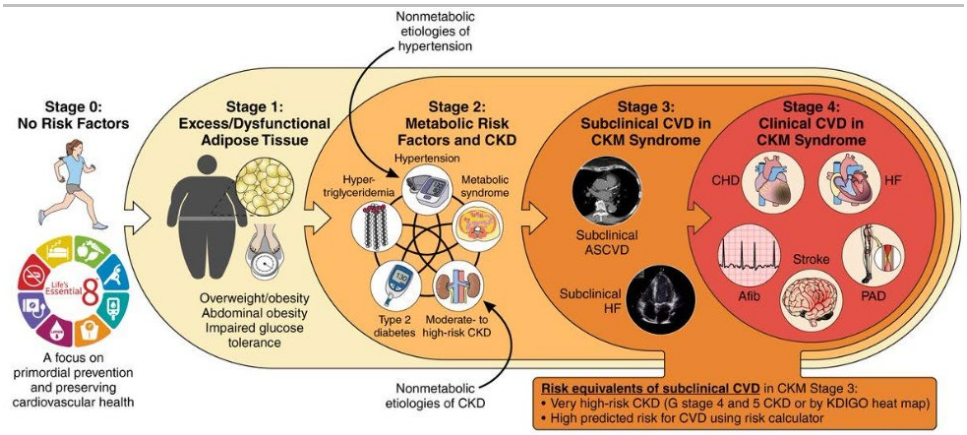
GLP-1의 적응증 확장은 신장질환 치료의 의료경제적 가치 측면에서도 주목할 필요가 있다. 미국 USRDS 자료에 따르면 2022년 66세 이상 Medicare 수혜자 중 CKD 환자는 전체의 15.4%에 불과했으나, 이들의 의료비 지출은 전체의 26.7%인 865억달러에 달했다. 특히 2012~2022년 CKD 관련 Medicare 지출은 물가 조정 기준 38% 증가하면서 동기간 전체 Medicare 지출이 2.6% 감소한 것과 대조적이다. 이러한 의료비 부담 속에서 FLOW 임상은 세마글루타이드가 제2형 당뇨병 동반 CKD 환자의 주요 신장 · 심혈관 복합평가변수 위험을 24% 낮출 수 있음을 입증했다. 이는 GLP-1 치료가 기존 비만 · 당뇨병 시장을 넘어 CKD 환자군으로 확대될 수 있는 임상적 근거를 확보했다는 의미다. 향후 치료 접근성 확대와 장기적인 질병 진행 지연이 실제 의료비 절감으로 이어질 수 있는지는 약제비를 포함한 비용효과성 평가를 통해 추가 검증이 필요하다.

II. GLP-1의 확장: 비만치료제에서 CVRM 치료제

비만치료제의 진화와 CVRM 시장의 등장

비만은 단순한 에너지 섭취 과잉이 아닌 식욕조절, 포만감, 에너지 소비 및 다양한 호르몬신호가 복합적으로 관여하는 만성/재발성 질환이다. GLP-1 수용체 작용제는 식욕과 에너지 섭취를 감소시키는 동시에 혈당 조절을 개선하며, GLP-1/GIP 이중작용제는 서로 다른 대사 경로를 활용해 치료 효과를 확장하고 있다. 이에 따라 차세대 비만치료제의 경쟁력은 체중감소율뿐 아니라 내약성, 치료 지속성, 투여 편의성 및 장기적인 대사 개선 효과를 함께 고려하는 방향으로 변화하고 있다.

도표 6. 비만에서 CKD 심혈관질환으로 이어지는 질병 진행과 조기 개입의 경제적 가치



자료: AI 생성, DB증권

GLP-1 계열 비만치료제가 체중감량을 넘어 심혈관/ 신장질환의 위험을 낮추는 치료제로 확장되면서 최근 CVRM(Cardiovascular, Renal, and Metabolism, 심뇌혈관 · 신장 · 대사 질환) 예방 또는 치료제로 관심 받고 있다. 이유는 GLP-1 계열 의약품이 CVRM관련 적응증에 대한 위험도 감소, 예방효과 등의 임상적 결과를 발표하였기 때문이다.

대표적으로 SELECT 임상에서는 비만 또는 과체중의 당뇨병이 없는 심혈관질환 환자에서 세마글루타이드 투여로 MACE(major adverse cardiovascular events, 주요심혈관사건) 위험을 20% 감소, 심부전 및 신장 관련 지표에서도 긍정적인 결과가 관찰됐다. 또한 SOUL에서는 제2형 당뇨병과 ASCVD(죽상경화성 심혈관질환, atherosclerotic Cardiovascular Disease) 또는 CKD(만성신장질환)을 보유한 비만 및 과체중 환자에서 경구 세마글루타이드가 MACE 14% 감소시킨다는 결과를 발표하였다. 기존에는 비만으로 인한 당뇨에서 심혈관/신장질환으로 진행되는 구조에서 비만을 조기 치료함으로써 얼마나 많은 장기에 임상적 사건을 개선시킬 수 있는가에 대한 치료제 개발로 경쟁구조가 전환되고 있다.

세마글루타이드의 FLOW 연구에서는 제2형 당뇨병과 만성콩팥병을 동반한 환자 3,533명을 대상으로 중앙값 3.4년간 추적한 결과, 신부전 발생 · 지속적인 신기능 저하 · 신장 또는 심혈관 사망으로 구성된 일차 복합평가변수의 위험이 위약 대비 24% 감소했다(HR 0.76, 95% CI 0.66–0.88). 이는 GLP–1 계열의 가치 평가에서 체중 감량 및 혈당 개선뿐 아니라 신장 예후와 심혈관 사건을 직접 평가하는 임상 근거가 중요해지고 있음을 보여준다.

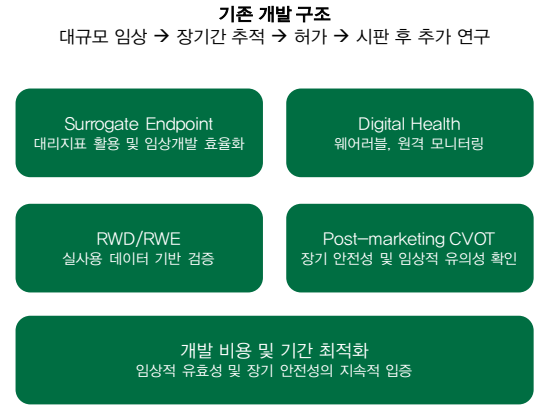
투자 관점에서는 비만치료제 시장의 성장이 CVRM 전반으로 확장될 가능성에 주목할 필요가 있다. 다만 약물의 생물학적 작용기전이나 eGFR 등 대리 지표의 개선이 모든 환자군에서 신부전 예방으로 이어진다고 단정할 수는 없다. 향후에는 적응증별 임상 결과, 기존 표준치료 대비 추가 편익, 장기 안전성, 치료 지속률 및 보험 적용 범위를 함께 평가해야 한다. 국내 신약개발 기업 역시 비만 · 당뇨 · 신장질환을 연결하는 기전적 차별성과 임상적 유효성을 입증할 수 있는지가 기술이전 및 기업가치 재평가의 주요 판단 기준이 될 전망이다

도표 7. 비만치료제의 적응증 확장 패러다임



자료: DB증권

도표 8. 비만치료제 개발의 패러다임 전환



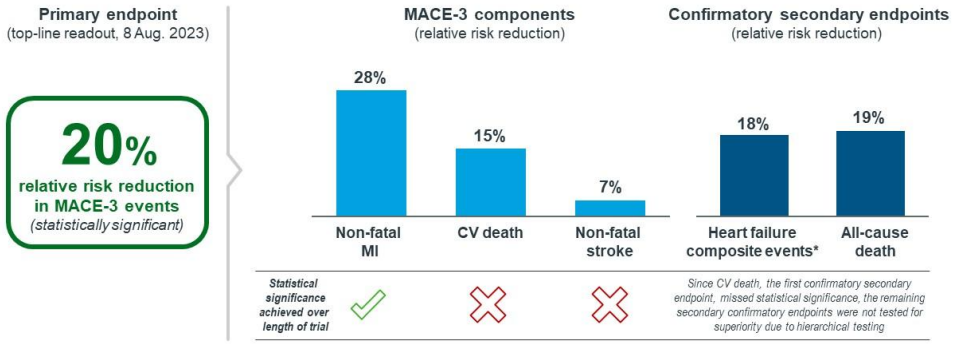
자료: DB증권

도표 9. 세마글루타이드 관련 주요 3건 임상개요 차이

구분	SELECT	SOUL	FLOW
환자수	17,604	9,650	3,533
대상	비당뇨, BMI ≥27, 기존 CVD, 45세 이상	T2D 및 ASCVD 또는 CKD, 50세 이상	T2D + 고위험 CKD, 18세 이상
투여	SC 2.4 mg/주	경구 14 mg/일	SC 1.0 mg/주
추적기간	평균 3.3년	평균 4.0년	중앙값 3.4년
주요 결과	MACE 20% 감소	MACE 14% 감소	신장 복합평가변수 24% 감소
HR	0.80	0.86	0.76

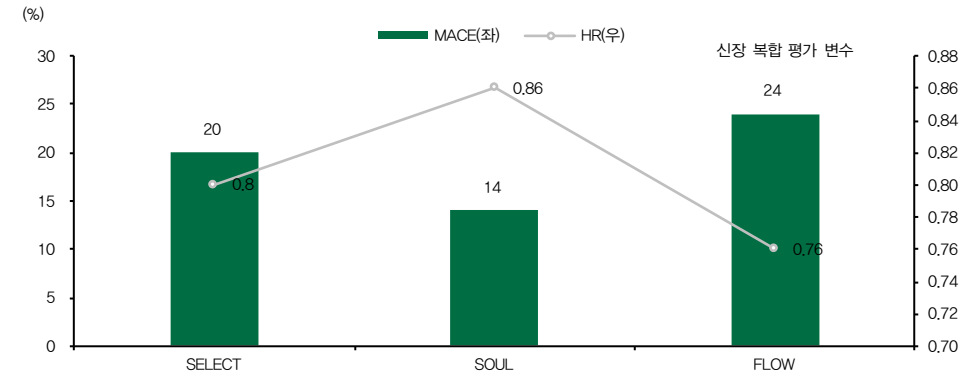
자료: SELECT: NEJM (2023, SOUL: NEJM (2025), FLOW: NEJM (2024), DB증권

도표 10. SELECT 임상: 세마글루타이드 2.4mg에 대한 심혈관질환 위험 감소를 성공적으로 입증



자료: DB증권

도표 11. GLP-1 약물에 대한 주요임상 연구에서 입증한 주요심혈관사건(MACE) 개선효과



자료: SELECT: NEJM (2023, SOUL: NEJM (2025), FLOW: NEJM (2024), DB증권
주: MACE: major adverse cardiovascular events, 주요심혈관사건, HR: Harzard Ratio

CVRM 신약은 1)다중 장기(심혈관, 신장 등)의 치료 및 보호 효과로의 확장. 2) 장기 복용이 가능한 안전성 및 편의성, 3) 기존 GLP-1, SGLT-2, MRA 등 표준치료 대비 추가적인 임상적 가치를 입증하는 것이 경쟁력이 될 것이다. 다만 치료제 개발을 위한 임상규모가 커지고, 개발 기간이 길어지기 때문에 대리지표(surrogate endpoint)를 활용한 가속승인 전략 및 Post-marketing CVOT(Cardiovascular Outcomes Trial) 연계구조, 즉 임상시험 이후 실제환경에서 약물의 안전성과 효과를 지속적으로 추적 관찰하는 것이 중요하다. 이를 위해 웨어러블/원격 모니터링, RWD 연구 등을 활용하여 데이터 정밀화에 따른 개발 비용 및 기간을 절감하는 것도 중요하다.

도표 12. 차세대 CVRM 신약개발의 경쟁력과 임상개발 패러다임 변화



자료: WeGuide,health, DB증권

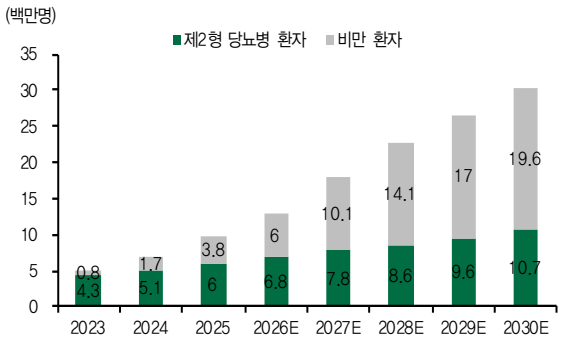
GLP-1 치료제의 적응증 확장에 따른 경제적 가치와 급여 딜레마

올해도 GLP-1 치료제는 출시국가 확대와 제네릭 출시로 성장 전망

2026년 J.P. Morgan 자료에 따르면, GLP-1 시장을 포함한 글로벌 인크레틴 시장은 2030년 2천억 달러 규모로 약 25백만명의 미국인이 GLP-1 작용제를 투약(25년 10백만명)하고 있을 것이라고 전망하였다.

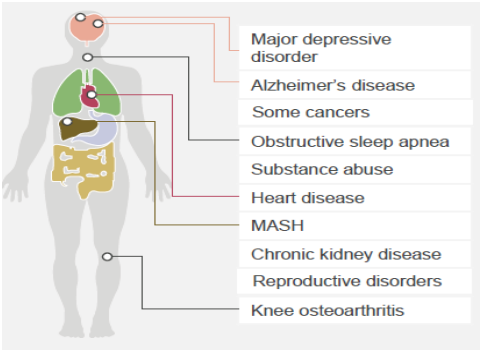
현재는 글로벌 시장에서는 가격과 공급 문제로 인크레틴 약물을 당뇨환자의 7%, 비만환자의 단 2%만이 사용하고 있으나 올해부터 미국 내 약가인하, 제네릭 출시, 그리고 경구제제 출시로 글로벌 처방은 점차 증가될 수 있다. 특히 올해 전 세계 인구의 40%(비만인구의 약 33%)가 거주하는 중국, 인도, 브라질, 캐나다, 튀르키예 등에서 제네릭이 출시가능하다보니 북미뿐 아니라 글로벌 처방 증가를 예상한다. 인크레틴 약물의 성장은 2030-2034년까지 식품과 음료산업 매출의 300-550억 달러 감소로 이어질 것이다. 즉, 칼로리 섭취는 21%, 식료품 지출은 31% 감소할 것으로 전망된다.

도표 13. GLP-1 치료제에 대한 시장전망



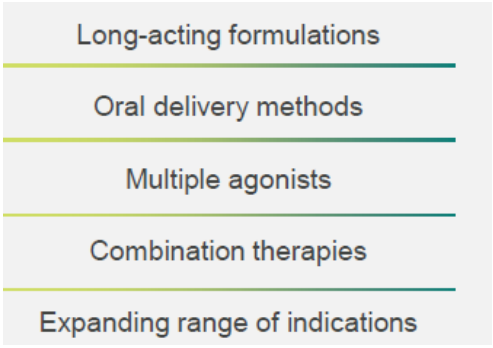
자료: JP Morgan, DB증권

도표 14. 비만환자의 70% 이상은 동반질환 보유



자료: Nature2025, DB증권

도표 15. GLP-1 기반 치료제의 집중하는 기술



자료: DB증권

도표 16. GLP-1 치료제 관련 기업



자료: DB증권

GLP-1 치료제 성장을 위해 필요한 급여

GLP-1 치료제 시장 성장을 위해서 급여가 필요하다. 특히 당뇨, 만성신증질환 등은 질환특성상 장기적인 관리가 필요한 질환으로, 치료제의 가격과 환자의 지불 능력은 치료 지속성을 결정하는 주요 요인이다. CKD는 강연에서 제시된 사례에 따르면, 프랑스에서는 특정 치료 비용이 월 소득의 약 1.6% 수준인 반면, 일부 저소득 국가에서는 약제비가 월 소득의 110%를 초과할 수 있다. 이는 국가별 의료보장 체계와 소득 수준에 따라 치료에 대한 경제적 접근성이 크게 달라질 수 있음을 보여준다.

특히 환자가 약제비를 직접 부담하는 비중이 높은 국가에서는 치료제의 임상적 유효성이 입증되더라도 비용 부담으로 인해 처방을 시작하지 못하거나 투약을 중단할 가능성이 있다. 이 경우 임상시험에서 확인된 치료 효과가 실제 진료 현장에서 충분히 구현되지 못할 수 있다.

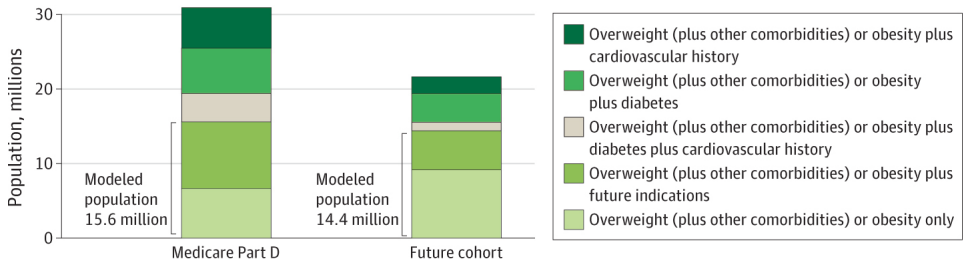
따라서 신약의 실질적인 임상적 · 경제적 가치를 평가할 때는 약물의 효능과 안전성뿐 아니라 약가, 보험급여 범위, 환자 본인부담금 및 장기 치료 지속 가능성을 함께 고려해야 한다. 특히 GLP-1 기반 치료제와 같이 장기간 사용이 필요한 약물에서는 가격 경쟁력과 보험 접근성이 시장 확대의 중요한 변수로 작용할 수 있다. 이러한 이유로 각 국가들은 GLP-1 치료제로 도출되는 임상적 결과에 관심을 가질 수밖에 없다.

2025년 JAMA Health Forum에 발표된 "메디케어의 GLP-1 비만적응증 급여확대시 10년간 재정에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 시뮬레이션 연구"에 대한 논문에 따르면, 비만치료제에 대한 약제비는 659억 달러가 증가되는 반면 비만환자의 동반질환으로 인한 의료비 절감 효과는 182억 달러밖에 이르지 않는다고 보았다. 즉, 비만에 대한 급여혜택을 확대하게 되었을 때 순지출은 477억 달러에 이르면서 정책으로 반영되기 어렵다는 점을 시사하였다.

이외에도 CBO(미국 의회예산처 보고서, Congressional Budget Office)는 메디케어 PartD에 비만치료제 GLP-1을 도입하게 될 경우 9-10년간 순 지출은 약 355억 달러에 이르며, Health Affairs 2024 자료에 따르면 채택률 5-10%에 따라 연간 31~61억 달러 수준의 순지출이 증가한다는 연구가 있다. 이에 따라 미국 CMS는 GLP-1 급여에 대해 유예하거나 제한적 적용으로 신중한 입장을 취하고 있다.

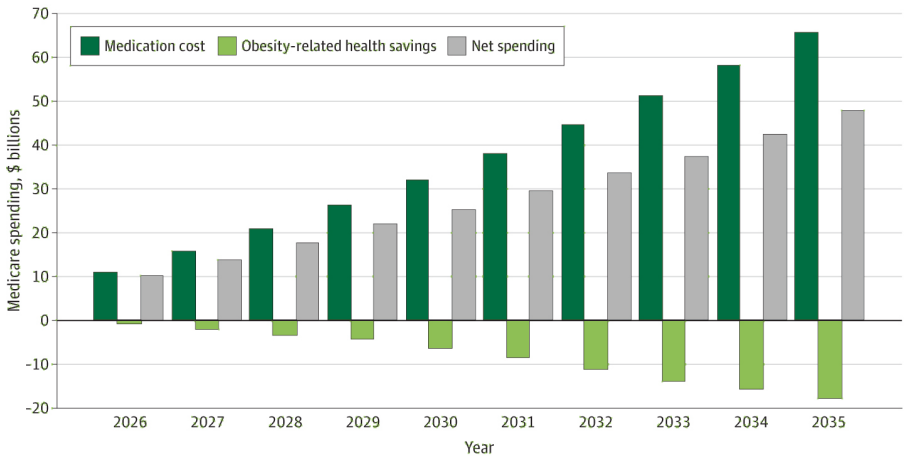
한편 JAMA Health Forum의 연구를 자세히 보면 65세 메디케어 가입자 3천만명을 대상으로 이미 당뇨나 심혈관질환을 진단받아 기존 메디케어에서 GLP-1를 투약하는 환자를 제외한 81.7%에 대해 분석해보니 81.7% 당뇨전단계, 75.5% 고혈압, 67.5% 이상지질혈증 등 높은 비율의 동반질환을 보유하고 있었다. 이때 약제비는 2026년 약 113억 달러에서 2035년 총 182억 달러까지 부담이 증가되는 반면, 체중감량과 임상지표 개선효과가 누적됨에 따라 동기간 10억달러에서 182억 달러까지 절감됨을 확인 할 수 있다고 한다.

도표 17. 메디케어 파트 D 수혜자 및 향후 대상군의 GLP-1 적응증별 유병률



자료: JAMA Health Forum 2025, DB증권
주: 2017~2020년 미국 국민건강영양조사(NHANES) 데이터 활용. 현재 메디케어 파트 D 수혜자 및 향후 대상군(매년 65세 이상으로 진입하는 연령층)을 대표하는 3,000만 명을 포함
과체중(Overweight)은 체질량지수(BMI) 27~29.9kg/m2이면서 최소 1개 이상의 체중 관련 동반질환(당뇨 전단계, 고혈압, 이상지질혈증, 폐쇄성 수면무호흡증, 만성 콩팥병 등)을 보유한 경우로 정의, 비만(Obesity)은 BMI 30kg/m2 이상인 경우로 향후 확대 예상 적응증은 만성 콩팥병(CKD), 폐쇄성 수면무호흡증(OSA), 골관절염(OA)로 한정하였음

도표 18. 비만 치료용 GLP-1 치료제의 메디케어 도입에 따른 10년 재정 영향 분석: 35년까지 적자

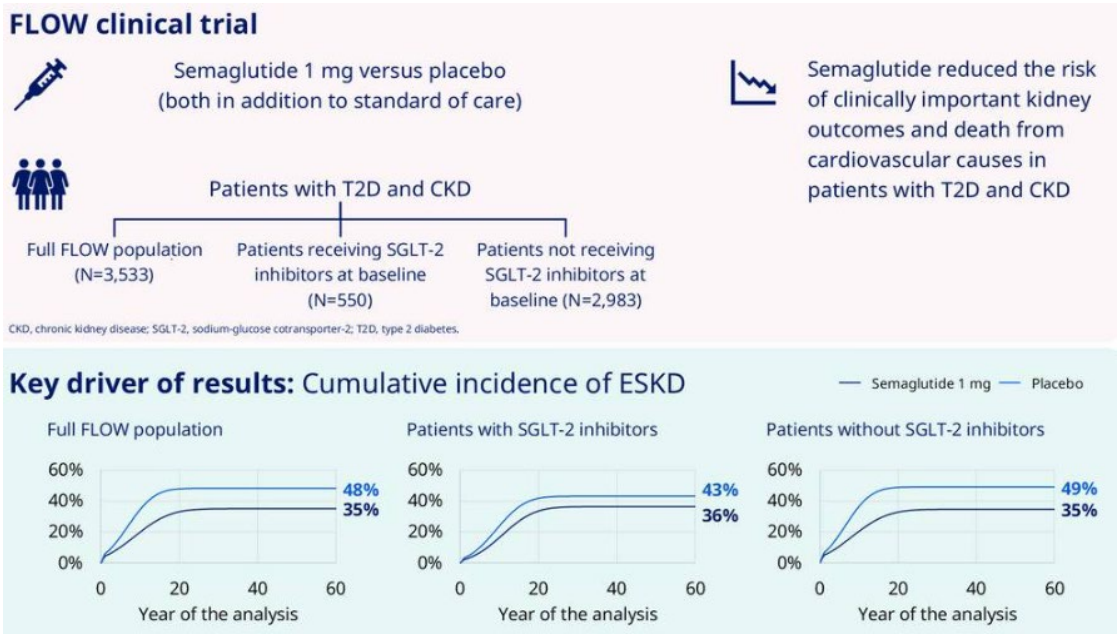


자료: JAMA Health Forum 2025, DB증권

이미 노보 위고비는 SELECT 임상으로 심혈관 질환 위험(MACE) 20% 감소, 당뇨병성 신장질환(창) 진척 지연 효과 입증되고 있다. 그외 비알코올성 지방간염(MASH), 신장질환(CKD), 수면무호흡증(OSA) 등 CVRM 연관 질환으로 확장되고 있다. 캐나다는 약물경제성 평가 시 SELECT 결과를 반영하고, 덴마크는 FLOW 결과를 반영한 바 있다.

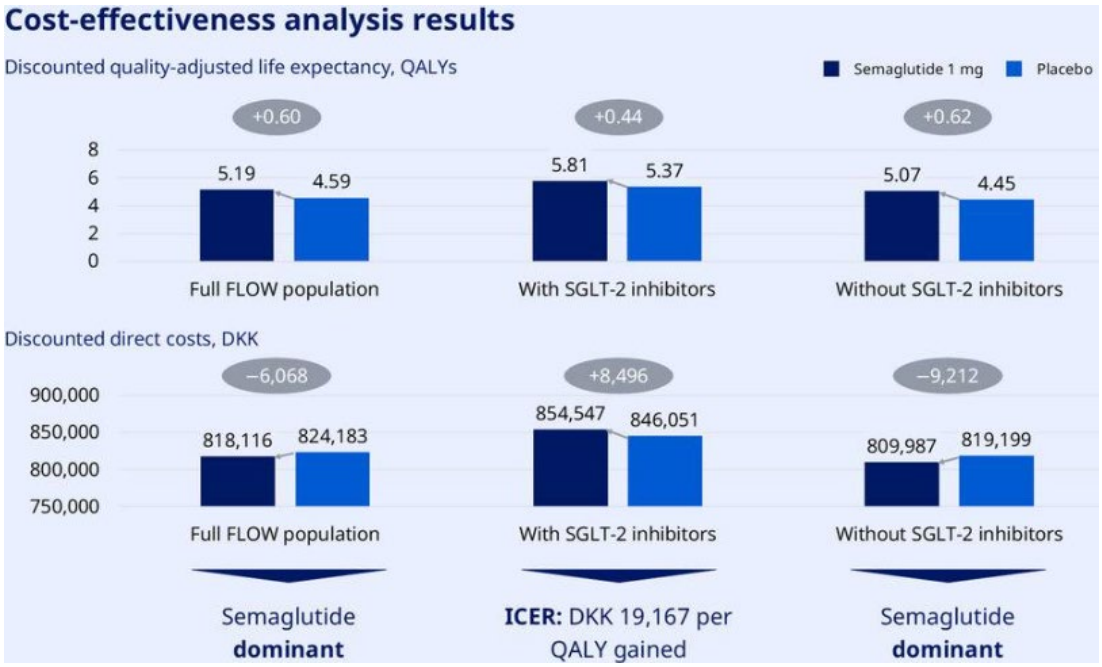
덴마크는 FLOW 임상시험 결과를 기반으로 제2형 당뇨병(T2D)과 만성신장질환(CKD)을 동반한 환자에서 세마글루타이드 1mg을 표준치료(SoC)에 추가했을 때의 장기적인 임상적 · 경제적 효과를 의료업의 입장에서 분석했다. PRIME T2D 모델을 활용해 평생 의료비와 건강수명을 추정한 결과, 세마글루타이드 투여군은 위약군 대비 기대수명 0.73년, 질보정수명(QALY) 0.60년 개선되었으며, 특히 신부전 발생률을 48%에서 35%로 낮추는 것이 주요 기여 요인으로 분석됐다. 이에 따라 환자 1인당 평생 의료비는 6,068 DKK 절감되어 세마글루타이드가 위약 대비 비용과 효과 측면에서 모두 우월한(Dominant) 치료 옵션으로 평가됐다. SGLT-2 억제제 병용 여부에 따른 하위 분석에서도 SGLT-2 억제제 미사용군은 0.62 QALY 개선 및 9,212 DKK의 비용 절감이 나타났으며, 사용군에서도 0.44 QALY 개선과 19,167 DKK/QALY의 ICER로 덴마크의 지불의사금액 기준을 크게 하회했다. 핵심은 GLP-1 치료의 신장 보호 효과가 단순히 eGFR 저하 속도를 늦추는 임상적 이점을 넘어, 장기적으로 신부전 · 투석 발생을 줄여 의료비 절감과 의료경제적 가치로 연결될 수 있다는 점이다.

도표 19. 덴마크 의료시스템에서 분석한 FLOW 임상결과



지료: Cardiovasc Diabetol,2025, DB증권

도표 20. 덴마크 의료시스템에서 분석한 FLOW 임상결과에 따른 경제성 분석



지료: Cardiovasc Diabetol,2025, DB증권

Medicare에서는 비만 치료용 GLP-1을 처음으로 급여하는 GLP-1 Bridge가 7월부터 2027년 말까지 한시적으로 운영된다. 월 순가격 $245(환자 $50, 메디케어 $195)로 제조사와 합의했고, Part D 보험사를 거치지 않고 CMS가 직접 처리하기로 하였다. 연 재정 부담은 1.1백만명 가입 기준 $1.3~2.6B 수준으로, 2024년 CBO 추정의 1인당 비용($5,600)보다 약 58% 낮다. 대상자는 PartD(T2D, 중등도 이상 수면무호흡, MASH)로 급여가 되지 않으면서, 1)BMI ≥35, 2)BMI ≥30에 HFpEF, 조절 안 되는 고혈압, CKD 3a 이상 중 하나, 3)BMI ≥27에 전당뇨, 심근경색 · 뇌졸중 병력, 증상성 말초동맥질환 중 하나일 때 급여가 가능하다.

Bridge에서 적용되는 $245는 TrumpRx 현금가 약 $346~350보다 약 30% 낮으며, 2027년 1월부터는 IRA 협상가(MFP)가 적용된다. 특히 세미글루타이드(Ozempic · Wegovy · Rybelsus)는 $274로, 정가 대비 71% 인하예정이다. 메디케어 가입자에게만 적용된다.

국내에서는 당뇨병 급여 확대가 우선적인 시장 성장 경로가 될 가능성이 높다. 2026년 2월 semaglutide의 T2D 급여가 신설됐으나 비만 목적의 공보험 급여 및 CKD · CVD 환자에 대한 별도 급여 확대는 여전히 정책적 과제로 남아 있다. 향후 임상 근거가 축적되고 가이드라인이 변화할수록 GLP-1의 처방 범위 확대 가능성은 높아질 수 있으나, 실제 급여 환자 수와 시장 규모는 별도의 보험정책 변화가 확인된 이후 반영할 필요가 있다.

따라서 신약의 실질적인 임상적 · 경제적 가치를 평가할 때는 약물의 효능과 안전성뿐 아니라 약가, 보험급여 범위, 환자 본인부담금 및 장기 치료 지속 가능성을 함께 고려해야 한다. 특히 GLP-1 기반 치료제와 같이 장기간 사용이 필요한 약물에서는 가격 경쟁력과 보험 접근성이 시장 확대의 중요한 변수로 작용할 수 있다.

글로벌 기업들의 비만/대사질환 확장을 위한 노력

노보, 인크레틴과 비인크레틴 기전 확보로 포트폴리와 확대

노보 노디스크는 세마글루타이드 중심의 시장 지배력을 유지하는 동시에, 다중 수용체 작용제와 경구용 저분자화합물, 비인크레틴 기전으로 파이프라인을 확장하고 있다. 2025년 3월 중국 유나이티드바이오테크놀로지(United Biotechnology)로부터 GLP-1 · GIP · 글루카곤 삼중 작용제인 UBT251의 중국 본토 · 홍콩 · 마카오 · 대만을 제외한 글로벌 개발 · 상업화 권리를 확보했다. 해당 후보물질은 2026년 2월 발표된 중국 임상 2상에서 24주 투여 후 최대 19.7%의 평균 체중 감소를 기록하며 차세대 비만치료제로서의 가능성을 제시했다. 같은 해 5월에는 Septerna와 약 22억달러 규모의 협력 계약을 체결해 GLP-1 · GIP · 글루카곤 수용체를 표적으로 하는 경구용 저분자화합물 4개 프로그램을 추진하고 있으며, Lexicon으로부터는 비인크레틴 계열의 경구용 후보물질 LX9851을 도입했다.

MASH 치료제 개발을 위해 Akero Therapeutics와 FGF21 유사체 에프룩시퍼민(efruxifermin)을 확보하는 등, 비만 자체의 체중감량 효과를 넘어 대사질환 동반질환까지 치료 영역을 넓히고 있다. 이는 기존 GLP-1 중심의 경쟁력을 강화하는 한편, 투여 편의성과 체중감량 유지, 대사질환 병용치료 등 차세대 시장의 요구에 대응하려는 전략으로 해석된다.

도표 21. 노보의 비만/대사질환 치료제 확장을 위한 기술계약

(단위: 백만달러)

일자	회사	딜 종류	파이프라인	타깃	적응증	임상 단계	계약 규모
2026-09	Orbis Medicines	LI(플랫폼)	nGen AI macrocycle 치료제 발굴	심혈관대사 타깃 (비공개)	심혈관대사	Discovery	1,400
2026-09	Kallyope	LI	K-554 (펩타이드, IND 신청 가능) + 저분자 2종	non-incretin (비공개)	비만	IND 신청 가능 / 전임상	
2026-09	Nanexa	LI(플랫폼)	PharmaShell (ALD 무기물 코팅 플랫폼)		비만, T2D, 심혈관대사	플랫폼	11.65억 유로
2026-02	Vivtex	LI(플랫폼)	경구용 비만 및 당뇨병 치료제, 위장관 스크리닝 및 제형 플랫폼		비만, 당뇨 관련 동반질환	플랫폼	2,100
2025-10	Akero Therapeutics	M&A	Efruxifermin	FGF21	MASH F2-F3, 대상성 간경변 F4	Ph3	5,200
2025-08	Replicate Bioscience	LI(플랫폼)	srRNA 플랫폼	비공개	비만, T2D, 심혈관대사	Discovery	550
2025-06	Deep Apple Therapeutics	LI(플랫폼)	GPCR 표적 저분자화합물 치료제	non-incretin GPCR	비만, 심혈관대사	Discovery	812
2025-05	Septerna	LI(후보물질까지는 공동연구개발)	GPCR에 대한 저분자 치료제 개발 프로그램 4개	GLP-1, GIP, GCG 수용체 포함 하나 이상의 GPCR 등	비만, T2D, 심혈관대사	Discovery	2,200
2025-03	The United Laboratories	LI	UBT251	GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제	비만, 제2형 당뇨병	임상 1b상 (중국)	2,000
2025-03	Lexicon Pharmaceuticals	LI	LX9851	ACSL5 저해제 (non-incretin)	비만, 심혈관대사	전임상	1,075
2023-08	Embark Biotech	M&A	β-아드레날린성 GPCR 작용제	GPR3	비만 및 당뇨	전임상	471

자료: DB증권

일라이 릴리, 체중감량 효과의 극대화

일라이 릴리는 터제파타이드(GLP-1/GIP 이중 작용제)를 기반으로 한 시장 경쟁력을 바탕으로, 삼중 작용제 · 경구용 치료제 · 근육량 보존 기술을 결합해 비만치료의 차별화를 추진하고 있다. 자체 개발 중인 레타트루타이드(retatrutide)는 GLP-1 · GIP · 글루카곤 수용체를 동시에 활성화하는 삼중 작용제로, 기존 인크레틴 치료제 대비 추가적인 체중감량와 차별화된 적응증 확장을 위해 후기 임상을 진행하고 있다.

경구용 저분자 GLP-1 작용제 오르포글리프론(orforglipron)과 아밀린 계열의 엘로랄린타이드(eloralintide)도 개발하며 투여 편의성과 작용기전 다변화를 모색하고 있다. 특히 2023년 최대 19.25억달러 규모로 Versanis Bio를 인수해 확보한 비마그루맙(bimagrumab)은 액티빈 수용체를 차단하는 항체로, 지방량 감소와 근육량 보존을 동시에 추구하는 접근법이다. 이는 GLP-1 계열 치료제의 체중감량 과정에서 발생할 수 있는 제지방량 감소 문제를 보완하고, 단순 체중 감소를 넘어 체성분 개선과 장기적인 대사 건강을 차별화 요소로 삼으려는 전략이다. 즉, 릴리는 기존 인크레틴의 효능을 높이는 동시에 근육 보존, 경구 투여, 심혈관 · 신장 등 동반질환으로 경쟁 범위를 확장하고 있다.

일라이릴리는 레타트루타이드에 대해서 내년 1분기에 신약허가신청서(BLA)를 미국 FDA에 제출할 계획이다. 이외에도 비만 및 체중관련질환을 하나 이상 동반한 과체중 환자, 2형당뇨병, 무릎골관절염(Knee OA), 중등도에서 중증의 폐쇄성수면무호흡증(OSA), 만성 허리통증(CLBP), 심혈관 및 신장질환, 대사기능장애 관련 지방간(MASLD) 환자를 대상으로 하는 여러 임상3상을 진행하고 있다.

도표 22. 25, 26년 국내기업과 일라이릴리 계약 체결 사례 (단위: 백만달러)

일자	회사	파이프라인	적응증	계약 당시 임상 단계	계약 규모
2025.02.10	올릭스	OLX702A	MASH/비만	임상 1상	630
2025.05.15	알지노믹스	RNA 편집 치료제	유전성 난청질환		1,300
2025.11.12	에이비엘바이오	Grabody-B 플랫폼	CNS, 비만, 근육질환		2,562
2026.06.01	한미약품	소네페글루타이드	단장증후군	임상 2상	1,260
합계					**5,752**

자료: Eli Lilly, DB증권

도표 23. 일라이릴리 대사질환 사업부 확장을 위한 기업 제휴

(단위: 백만달러)

발표일	파트너	딜 유형	자산 / 플랫폼	타깃 / 기전	적응증	계약 시점 단계	총 규모
2026-06	한미약품	LI	소네펩글루타이드 (HM15912)	GLP-2 유사체	단장증후군	임상 2상	1,260
2026-02	CSL	LI	Clazakizumab	IL-6	심혈관 위험 감소 (ESKD 관련 CV는 CSL 보유)	임상 2b상	
2026-01	Nimbus Therapeutics	LI(플랫폼)	계산화학 및 구조 기반 약물 설계	비공개	비만, 대사질환	Discovery	1,355
2026-01	Ventyx Biosciences	M&A	VTX3232 외	NLRP3 억제	심혈관 염증, 심혈관대사 (+신경 · 면역)	임상 2상	1,200
2025-11	SanegeneBio	LI(플랫폼)	LEAD 간외 RNAi 전달 플랫폼	대사 타깃 (지방 · 근육, 비공개)	대사질환	Discovery	1,200
2025-08	Superluminal Medicines	LI(플랫폼)	AI 구조기반 GPCR 플랫폼	GPCR (첫 프로그램 MC4R 작용제, 2026 FIH)	비만, 심혈관대사	Discovery	1,300
2025-06	Camurus	LI(플랫폼)	FluidCrystal (약물전달 플랫폼)	incretin 계열 치료제 최대 4종에 적용 가능	비만, T2D, 심혈관대사	플랫폼	870
2025-06	Juvena Therapeutics	LI(플랫폼)	AI 기반 단백질 발굴 플랫폼	근육 타깃 (복수)	비만 (근육 보존)	Discovery	650
2025-06	Verve Therapeutics	M&A	VERVE-102	PCSK9	In-vivo 염기 편집	임상 1b상	1,300
2025-02	올릭스	LI	OLX75016 (OLX702A)	01-Mar	MASH, 비만, 심혈관대사	임상 1상	630
2023-07	Versanis Bio	M&A	Bimagrumab	ActRII (근육 보존)	비만	임상 2상	1,925

자료: Eli Lilly, DB증권

로슈, 카모트 인수와 아밀린 병용계약을 통해 CVRM 시장 진입

로슈는 비만치료제 시장 후발주자로서 자체 개발만으로 경쟁력을 확보하기보다, 외부 기술 도입과 대규모 인수를 통해 인크레틴 및 비인크레틴 기전을 동시에 확보하고 병용요법 중심의 포트폴리오를 구축하고 있다. 2023년 카르모트 테라퓨틱스(Carmot Therapeutics)를 선급금 27억달러와 최대 4억달러의 추가 마일스톤 조건으로 인수하면서, 주 1회 투여하는 GLP-1/GIP 이중 작용제 CT-388, 경구용 GLP-1 저분자 작용제 CT-996, 제1형 당뇨병 환자를 대상으로 하는 CT-868 등 임상 단계 인크레틴 파이프라인을 확보했다. 이어 2025년 3월에는 Zealand Pharma와 최대 53억달러 규모의 공동개발 · 상업화 계약을 체결해 장기지속형 아밀린 유사체 페트렐린타이드(petrelintide)를 도입했다. 페트렐린타이드는 단독요법뿐 아니라 로슈의 CT-388과 고정용량 복합제(FDC)로 개발될 수 있어, GLP-1/GIP와 아밀린이라는 서로 다른 식욕 · 포만감 조절 기전을 결합해 체중감량 효과와 내약성을 개선하는 전략적 의미가 있다. 미국 · 유럽에서는 양사가 공동 상업화하고, 그 외 지역에서는 로슈가 독점 상업화 권리를 확보하는 구조다. 이러한 일련의 계약은 로슈가 비만을 단일 체중감량 시장이 아닌 심혈관 · 신장 · 대사질환(CVRM)을 포괄하는 장기 성장 영역으로 인식하고 있음을 보여준다

도표 24. 로슈의 비만/대사질환 관련 기술 도입 및 기업 제휴 계약

(단위: 백만달러)

일자	회사	계약 종류	플랫폼	타겟	적응증	임상 단계	계약규모
2026-10	Rona therapeutics	LI	RNA 간섭(RNAi) 기반 비만 · 대사질환 치료제	ALK7	비만, 대사질환	미공개	1,060
2026-09	Atavistik Bio	LI(플랫폼)	대사-단백질 스크리닝 및 알로스테릭 치료제 발굴 플랫폼	알로스테릭 결합부위 (비공개)	CVRM	전임상	1,970
2026-08	한미약품	LI	HM17321	UCN2 유사체 (CRF2R 작용제), non-incretin	비만 (근육량 보존), T2D, 심혈관	임상 1상	2,300
2025-09	89bio	M&A	Pegozafermin	FGF21	MASH F2-F4, 중증 고중성지방혈증(SHTG)	임상 3상	3,500
2025-03	Zealand Pharma	공동개발 · 공동판매	Petrelintide (+ petrelintide/CT-388 복합제 개발 방안 검토)	Amylin 유사체	비만, T2D	임상 2b상	5,300
2023-12	Carmot Therapeutics	M&A	Enicepatide (CT-388), CT-996, CT-868	GLP-1/GIP 이중 (CT-388), 경구 GLP-1 (CT-996)	비만, T2D, T1D 보조	임상 1/2상	3,100
2023-07	Alnylam	공동개발 · 공동판매	Zilebesiran	Angiotensinogen (AGT)	고위험 고혈압	임상 2상	2,800

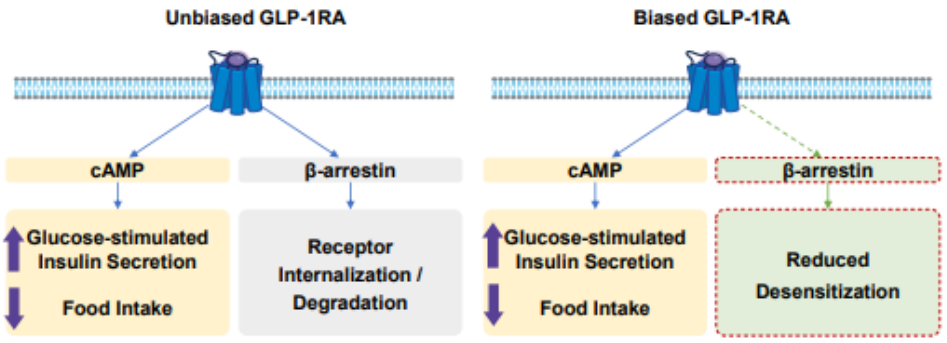
자료: Roche, DB증권

화이자, 멧세라 인수를 통해 cAMP biased GLP-1에 집중

화이자는 중국법인이 사이윈드 에크로글로타이드로부터 약 최대 4.95억 달러에 판권을 확보하면서 biased cAMP GLP-1 RA에 대해 관심을 갖기 시작하였다. 2025년 11월 약 70억달러 규모로 멧세라(Metsera) 인수를 완료하며 비만 · 심혈관대사질환 파이프라인을 확보했다. 핵심 자산인 MET-097i(PF-08653944, berobenatide)는 GLP-1 수용체의 세포 내 신호전달 경로 중 cAMP를 활성화하는 G단백질 신호는 유지하면서 β -arrestin의 동원은 최소화하도록 설계된 편향 작용제(biased agonist)다. 이는 수용체 내재화와 탈감작을 줄여 신호전달을 지속시키고, 약효 및 투여 간격을 개선할 수 있다는 가설에 기반한다. 여기에 멧세라의 HALO 지질화 기술을 적용해 반감기를 연장했으며, 월 1회 투여가 가능한 초장기 지속형 GLP-1 치료제를 목표로 한다.

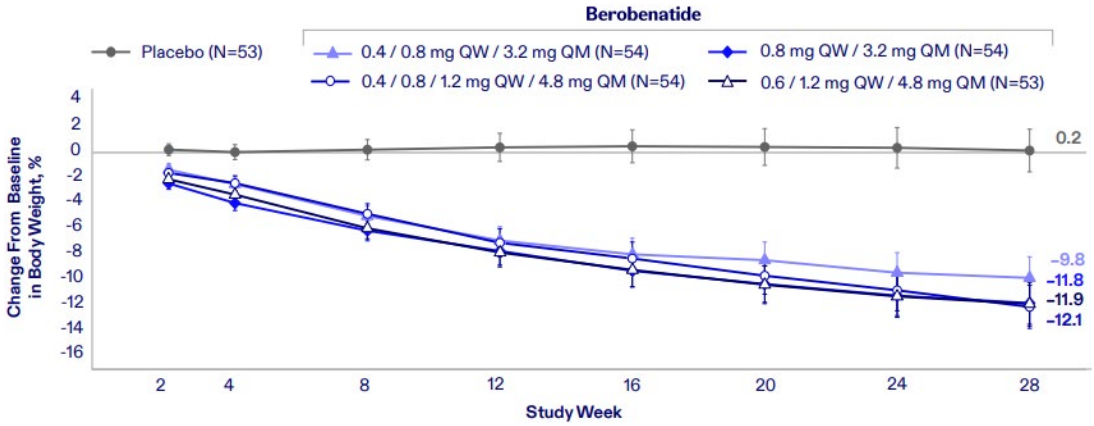
2026년 ADA에서 공개된 VESPER-3 임상 2b상에서는 28주 투여 후 월 1회 4.8mg 투여군에서 위약 보정 최대 12.3%의 체중감량을 달성했으며, VESPER-1 연장시험에서도 고용량 주 1회 투여 시 32주간 체중감량이 지속되는 결과를 확인했다. 화이자는 VESPER-4 · 5 · 6 등 3상 임상과 비만 관련 동반질환 임상을 포함해 2026년 10개 3상 프로그램을 추진하고, 아밀린 유사체 MET-233i와의 월 1회 병용요법까지 개발 범위를 확대하고 있다. 화이자의 접근은 기존 GLP-1 치료제의 주 1회 투여 및 수용체 신호전달 방식에서 차별화를 시도한다는 점에서 의미가 있으며, 향후 경쟁력은 cAMP 편향 작용의 임상적 유효성 · 내약성 개선 여부와 월 1회 투여의 실제 체중감량 지속성에 의해 결정될 전망이다.

도표 25. Unboased vs. biased cAMP GLP-1RA



자료: 화이자, DB증권

도표 26. 화이자 VESPER-3 임상결과: 주1회 투여로 내약성 확보 후 월 1회 투여로 전환한 결과



자료: ADA2026, DB증권

도표 27. 노보 경구용 세마글루타이드 vs. 릴리 오포글리프론

DDI/population use	oral semaglutide[3]	orforglipron[4]
Strong CYP3A4 inhibitors	● No interaction	● **Dose restriction*** **Avoid** concomitant use of CYP3A4 + OATP1B inhibitors
Strong CYP3A4 inducers	● No interaction	● **Avoid** concomitant use
Moderate CYP3A4 inducers	● No interaction	● **Monitor**
Simvastatin	● No interaction	● Dose **restriction**[†]
Levothyroxine	● **Monitor**	● No interaction
Oral contraceptives guidance	● No interaction	● Use **non-oral** or **barrier** method[‡]
Severe hepatic impairment	● No significant differences	● **Not recommended**

자료: ADA2026, DB증권

Ⅲ. 신장질환 치료 패러다임의 변화와 새로운 시장 기회

만성신장질환 치료 시장: 보존적 치료에서 질환 진행 억제로

만성신장질환은 신장의 사구체 미세혈관이 손상되거나 퇴화되면 사구체 여과 속도(GFR, Glomerular Filtration Rate)가 감소하고, 단백뇨(Proteinuria) 증상이 점차 심각해지는 상태를 말한다. 다양한 원인으로 신장이 손상되어 기능이 3개월 이상 지속적으로 감소한 상태로 사구체여과율(eGFR)이 60mL/min/1.73㎡ 미만으로 감소하거나 단백뇨 · 혈뇨 · 영상학적 이상 등 신장 구조의 손상이 3개월 이상 나타날 때 진단한다. 표준치료제로는 혈압을 낮추는 약물(ARB, ACEI), 혈당을 소변으로 배출하는 약물(SGLT-2저해제), 신장섬유화와 염증을 억제하는 약물(MRA), GLP-1 작용제 등이 있다.

당뇨병성 신증은 당뇨환자의 주요 사망요인으로 아주 서서히 진행되기 때문에 진단 및 치료제 개발이 중요하다. 일반적으로 당뇨병을 진단받고 10~15년 지나면 전체 환자의 1/3 정도에서 단백뇨가 발생하며, 초기 사구체여과율의 증가 → 30~300 mg/day의 미세 단백뇨 → 부종 → 만성 신부전증 → 요독증으로 진행된다. 60세 이상 당뇨병 환자 중 75%가 당뇨병성 신증 환자임을 고려할 때 전문치료제의 개발이 절실하다.

당뇨병성 신증은 각종 세포 내 신호전달 경로와 TGF-β (전환성장인자 베타, Transforming growth factor-beta) 등의 여러 사이토카인이 관여한다. 당뇨병성 신증이 악화되면 세포외기질의 축적으로 인한 신섬유화로 말기 신부전으로 진행되고 투석치료를 받는 만성신부전(말기 신질환) 환자 중 약 40%가 당뇨에 있다.

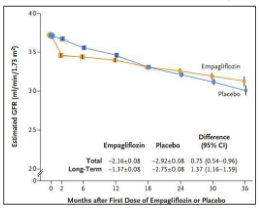
만성신장질환의 치료는 안지오텐신 수용체 차단제(ARB), 알도스테론 길항제, 레닌차단제, 안지오텐신 전환 효소 2 억제제(ACE-2) 등 고혈압, 고혈당 치료제 등 보전적 치료가 대부분이다. 그러나 고칼륨혈증과 심혈관질환 악화의 부작용을 발생시킴에 따라 이러한 합병증을 극복하고자 하는 새로운 치료제 개발에 대한 요구가 늘고 있다. 그 중 당뇨병 치료제인 SGLT-2 억제제(Sodium Glucose Co-Transporter 2, 신장에서 포도당이 재흡수되는 것을 억제하여 소변으로 포도. 당이 배출되도록 하는 기전)의 긍정적인 심혈관 및 신기능 개선이 입증되어 사용되고 있다.

도표 28. 당뇨병성 신증 관련 치료제 현황

• 기존에 사용되던 약물 : 고혈압, 당뇨 치료제 등

구분	성분명	특징	한계[1,2,3,4]
RAAS Inhibitor (고혈압 치료제)	Losartan, Telmisartan 등	• 혈관수축 억제를 통한 사구체 내압 감소 • 혈압 조절 및 단백뇨 감소	• 장기 사용 시 고칼륨혈증, 신기능 저하 우려 • 혈역학적 변화에 따른 초기 eGFR 감소(Initial dip) • eGFR 감소 지연에 그침
SGLT-2 Inhibitor (혈당 강하제)	Empagliflozin, Dapagliflozin 등	• 세뇨관에서 포도당 재흡수 억제 • 혈당 강하 효과와 함께 신장 보호 효과 입증	• 혈역학적 변화에 따른 초기 eGFR 감소(Initial dip) • eGFR 감소 지연에 그침

SGLT-2 Inhibitor의 초기 eGFR 감소(Initial dip)

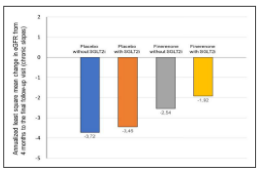


• 당뇨병성 신증 타깃 약물 : 바이엘 케렌디아 (2021)

구분	성분명 (상품명)	특징	한계[1,2,3,4]
nsMRA	Finerenone (케렌디아)	• 신장의 나트륨 흡수 저해 • 염증 및 섬유화 억제를 통한 신장 손상 억제	• 고칼륨혈증 발생 가능성 높아 칼륨 수치 모니터링 필요하고, 고혈압 치료제와 함께 쓰기 어려움 • eGFR 감소 지연에 그침

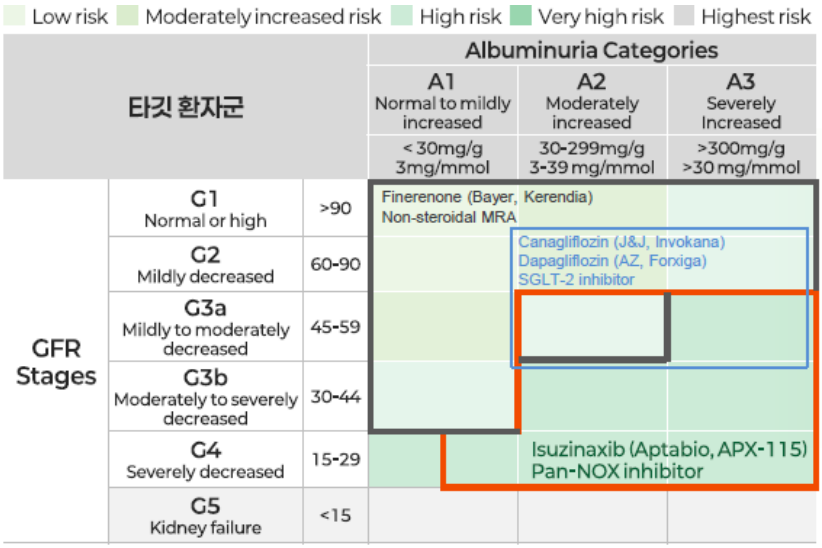
※ 그 외 GLP-1 Receptor agonist 등이 사용되기 시작함

Finerenone(케렌디아) 임상3상에서 SGLT-2 Inhibitor와 병용 시에도 eGFR 감소 지연에 그침[4]



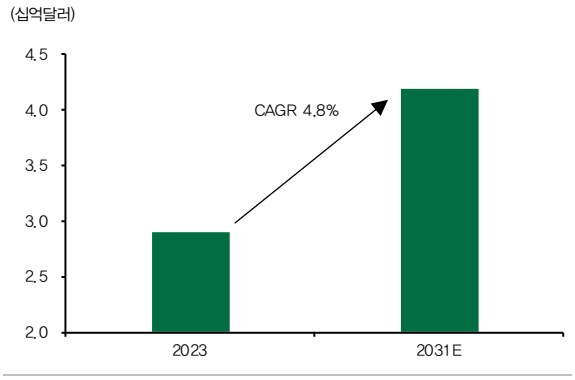
자료: 큐리클, DB증권

도표 29. uACR과 GFR 지표로 선택하는 당뇨병성신증 치료제



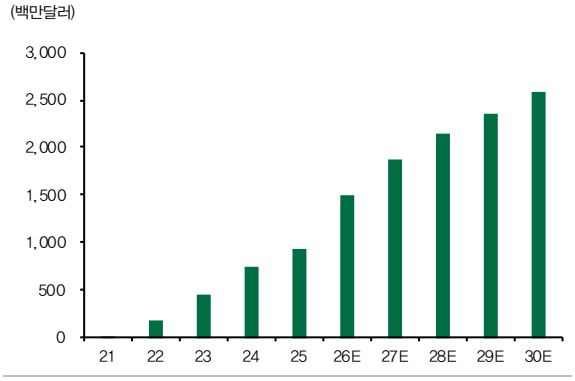
자료: 압타바이오, DB증권

도표 30. 당뇨병성 신증 치료제 시장 전망



자료: 압타바이오, 산업데이터, DB증권

도표 31. 케렌디아 글로벌 매출 추이 및 전망



자료: 큐라클, 산업데이터, DB증권

도표 32. 주요 만성신장질환 치료제 임상결과 비교

약물	임상 디자인	임상적 유효성	주요 부작용
지보텐탄+다파글리플로진 (ZENITH-CKD, 2b상, n=447)	다파글리플로진 단독 대비 추가효과, 12주 UACR	고용량군: 단독 대비 보정시 -52.5% (90% CI -42.5~-23.5, p<0.001) 저용량군 -47.7%(p=0.002)	부종: 고용량군 18.4%(33/179) vs 단독 7.9%(14/177) 저용량군 8.8%(8/91)로 대조군과 비슷
피네레논 (FIDELIO-DKD, 3상 확증, n=5,734, 중앙추적 2.6년)	CV · 신장 복합 경성 임상결과	신장 진행 위험 HR 0.82(95% CI 0.73-0.93) CV 사건 HR 0.86(0.75-0.99). NNT 약 31명/2.6년으로 신부전 진행 1건 예방	고칼륨혈증: 18.3% vs 9.0%(위약, FIDELIO-DKD) / FIGARO-DKD(경증 환자군)에서는 10.8% vs 5.3%로 상대적으로 낮음. 이로 인한 투약 중단은 2.3% vs 0.9%로 낮은 편 사망 사례는 없었음
세마글루타이드 (FLOW, 3상 확증, n=3,533, 중앙추적 3.4년)	1차 복합 신장 · 심혈관 경성 임상결과	1차 평가변수 24% 위험 감소(HR 0.76, 95% CI 0.66-0.88), 사건 발생률 18.7% vs 23.2%(위약). eGFR 연간 감소 기울기 1.16 mL/min/1.73m² 개선, UACR 38% 감소, 전체 사망 위험 20% 감소	중대이상반응은 오히려 위약보다 적음(49.6% vs 53.8%). 다만 GLP-1 계열 특유의 오심 · 구토 등 위장관계 부작용은 별도로 보고
큐라클 CU01 (국내 2b상 완료, CSR 수령)	대조군 대비 12주 UACR 변화량	저용량(240mg): 대조군 대비 -21.45% / 고용량(360mg): -22.21%(통계적 유의) 2a상에서 eGFR이 12주 만에 60.60→64.40%(+3.8)로 개선되는 신호도 관찰	우수한 내약성 확인
압타바이오 APX-115 (유럽 2a상 완료, 국내 2b상 진행중)	위약 대비 12주 UACR 변화율	전체 환자 -20%(2021년 톱라인, 유의성 미확립) / 중등도 이상(eGFR<45) 환자군에서는 위약 대비 약 -50%(P<0.05)로 서브그룹 한정 유의	우수한 내약성 확인 2b상(186명) 중간데이터는 2H26년 발표 예정

자료: clinicaltrial. gov, DB증권

도표 33. 만성 신장질환에 대한 기술계약 사례 (단위: 억 달러)

인수 기업	일자	피인수기업	파이프라인	작용 기전	계약 규모
Akebia	2021	Cyclerion	Praliciguat	경구 sGC 자극제	L/O, 5.85
AstraZeneca	2023.01	CinCor	Baxdrostat	SGLT2 억제제 병용	M&A, 18
Novartis	2023.06	Chinook Therapeutics	Astrasentan, Zigakibart	최초의 선택적 ETAR 길항제, 항-APRIL 단일클론항체	M&A, 35
Novartis	2025.05	Regulus Therapeutics	Farabursen	miR-17 타깃, 올리고뉴클레오타이드 기반 약물	M&A 계약금 8, CVR 9
Novartis	2025.10	Avidity Biosciences	신경근육질환	RNA 타깃 전달 플랫폼 AOC 기술	M&A, 120
Vertex	2024.04	Alpine Immune Sciences	Povetacicept	BAFF와 APRIL 사이토카인 2중, IgA 신증 2상에서 최고 수준의 효능 가능성	M&A, 49
Asahi Kasei	2024.05	Calliditas Therapeutics	Tarpeyo, Setanaxib	IgA 신증 치료제, NOX1/4 저해제	M&A, 11
Asahi Kasei	2019.11	Veloxis Pharmaceuticals	Envarsus XR	신장이식 환자 면역반응 억제제	M&A, 13
Biogen	2026.03	Apellis	APL-3007	siRNA 치료제, 지리위축 환자 Syfovre 병용 투여	M&A, 56

자료: 각 사, DB증권

당뇨병성 신증에서 IgA 신증까지: 질환 기전별 표적치료제 경쟁 확대

GLP-1 작용제의 확장으로 만성신증질환에 대한 글로벌 빅파마의 관심은 지속적으로 나타났다. 다만 일반적인 당뇨 합병증에 따른 신장질환보다는 IgA 신증이라는 자가면역성 신질환에 더욱 관심이 많다. IgA신병증(IgAN) 치료 시장은 RAS 억제제와 SGLT2 억제제 등 보존적 치료에서 질환의 발병 기전을 직접 억제하는 표적치료제로 진화하고 있다. 특히 2025년 개정 KDIGO 가이드라인이 단백뇨를 0.5g/day 미만, 가능하면 0.3g/day 미만으로 관리하도록 권고하면서 병인 조절 치료제의 중요성이 확대되고 있다. Tarpeyo, Filspari, Fabhalta, Vanrafia에 이어 최근에는 B세포 활성화 및 항체 생성에 관여하는 BAFF/APRIL 경로 억제제가 차세대 치료제로 부상했다. 2025년 11월 Otsuka의 APRIL 단일 억제제 Voyxact가 가속승인을 받은 데 이어 2026년 7월 Vera Therapeutics의 BAFF/APRIL 이중 억제제 Trutakna(atacicept)가 승인되었으며, 104주 eGFR 기울기 개선 및 신질환 진행 위험 감소 데이터까지 확보하면서 경쟁의 기준이 단백뇨 감소에서 장기 신기능 보존으로 확대되고 있다.

도표 34. IgAN 주요 치료제 경쟁현황

구분	Voyxact	Trutakna	포베타시셉트
개발사	Otsuka	Vera Therapeutics	Vertex
작용기전	APRIL 단일 억제	BAFF/APRIL 이중 억제	BAFF/APRIL 이중 억제
투여방식	피하주사	피하주사	피하주사
투여주기	4주 1회	주 1회	4주 1회
주요 임상	3상	3상	3상 RAINIER
단백뇨 감소	51.2%	임상별 확인 필요	52.00%
주요 차별점	APRIL 선택적 억제	장기 eGFR 데이터	BAFF/APRIL 이중 억제, 투여 편의성
개발 현황	가속승인	가속승인	FDA 가속승인 심사
주요 투자 포인트	장기 신기능 보존	eGFR 개선의 지속성	허가 및 104주 eGFR 결과

자료: 산업자료, DB증권

버텍스, 낭포성섬유증(CF) 치료제 기반 위에 신규 사업축 확대 중

버텍스(Vertex)는 낭포성섬유증(CF) 치료제를 기반으로 2025년 120억 달러의 매출을 달성한 기업으로, 기존 CF 사업의 안정적인 현금흐름을 바탕으로 신규 성장동력을 확보하고 있다. 2026년 2분기 매출은 33.3억 달러(+12% YoY)로 연간 가이던스를 상향했으며, Alyftrek의 성장과 함께 Casgevy, 비마약성 진통제 Journavx 등 비CF 사업의 매출 기여도 확대되고 있다. 또한 약 100억 달러 규모의 Crinetics 인수를 통해 내분비질환 사업까지 확보하면서 사업 영역을 확장했다. 신장질환 분야에서는 2024년 약 49억 달러에 인수한 Alpine Immune Sciences의 포베타시셉트를 중심으로 IgAN 시장 진입을 추진하고 있으며, APOL1 억제제 이낙사플린과 ADPKD 치료제 VX-407을 후속 파이프라인으로 확보했다. 이에 따라 신장질환은 기존 CF, 유전자치료제, 통증 치료제에 이은 버텍스의 주요 성장축으로 자리매김할 전망이다.

버텍스의 신장질환 파이프라인 중 가장 앞선 포베타시셉트는 BAFF/APRIL 이중 억제 융합단백질로, 2026년 11월 30일 FDA 가속승인 여부가 결정될 예정이다. ASN Kidney Week 2026에서 발표된 3상 RAINIER 중간분석에서는 36주차 단백뇨가 기저치 대비 52.0% 감소해 위약군(-4.3%) 대비 49.8%의 개선 효과를 나타냈으며, 혈청 Gd-IgA1도 위약 대비 79.3% 감소했다. 4주 1회 피하주사라는 투여 편의성과 우수한 단백뇨 감소 효과는 차별화 요인이다. 다만 경쟁약 Trutakna가 이미 104주 eGFR 개선 데이터를 확보한 만큼, 포베타시셉트 역시 향후 장기 신기능 보존 효과를 입증해야 한다. 후속 파이프라인인 이낙사플린은 APOL1을 직접 억제하는 경구용 AMKD 치료제로 2027년 초 3상 AMPLITUDE 중간분석이 예정되어 있으며, VX-407은 일부 PKD1 변이 환자를 대상으로 PC1 단백질의 접힘 결함을 교정하는 ADPKD 치료제다. 결국 단기적으로는 포베타시셉트의 허가와 초기 상업화, 중기적으로는 이낙사플린의 임상 결과, 장기적으로는 VX-407의 임상적 유효성 입증이 버텍스 신장 프랜차이즈의 가치 상승을 결정할 전망이다.

도표 35. RAINIER 버텍스 포베타시셉트 임상 3상 주요 결과

평가변수	포베타시셉트	위약	위약 대비
UPCR 변화율 (36주)	-52.0%	-4.3%	-49.8%
KDIGO 목표 UPCR 0.5g/g 미만 도달률	42.2%	6.2%	-
Gd-IgA1 변화율	-77.4%	9.1%	-79.3%
혈뇨 소실률	85.1%	23.4%	-
중대한 이상반응	3.0%	4.3%	-

자료: 버텍스, DB증권

도표 36. 버텍스 주요 파이프라인 및 개발 일정

파이프라인	타깃 질환	작용기전	개발 단계	주요 이벤트
포베타시셉트	IgAN	BAFF/APRIL 이중 억제	3상 완료 · 허가 심사	2026.11.30 PDUFA
이낙사플린	AMKD	APOL1 저해	2/3상	2027년 초 중간분석
VX-407	ADPKD	PC1 단백질 접힘 교정	2a상	2027년 7월 1차 완료 예상

자료: 버텍스, DB증권

급성 신손상에서 만성 신장질환까지: AKI–AKD–CKD 연속성의 중요성

신장질환 치료의 새로운 접근은 만성 신장질환의 진행을 억제하는 것뿐 아니라 급성 신손상 발생 이후 신기능 회복을 촉진해 만성화되는 것을 방지하는 방향으로 확대되고 있다. 급성 신손상(AKI)은 시술 직후의 손상(AKI)에서 끝나지 않고, 7~90일의 회복기(AKD)를 거쳐 회복되지 않으면 만성콩팥병(CKD)으로 이어지는 하나의 Continuum이며, KDIGO 2026 개정안 역시 이 개념을 전면에 내세우고 손상 이후 90일까지의 신기능 회복을 중요하게 강조하고 있다.

기존 급성 신손상 임상은 주로 시술 직후 48~72시간 내 혈중 크레아티닌 상승 여부를 평가하는 데 집중했다. 그러나 최근에는 AKI 발생 자체뿐 아니라 이후 신기능이 회복되는지, AKD로 진행하는지, 장기적으로 CKD 위험을 얼마나 낮출 수 있는지가 중요해지고 있다. 이에 따라 급성 신손상 발생을 예방하는 것에서 신장 손상 이후의 회복과 만성화 방지까지 치료 목표가 확대되는 추세다.

압타바이오, 조영제 유발 급성 신손상 임상 결과로 당뇨병성 신증까지 패키지 딜 목표

압타바이오는 NOX 저해제 플랫폼 기반으로 산화 스트레스 조절을 통해 염증 및 섬유화를 억제시키는 APX-115를 당뇨합병성 신증과 조영제 유발 급성신장손상 치료제로 개발하고 있다. APX-115는 Pan-NOX 저해제로 유럽 임상 2a에서 Compliance Group(투약 준수 그룹)에서는 기저치 대비 uACR 변화율은 31% 개선되었고, 중증환자(3b등급, 21명)에서 47% ($p=0.019$) 개선을 확인하였다. 이를 기반으로 현재 당뇨병성 신증 치료제는 국내 중증 환자 대상으로 24주간 임상 2b상을 진행하고 있으며, 연내 중간결과 발표할 예정이다. 조영제 유발 급성 신장손상증(CI-AKI)은 7월말에 환자 투약 완료 후 10월 ASN(미국신장학회)에서 탑라인 데이터를 발표하였다.

CI-AKI 임상 2상은 한국 · 미국 14개 병원에서 PCI 예정 환자 212명을 대상으로 진행하였고, 1차 평가지표 안전성 결과는 투여군과 위약군 모두 임상적으로 유의한 결과를 확인하였다. 또한 기저 eGFR 45mL/min/1.73㎡ 이하의 신기능 저하 고위험군에서도 특별한 안전성 우려가 보고되지 않았다.

유효성 평가는 시술 2일 전부터 복용해 시술 시점에 약물 농도를 안정적으로 유지하고, 기존 AKI 가이드라인에 맞추어(48-72시간 구간까지 투약 설계) 조영제 손상이 진행되는 시술(PCI) 후 48~72시간 구간까지 총 5일 투약하도록 설계하였다. 그리고 급성 신질환(AKD)에서 CKD로 전환되는 시점의 신기능을 12주 eGFR, 혈청 크레아티닌으로 확인하였고, 모두 위약대비 통계적 유의성을 보여주였다.

12주 시점 eGFR은 아이수지낙시브군이 위약 대비 5.6%p 차이(p=0.017, -1.8% vs. -7.4%)를 보였고, 혈청 크레아티닌은 투약군에서 0.03mg/dL 증가(위약 0.10mg/dL)하면서 통계적 유의성(p=0.028)을 확보하였다. 신기능을 나타내는 두 지표는 같은 방향성을 보여주었으며, 조영술 직후 AKI 발생률은 두 군이 비슷한 수준이었으나, 이후 신기능 저하가 지속되는 급성 신질환(AKD) 발생은 아이수지낙시브군에서 위약군의 절반 수준으로 관찰되면서 신장개선 효과를 확인할 수 있었다. 이러한 임상 설계는 KDIGO가 2026년 개정안에서 급성 손상 이후 90일까지의 신기능 회복을 확인해야한다는 내용과 일치한다.

본 임상 2상 디자인은 이러한 처방 가이드라인의 취지와 변화를 사전에 반영하여 AKI 치료제 중 최초로 성공적인 결과를 도출하였다는 점에서 의미가 크다. 조영술 직후 AKI 발생률은 두 군이 비슷했지만, 신기능 저하가 이어지는 AKD 발생은 위약군의 절반 수준으로 관찰되었고, AKD 구간에 해당하는 12주(약 84일) 시점 eGFR 감소폭이 위약군과 뚜렷한 차이를 보였다. 이는 투약이 끝난 뒤에도 두 군의 eGFR 격차가 4주보다 12주에 더 벌어지면서 AKI가 CKD로 진행되는 AKD 진행을 차단하고 있다고 해석된다. 특히, 만성화 위험이 가장 큰 eGFR 60 미만 고위험군에서 위약군이 12주 만에 9.7% 감소하는 반면 약물군은 0.9% 감소에 그쳐 차이가 8.9%p(p=0.012)까지 확대되었다. 이는 당뇨병성 신증 임상 2a상에서 신기능이 낮은 환자일수록 알부민뇨(UACR) 개선 폭이 컸던 결과와 같은 양상이다. 급성 신손상의 회복과 만성 신질환의 지연을 하나의 약물로 가능하다는 점에서 아이수지낙시브는 AKI-AKD-CKD Continuum 전체를 아우르는 최초의 신약으로 거듭날 수 있는 가능성이 있다고 전망된다. 또한 진행 중인 당뇨병성 신증 임상 2b상의 성공 가능성과 패키지 기술이전의 가치 모두 한층 높아졌다고 판단할 수 있는 근거가 마련되었다.

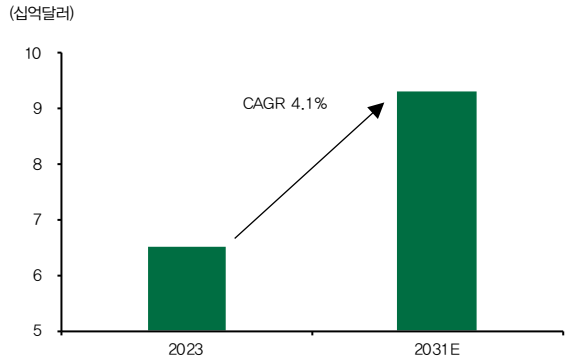
도표 37. AKI–AKD–CKD Continuum



발생 ~ 7일	발생 7 ~ 90일	발생 90일 이상
serum creatinine	persistent eGFR decline Kidney damage markers	eGFR decline albuminuria (UACR)

자료: ASN2026, 압타바이오, DB증권

도표 38. 급성신장손상 치료제 시장 전망



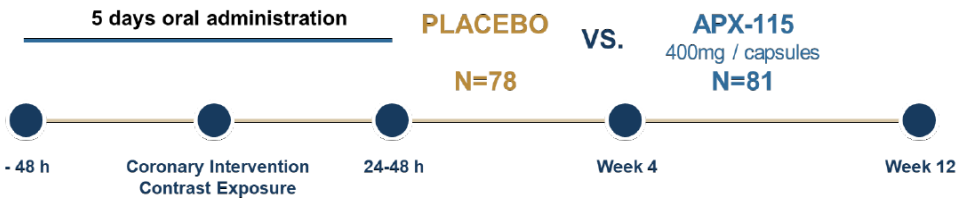
자료: 압타바이오, 산업데이터, DB증권

도표 39. 조영제 급성신장손상 위험성



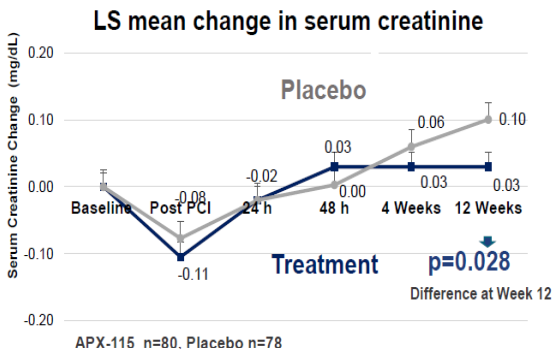
자료: 압타바이오, DB증권

도표 40. 아이수지낙시브 CI-AKI 임상 2상 디자인



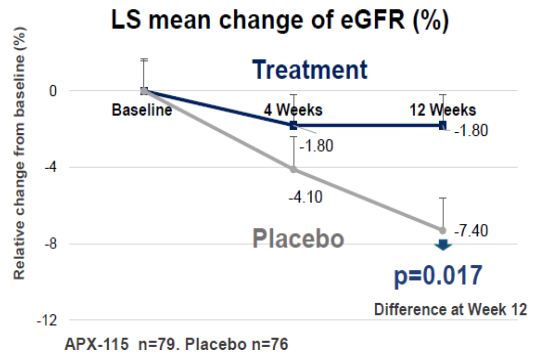
자료: ASN2026, 압타바이오 DB증권

도표 41.아이수지낙시브 혈중 크레아티닌 변화



자료: ASN2026, 입타바이오, DB증권

도표 42. 아이수지낙시브, eGFR 변화



자료: ASN2026, 입타바이오, DB증권

Ⅳ. 미국신장학회 ASN2026: 신장질환 지료 지형 변화

GLP-1의 신장보호효과, 비당뇨 CKD 및 중증 환자로 확대

신장 지방 및 대사 개선: GLP-1의 새로운 작용 가능성

신장질환은 당뇨병, 비만, 고혈압 및 심혈관질환과 밀접하게 연관되어 있어 GLP-1 기반 치료제의 적응증 확장 가능성이 높은 분야로 평가된다. 최초 GLP-1 치료제 관련 성과는 2024년 노보가 발표한 SELECT 임상으로 세마글루타이드(위고비)로 혈당 및 체중 조절을 넘어, 표준치료(RASi 및 일부 SGLT2i) 환경에서 직접적인 말기 신질환(ESKD) 및 사망 위험을 줄인다는 결과를 입증하였다. 신장-심장-대사(CKD-CVD-T2D) 복합적 위험, 즉, UACR 감소, eGFR 감소 지연, 3-point MACE 억제, 전인수 사망 감소를 해결할 수 있다는 결과를 기반으로 비만/과체중이면서 기존 CVD 성인의 심각한 심혈관 사건 위험 감소에 대한 적응증을 정식으로 획득할 수 있게 되었다.

2026년 8월 Lancet Diabetes & Endocrinology에 게재된 SELECT · FLOW · SOUL 3개 대규모 임상시험 통합분석은 Semaglutide의 신장 보호 효과를 보다 광범위한 환자군에서 확인했다는 점에서 의미가 있다. 총 30,787명의 개별 환자 데이터를 통합 분석한 것으로, 기존 당뇨병성 만성신장질환(CKD) 환자를 대상으로 한 FLOW 연구에서 확인된 신장 보호 효과를 비당뇨병 환자 및 경구제형까지 확장했다는 점이 핵심이다. 세부적으로 FLOW는 제2형 당뇨병과 고위험 CKD 환자 3,533명(SC 1.0mg/주), SELECT는 당뇨병 병력이 없는 과체중 · 비만 및 심혈관질환 환자 17,604명(SC 2.4mg/주), SOUL은 제2형 당뇨병과 ASCVD 및/또는 CKD를 동반한 환자 9,650명(경구 14mg/일)을 대상으로 진행됐다. 평균 추적관찰 기간은 약 39.5~47.5개월이었다.

가장 주목할 부분은 Semaglutide 투여군의 주요 신장 복합평가지표 발생 위험이 위약 대비 16% 감소했다는 점이다(HR 0.84, 95% CI 0.77~0.91). 실제 사건 발생 건수는 Semaglutide 투여군 973건(6.3%), 위약군 1,134건(7.4%)으로 집계됐다. 해당 평가지표는 eGFR의 지속적인 50% 이상 감소, 신부전 발생, 신장 관련 사망 및 심혈관 사망을 포함한다. 특히 심혈관 사망을 제외한 신장 중심의 이차 복합평가지표에서도 발생 위험이 20% 감소(HR 0.80, 95% CI 0.69~0.92)해 심혈관 보호 효과만으로 전체 결과를 설명하기 어렵다는 점을 보여줬다. 신장 기능의 연간 감소 속도 역시 Semaglutide 투여군 -1.26mL/min/1.73㎡, 위약군 -1.74mL/min/1.73㎡로 차이를 보였으며, UACR도 위약 대비 약 15% 낮았다.

하위군 분석에서는 기저 eGFR 수준이나 당뇨병 유무와 관계없이 전반적으로 일관된 상대적 위험 감소 효과가 관찰됐다. 특히 기저 eGFR이 60mL/min/1.73㎡ 미만인 환자군에서 주요 신장 복합평가지표의 위험 감소 폭은 21%(HR 0.79)로, eGFR 60 이상 환자군의 11%(HR 0.89)보다 크게 나타났다. SGLT2 억제제 병용 환자에서도 연간 eGFR 감소 속도를 완화하는 효과가 확인됐으며(ETD 0.25mL/min/1.73㎡/년), 이는 기존 RAS 억제제 및 SGLT2 억제제 중심의 신장질환 치료에 GLP-1RA가 추가적인 치료 옵션으로 자리 잡을 가능성을 뒷받침한다. 다만 신부전 발생 자체의 위험 감소는 HR 0.83(95% CI 0.69~1.00)으로 통계적 유의성에 대한 해석에 주의가 필요하다.

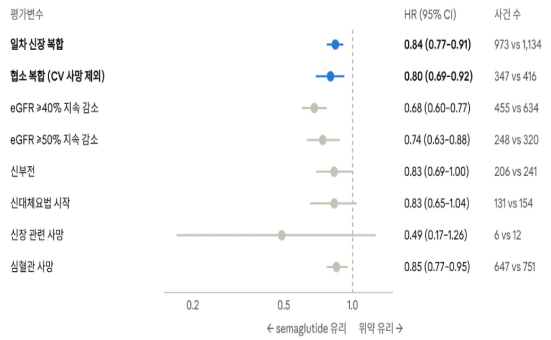
본 임상 결과의 의의는 GLP-1 치료제의 경쟁 범위가 단순 체중 감소 및 혈당 조절에서 장기적인 심혈관 · 신장 합병증 예방으로 확대되고 있다는 데 있다. 특히 당뇨병이 없는 비만 · 심혈관질환 환자와 경구제형에서도 일관된 방향의 효과가 확인되면서 향후 환자 접근성과 처방 저변 확대 가능성이 높아졌다. Novo Nordisk는 이미 Semaglutide의 제2형 당뇨병 동반 CKD 적응증을 확보한 상황으로, 향후 비당뇨병 CKD 환자 및 추가적인 심장-신장-대사질환 영역으로의 근거 확대가 주목된다. 반면 Eli Lilly의 Tirzepatide와 Retatrutide는 신장질환 관련 후속 임상 결과가 필요한 단계로, GLP-1 계열 내 신장 보호 효과를 입증한 임상적 선도 지위는 현재 Semaglutide가 앞서 있는 것으로 판단된다.

도표 43. 세마글루타이드 신장관련 주요 임상연구

구분	SELECT	SOUL	FLOW
N	17,604	9,650	3,533
대상	비당뇨, BMI ≥27, 기존 CVD, 45세 이상	T2D, ASCVD 또는 CKD, 50세 이상	T2D + 고위험 CKD, 18세 이상
투여	SC 2.4 mg/주	경구 14 mg/일	SC 1.0 mg/주
평균 eGFR (mL/min/1.73m²)	82.5	73.8	47
UACR 중앙값 (mg/g)	7.4	측정 안 함	567.6
기저 SGLT2i 사용	0%	26.90%	15.60%
일차 복합 결과 건수 (semaglutide vs 위약 IR/100인)	528건 (0.8 vs 1.0)	838건 (2.1 vs 2.3)	741건 (5.6 vs 7.1)
협소 복합 결과 건수	44건	241건	478건 (IR 3.7 vs 4.5)

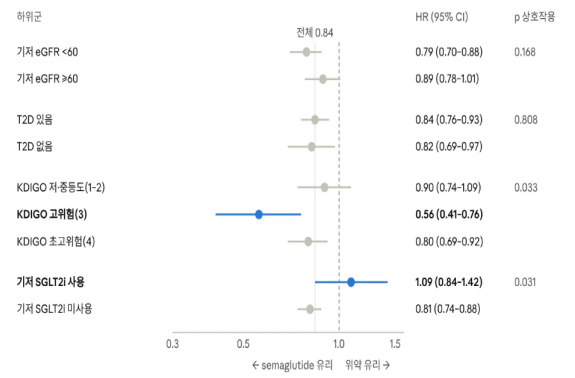
자료: Lancet Diabetes & Endocrinology2026, DB증권

도표 44. 세마글루타이드: 일차 신장 복합 HR 0.84(CV 사망 제외시 0.80으로 위험 감소)



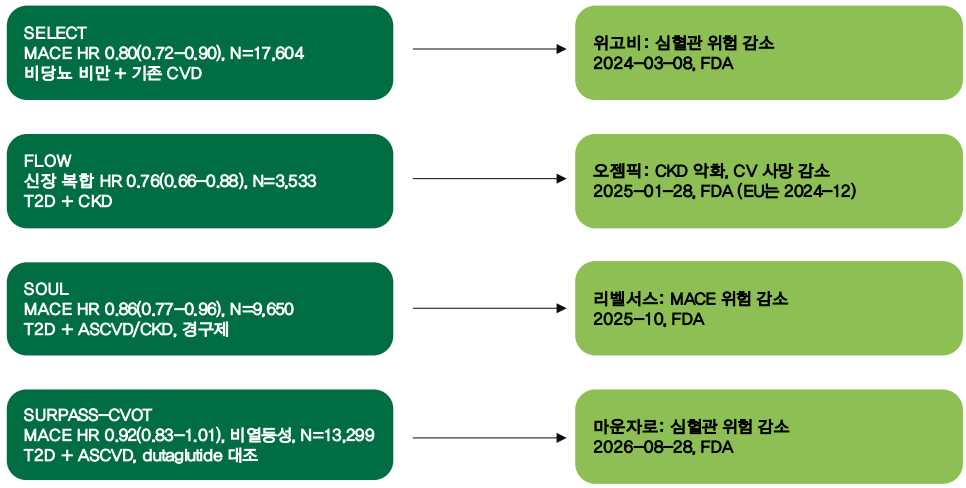
자료: Lancet Diabetes & Endocrinology2026, DB증권

도표 45. 하위군 효과는 대체로 일관적, 예외는 KDIGO 고위험군과 SGLTi 병용



자료: Lancet Diabetes & Endocrinology2026, DB증권

도표 46. GLP-1 작용제에 대한 CVRM 관련 임상결과를 토대로 적응증 추가 현황



자료: DB증권

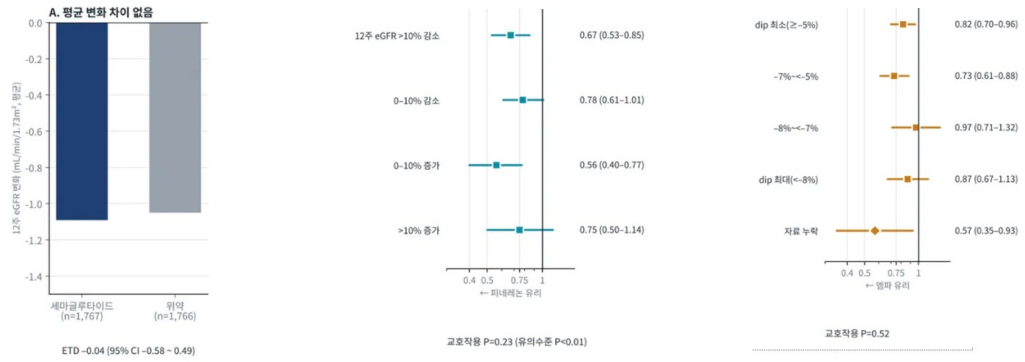
도표 47. GLP-1 작용제에 대한 CVRM 관련 임상결과를 토대로 치료 가이드라인 변경



자료: DB증권

오젬픽의 CKD 적응증 획득 이후 리얼 월드 데이터에 따르면, 세마글루타이드 실제 처방(RxFiles)에서 12개월내 약 40%가 중단되는데 이에 대한 FLOW 사후분석 데이터가 이번 ASN2026에서 발표되었다. 세마글루타이드 투여 12주 시점의 평균 eGFR 변화가 위약과 같으므로(-1.09 vs -1.05 mL/min/1.73m^2 , ETD -0.04) 초기 하락만으로 투약이 중단되지만 개별 환자에서 하락 폭이 클수록 104주 사건률이 높아지는 연관성이 나타났다. 즉, 이번 발표는 신약 데이터가 아니라 이미 승인된 Ozempic CKD 적응증(2025년 1월)의 처방 지속성을 방어하는 근거 자료라고 할 수 있다.

도표 48. FLOW 사후분석: 12주 eGFR 변화와 기존 신장보호제(피네레논, 엠파글리플로잔)



자료: ASN202, 노보, DB증권

도표 49. 인크레틴 약물 3종의 연구결과: eGFR을 서로 다르게 해석

	시험/대조군	초기 eGFR 반응	실측/대체 지표	알부민뇨(UACR)	하드 아웃컴 / 라벨
세마글루타이드 (Novo)	FLOW 3,533명, 위약 + ASN2026 사후분석	크레아티닌 eGFR 하락 −1.09 vs −1.05 (ETD −0.04)	시스타틴 C/REMODEL 청소율은 dip 없음	FLOW에서 감소 (REMODEL 시사)	주 평가변수 24% 감소 오젬픽 CKD 라벨 (25.1)
티르제파타이드 (Lilly)	SURPASS-CVOT 13,165명 활성 대조(dulaglutide)	초기 가역적 dip (과여과 감소와 부합)	연 eGFR 감소 차이 +0.29 (고위험 +0.93)	36개월 −45.6% vs −28.0% (초고위험 CKD 사후)	신장 복합 23% 감소 (탐색적) CKD 라벨 없음
레타트루타이드 (Lilly)	TRANSCEND-CKD 2b 146명, 24주, 위약	eGFR 상승 (크레아티닌, 시스타틴 C)	mGFR 불변 −1.4 (CI −9.2~6.3)	UACR 30 이상 하위군 −49.2% (차이)	아웃컴 미판독 TRIUMPH, Outcomes (29.2)

자료: ASN2026, 노보, 일라이릴리, ClinicalTrial gov, DB증권

신장 기능 및 알부민뇨 개선: 임상적 근거의 확대

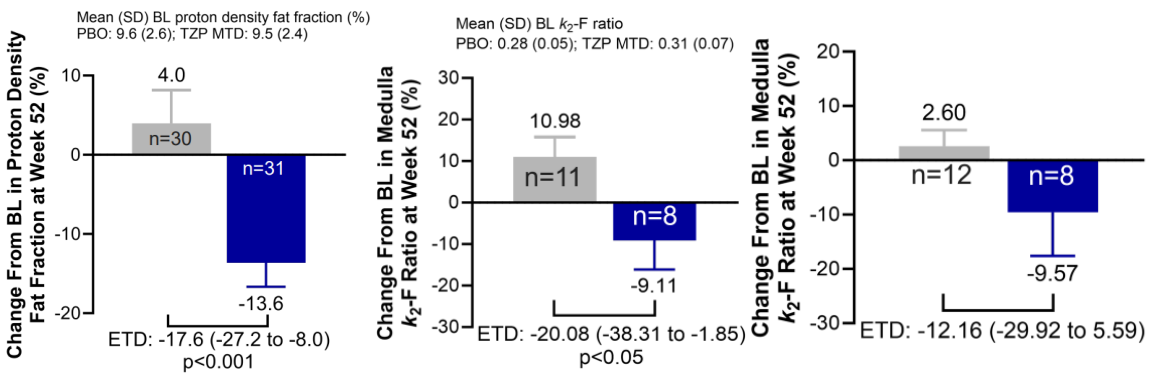
CKD 시장은 SGLT2i, 피네레논(FIND-CKD 임장으로 비당뇨까지 확장)이 기본 치료로 자리 잡아 GLP-1은 병용 이득을 입증해야만 한다. 일라이릴리도 노보와 같이 확실한 CKD에서 이점을 임상결과로 입증해야하는 과제가 남아있다. 터제파타이드가 dulaglutide 대비 신장 복합 23% 감소하며, 연 eGFR 감소 차이가 0.29 개선된다는 탐색적 SURPASS-CVOT 신장 분석 내용을 작년 미국 신장학회에서 발표하였고 지난 7월 논문을 출간하였다. 그리고 레타트루타이드에 대해서는 TREASURE-CKD(n=146, 24주)신장 산소화 BOLD-MRI를 2026년 7월 1차 완료로 등록되었으나 임상종료 후 결과 발표는 2029년이나 가능할 것으로 예상된다.

노보는 세마글루타이드와 아밀린 유사체 cagrilintide의 병용제인 카그리세마에 대한 CKD 적응증 확장가능성을 탐색하기 위한 임상 2상을 이미 완료하였다. 제 2형 당뇨병과 과체중/비만을 동반하는 CKD 환자 626명 대상으로 세마글루타이드, 카그릴린타이드, 위약과 비교하는 임상으로 1차 평가지표는 26주 시점의 UACR 변화이다. 이는 GLP-1 기반 치료제의 신장 보호 영역이 체중감량 및 혈당 조절을 넘어 아밀린 병용을 통한 추가적인 대사/신장 보호 효과로 확장될 가능성을 평가한다는 점에서 의미가 있다. 이외에 베링거인겔하임 서보두타이드도 올해 3월 정도부터 ARTIST-CKD 2상(120명 목표)을 시작하였다.

ASN 2026에서 일라이릴리는 터제파타이드에 대한 TREASURE-CKD와 레타트루타이드의 TRANSCEND-CKD에 대한 임상 2상 연구 결과를 발표했다. 두 연구 모두 비만 또는 과체중을 동반한 CKD 환자를 대상으로 GLP-1 기반 다중작용제가 신장 구조와 기능에 미치는 영향을 평가했다. TREASURE-CKD에서는 52주 투여 후 신장 실질 지방과 신장 주변 지방이 위약 대비 각각 17.6%, 26.4% 감소했으며, 체중 및 UACR 감소와 eGFR 개선도 관찰됐다. 특히 PET/CT 분석에서 신장 수질의 관류-대사 결합 개선이 확인돼 신장 대사 효율 개선 가능성을 제시했다. 다만 1차 평가변수인 신장동 지방 감소에서는 통계적 유의성을 확보하지 못했다.

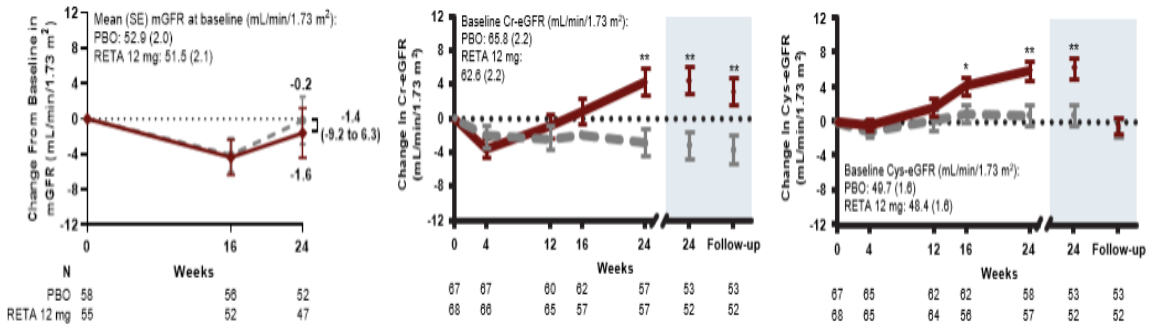
레타트루타이드를 평가한 TRANSCEND-CKD에서는 24주 투여 후 알부민뇨 환자군의 UACR이 위약 대비 49.2% 감소했으며, 신장 주변 및 신장 지방 감소와 사구체 내 압력 개선이 관찰됐다. 그러나 1차 평가변수인 Iohexol 기반 mGFR에서는 위약 대비 유의한 차이가 확인되지 않았다. 두 연구 모두 장기적인 신장 사건 감소를 입증한 연구는 아니지만, 체중 감량을 넘어 신장 지방 축적과 신장 혈역학 및 대사 환경에 영향을 미칠 수 있다는 기전적 근거를 확보했다는 점에서 의미가 있다.

도표 50. 터제파타이드 TREASURE-CKD 결과: 신장의 실질적인 지방구조와 신장 대사 효율개선 가능성(신장의 좌, 우)



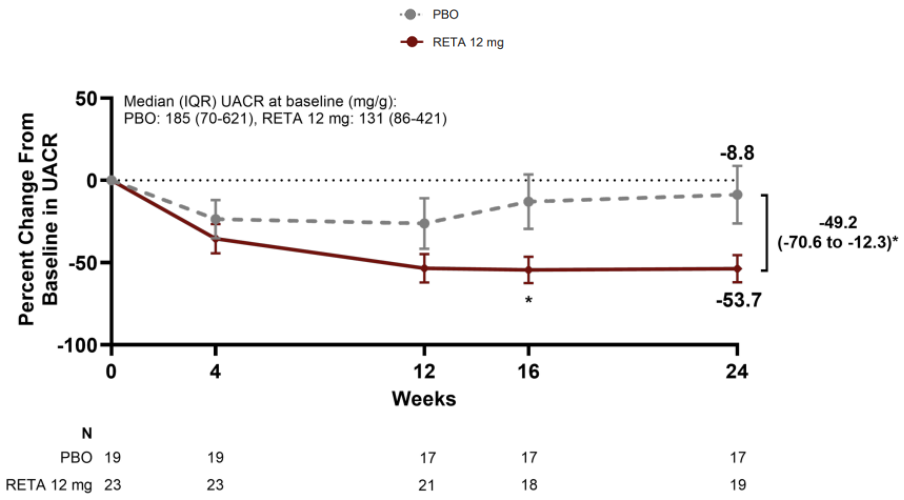
자료: ASN2026, 일라이릴리, DB증권

도표 51. 레타트루타이드 TRANSCEND-CKD 결과: mGFR, cr-eGFR, cys-eGFR으로 신장기능 확인



자료: ASN2026, 일라이릴리, DB증권

도표 52. 레타트루타이드 TRANSCEND-CKD 결과: UACR로 알부민뇨 감소 효과



자료: ASN2026, 일라이릴리, DB증권

도표 53. 일라이릴리 터제파타이드 SURPASS-CVOT 임상 결과

평가 지표	결과
ASN 2025 사후분석(초고위험 CKD)	36개월 eGFR 변화 -3.0 vs -7.2, 신장 복합 HR 0.67(0.52~0.87)
Lancet D&E 2026 사전규정 탐색분석	dulaglutide 대비 신장 복합 23% 감소
연간 eGFR 감소 차이	전체 0.29, 고위험 CKD 0.93 mL/min/1.73m² /년)
이상반응 중단	티르제파타이드 13.3% vs dulaglutide 10.2% American Society of Nephrology +3

자료: ASN2025, Lancet D&E2026, DB증권

도표 54. 노보와 릴리의 CKD 연구에 대한 현황

기업	노보 노디스크	일라이 릴리		
항목	세마글루타이드(노보)	티르제파타이드	레타트루타이드	오르포글리프론
신장 전용 아웃컴 RCT	FLOW 완료, 주 평가변수 24% 감소	SURPASS-CVOT 신장 분석(위약군 dulaglutide)	TRIUMPH-Outcomes: 1만 명 목표, ASCVD 및/또는 CKD, 2024.4~2029.2	ATTAIN-Outcomes: 7,140명 계획, ASCVD 및/또는 CKD, 2026.5 시작
적응증 확보	Ozempic CKD(T2D)	CKD 라벨 없음	미승인	비만 승인(Foundayo)
초기 eGFR 양상	크레아티닌 eGFR 하락(-1.09), 시스타틴C에는 없음	SURPASS-4에서 초기 가역적 dip 과여과 감소와 부합	eGFR 상승, 실측 GFR 불변	확인된 자료 없음

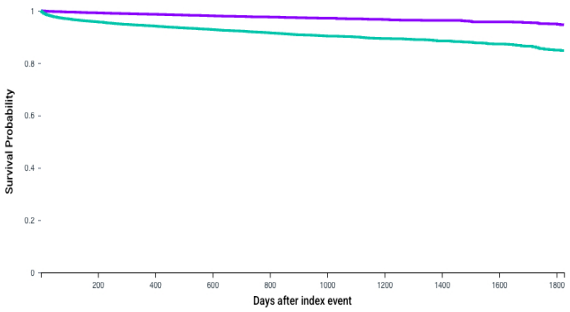
자료: ASN2026, ClinicalTrial.gov, DB증권

비당뇨 CKD와 투석 환자: 새로운 환자군으로의 확장

당뇨병이 없는 비만 CKD 환자에서도 신장 예후 개선이 연관성이 있다는 것에 대한 후향적 진료 연구를 발표하였다. 미국 112개 의료기관 데이터를 이용하였고, 성향점수 매칭 후 GLP-1 수용체 작용제 투여군과 비투여군을 각각 34,980명씩 비교한 것이다. 그 결과 사망위험비 HR 0.251, 심부전 악화 위험비 HR 0.744로 보고되었다. 무작위배정 임상이 아니라는 점에서 약물의 직접적인 인과효과로 단정하기는 어렵지만 GLP-1의 신장보호 효과가 제 2형 당뇨병 동반 CKD를 넘어 비당뇨병성 동반 비만 · CKD 환자로 확장가능성을 제시하였다.

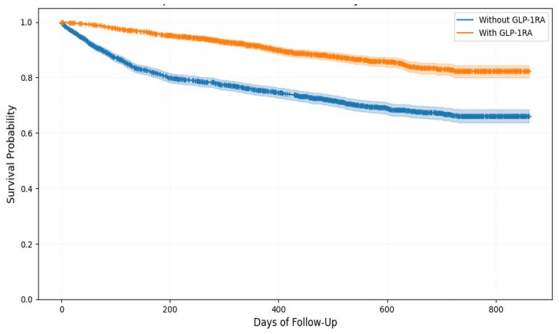
또한 Fresenius는 투석을 시작한 성인 환자 약 5,000명을 대상으로 한 GLP-1 투여군과 비투여군을 각각 2,468명씩 매칭하여 후향적 임상연구를 한 결과를 발표하였다. 투석 환자는 심혈관 위험과 의료 이용 부담이 높은 집단으로 체중 감량이나 GLP-1 치료제 사용으로 혈당 조절을 넘어 더 진행된 신장질환 환자에게도 잠재적 이점을 가질 수 있다는 가설을 강화하였다. 그 뿐만 아니라 복막투석 T2D 5,897명 코호트에서도 GLP-1 노출과 체중 변화를 분석하였는데 긍정적인 결과를 발표하였다. 다만 투석 환자에서의 치료 효과를 확정하는 근거로 사용하기에는 한계가 있고, 처방받은 환자와 그렇지 않은 환자의 기저 상태, 약물 선택 편향, 잔여 교란 가능성을 고려할 필요가 있다.

도표 55. 비만 동반 비당뇨성 CKD 환자에서의 GLP-1 치료제 투약 여부에 따른 생존분석



자료: ASN2026, DB증권

도표 56. 투석환자의 GLP-1 치료제 투약 여부에 따른 생존분석 (3년 생존률)



자료: ASN2026, DB증권

도표 57. 투석환자의 GLP-1 치료제 사용여부에 따른 임상 연구결과

주요 결과	GLP-1 투여군	대조군
환자수(명)	2,468	2,468
2년 누적 사망자(명)	196	547
3년 누적 사망자(명)	290	661
전체 사망 위험비(HR)	–	0.38
전체 입원 건수(건)	5,565	7,689
환자당 평균 입원 횟수(회)	2.26	3.11

자료: ASN2026, DB증권

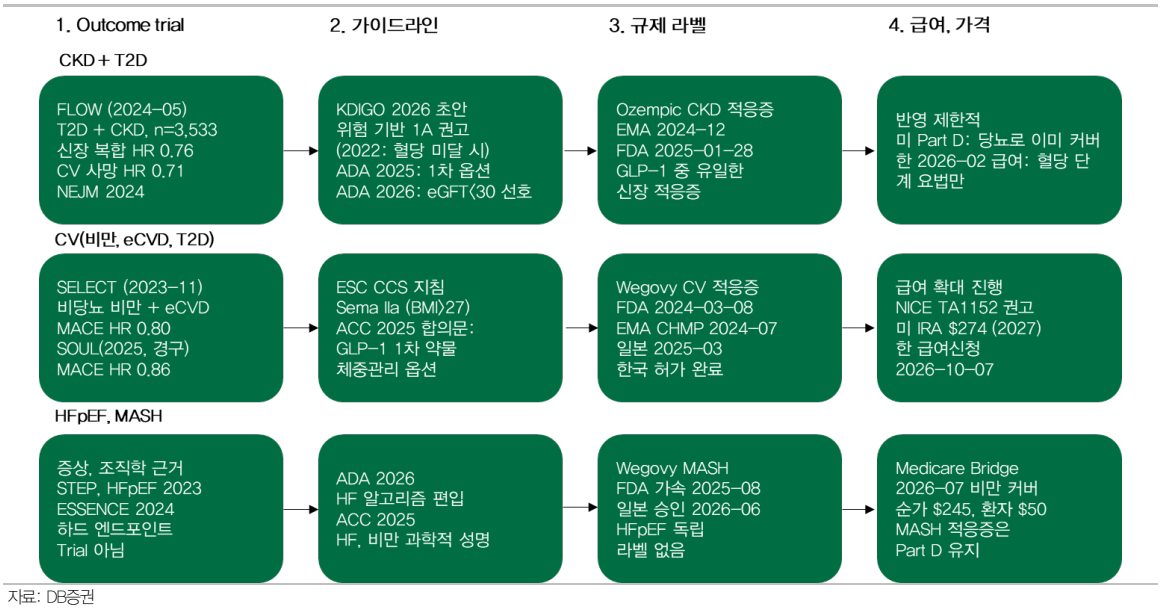
KDIGO 가이드라인 변화와 신장질환 치료의 새로운 기준

체중관리에서 심혈관질환 혜택이 신장 질환 예방에서 CMD 예방까지로 확장 중

2026년 6월 미국 심장협회(AHA), 미국 심장학회(ACC), 미국당뇨병학회(ADA), 미국신장학회(ASN) 등 공동으로 참여하여 심혈관-신장-대사(CKM) 증후군에 대한 통합가이드라인을 최초로 제정하였다. CKM 통합 가이드라인은 비만, 제2형 당뇨병, 만성콩팥병 및 심혈관질환을 상호 연관된 하나의 질환 스펙트럼으로 정의하고, 위험인자 평가부터 조기 진단, 단계별 치료 및 장기 관리까지 통합했다. 특히 GLP-1 기반 치료제의 역할이 혈당 및 체중 조절을 넘어 심혈관 · 신장 위험을 포괄하는 방향으로 확대되는데 촉진제 역할을 할 것으로 생각된다. 이번 가이드라인에는 T2D · CKD 환자 중 알부민뇨가 지속되는 고위험군에서 신장 및 심혈관 유익성이 입증된 GLP-1 기반 치료를 추가하도록 권고하는 등, GLP-1의 임상적 활용 범위를 구체화했다는 점에 의미가 있다.

다만 가이드라인은 임상적 유효성과 경제성을 별도로 평가하고 있으며, 2025년 미국 약가 기준으로 일부 T2D · CKM 환자군에서 GLP-1 치료의 비용효과성이 입증되지 않았거나 판단이 유보된 상태다. 따라서 향후 시장 확대는 임상적 근거 축적뿐 아니라 약가 인하, 보험 급여 확대 및 장기 의료비 절감 효과의 입증이 함께 뒷받침되어야 할 전망이다.

도표 58. GLP-1 치료제 관련 주요 임상결과, 처방가이드라인, 각 규제기관별 적응증 획득, 각 국가별 급여 결정 절차



자료: DB증권

KDIGO는 2020년 당뇨병 · CKD 가이드라인에서 GLP-1 수용체 작용제를 메트포르민 및 SGLT2 억제제로 충분한 혈당 조절을 달성하지 못하거나 해당 약제를 사용할 수 없는 환자의 추가 치료제로 권고했다. 당시 근거는 LEADER, SUSTAIN-6 등 주요 심혈관 결과시험에서 확인된 심혈관 보호 효과와 알부민뇨 감소에 주로 기반했다. 다만 신장 관련 복합 평가변수의 개선이 신규 거대알부민뇨 감소에 상당 부분 기인해, 신부전 진행 자체를 억제하는 효과에 대해서는 직접적인 근거가 제한적이었다.

2024년 발표된 FLOW 연구는 이러한 근거의 공백을 보완했다. 제2형 당뇨병 · CKD 환자 3,533명을 대상으로 한 이 연구에서 세마글루타이드는 신부전, eGFR의 유의한 감소 및 신장 · 심혈관 원인 사망을 포함한 주요 결과의 위험을 위약 대비 24% 낮췄다(HR 0.76, 95% CI 0.66-0.88). 이는 GLP-1 기반 치료가 혈당 · 체중 조절과 심혈관 보호를 넘어 임상적으로 중요한 신장질환 결과를 개선할 수 있음을 뒷받침하는 핵심 근거로 사용되었다.

이에 따라 GLP-1 기반 치료의 임상적 위치는 혈당 조절 중심에서 심혈관 · 신장 위험을 통합 관리하는 방향으로 확대되고 있다. 향후 시장 확대 가능성을 판단할 때는 당뇨병 동반 CKD에서 확보된 근거와 비당뇨 CKD로의 적응증 확장 가능성을 구분해야 한다. 특히 비당뇨 CKD 환자에 대한 직접적인 신장 결과 근거, 최종 가이드라인의 권고 범위, 허가 및 보험급여 변화가 실제 처방 시장 확대를 결정할 핵심 변수다.

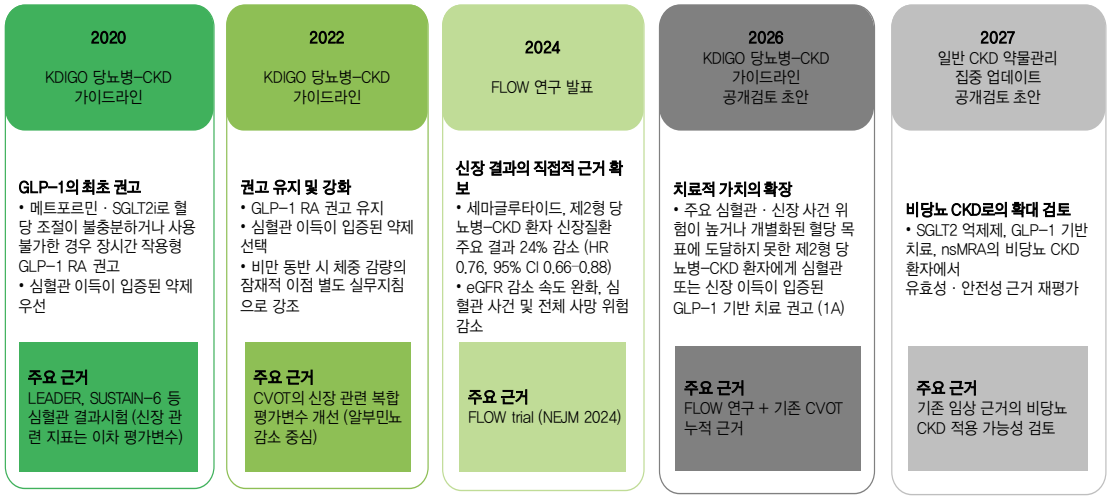
도표 59. GLP-1 치료제에 대한 심혈관위험에 대한 임상결과

임상시험명(약물)	환자 수 및 대상	추적 기간	주요 유효성 결과	안전성 · 부작용
LEADER (liraglutide)	9,340명. 제2형 당뇨병(T2D), 심혈관 고위험군	중앙값 3.8년	MACE 13.0% vs 14.9% HR 0.87, 13% 감소. 심혈관 사망 4.7% vs 6.0%(HR 0.78), 전체 사망도 감소	위장관 이상반응이 주요 중단 원인 췌장염의 유의한 증가 확인 않됨
SUSTAIN-6 (semaglutide SC)	3,297명. T2D, 심혈관 고위험군	중앙값 2.1년	MACE 6.6% vs 8.9% HR 0.74, 26% 감소. 비치명적 뇌졸중 감소가 주요 기여 요인	위장관 이상반응. 당뇨망막병증 합병증 증가 신호 관찰. 혈당이 빠르게 개선되는 환자에서 주의 필요
REWIND (dulaglutide)	9,901명. T2D, 기존 심혈관질환 환자와 위험인자 보유자 포함	중앙값 5.4년	MACE 12.0% vs 13.4% HR 0.88, 12% 감소 기존 심혈관질환이 없는 환자도 상당수 포함	위장관 이상반응 47.4% vs 34.1% 전체 사망은 통계적으로 유의한 감한 감한 것 아님.
AMPLITUDE-O (efpeglenatide)	4,076명. T2D, 심혈관 · 신장 고위험군	중앙값 1.81년	MACE 7.0% vs 9.2% HR 0.73, 27% 감소 신장 복합 결과도 HR 0.68로 감소	위장관 이상반응이 주요 계열 부작용.
SELECT (semaglutide 2.4mg)	17,604명. 과체중 · 비만 및 기존 심혈관질환, 당뇨병 없음	평균 추적 약 3.3년	MACE 6.5% vs 8.0% HR 0.80, 20% 감소 당뇨병이 없는 환자에서 심혈관 사건 감소를 입증한 중요한 연구	이상반응으로 치료 영구 중단 16.6% vs 8.2%. 주로 위장관 내약성 문제가 임상 적용 시 고려사항.

자료: DB증권

KDIGO 2026 임상진료지침에서 2가지 큰 변화가 있다. 첫번째는 당뇨병 동반 만성신장질환(CKD) 지침이 업데이트가 되고 있고 있다. 2020년 심혈관 및 신장 보호 효과가 입증된 GLP-1 치료제를 혈당 조절 수단에 국한하지 않고, 제2형 당뇨병과 CKD를 동반한 고위험 환자에서 신기능 저하 및 심혈관 사건을 줄이기 위한 치료 전략으로 다루는 것이 중요한 변화다. 이는 FLOW 임상에서 세마글루타이드가 신장 관련 복합 평가변수 위험을 24% 낮춘 결과 등, 혈당 · 체중 개선을 넘어선 임상적 근거가 축적된 데 따른 변화로 해석할 수 있다.

도표 60. 당뇨병과 CKD에 대한 치료 가이드라인 변화 추이



자료: KDIGO, DB증권

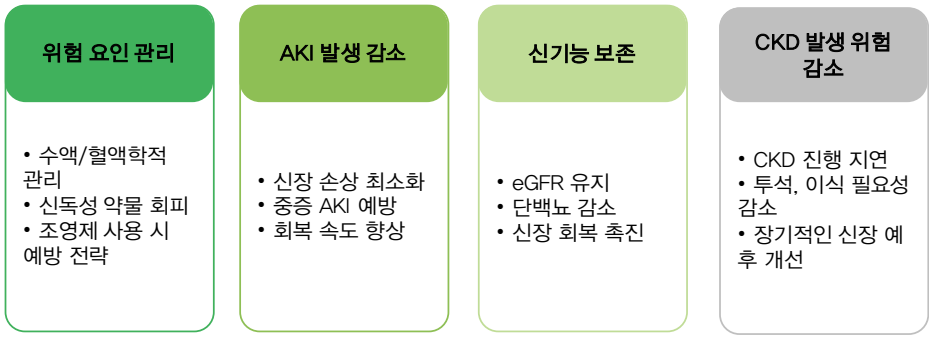
두번째는 2012년 이후 처음으로 급성 신손상(AKI) 및 급성 신장질환(AKD) 지침 초안에 대대적인 개정이 진행되고 있다. 기존 신기능 변화 중심의 평가에서 기능적, 구조적 바이오마커를 함께 활용하는 방향으로 확대하며, 수액 및 혈역학적 관리, 신독성 약물 관리, 조영제 관련 AKI 예방과 위험 관리에 대한 지침을 업데이트 했다. 또한 신대체 요법의 시작, 방식, 용량, 중단에 대한 지침을 재검토하고, AKI/AKD 이후 장기 예측 악화를 줄이기 위한 추적관리를 강조할 수 있다. 특히 진단은 기존 혈청 크레아티닌과 소변량 기준에서 시스타틴(Cyctatin C) 및 새로운 구조적 바이오마커를 도입하여 더 빠르고 정확하게 급성 신손상을 진단하는 흐름으로 가고 있다.

도표 61. AKI에 대한 KDIGO 치료가이드라인 변화



자료: KDIGO, DB증권

도표 62. KDIGO 사고의 전환: AKI 발생 위험 감소로 CKD로 확장되는 위험 감소 관리



자료: DB증권

국내 개발 현황 및 투자기회

CVRM 치료제 개발의 어려움

당뇨에서 시작한 GLP-1 작용제를 비만으로 확장하면서 CVRM 중심으로 확장하고 있는 국내 대표 기업은 한미약품, HK이노엔, 동아에스티이다. 또 다른 접근은 GLP-1 작용제에서 출발하거나 유전자치료제로 MASH 치료제에 대한 도전하는 한미약품, 디앤디파마텍, 올릭스 등이 있다.

또한 국내 기업들도 만성신장질환의 미충족 수요를 겨냥해 서로 다른 작용기전의 치료제를 개발하고 있다. 당뇨병성 신증에서는 압타바이오가 NOX 저해제 기반의 APX-115를 통해 산화 스트레스와 염증을 억제하는 전략을 추진하고 있으며, 큐라클은 Nrf2 활성화 및 TGF-β 신호 억제를 기반으로 한 저분자 합성신약 CU-01의 임상 2b상을 완료했다. 인제니아테라퓨틱스는 사구체 미세혈관 내피세포의 TIE2를 활성화하는 IGT-303을 개발하고 있으며, 큐라클 역시 TIE2 작용제인 MT-101을 후속 파이프라인으로 보유하고 있다. 이처럼 국내 기업들은 기존 혈압 · 혈당 조절 중심의 치료 전략에서 벗어나 산화 스트레스, 염증, 섬유화 및 사구체 미세혈관 기능을 직접 조절하는 방식으로 차별화를 시도하고 있다. 특히 압타바이오는 당뇨병성 신증뿐 아니라 조영제 유발 급성신손상(CI-AKI)으로 적응증을 확장하고 있어, AKI에서 AKD를 거쳐 CKD로 이어지는 신장질환의 연속적인 진행 과정에 대응할 수 있는 가능성도 주목할 필요가 있다.

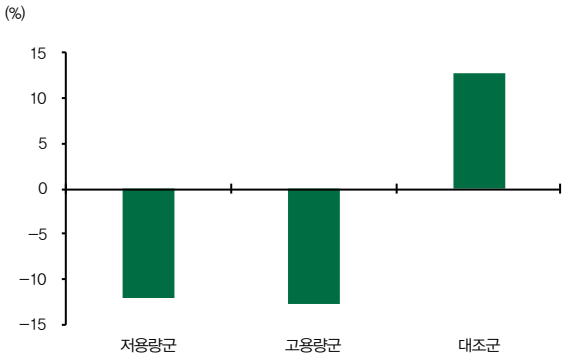
투자 관점에서는 국내 신장질환 파이프라인의 가치를 단순히 임상 단계나 단백뇨 감소율만으로 평가하기보다, 기존 표준치료제와 병용했을 때 추가적인 신장 보호 효과를 입증할 수 있는지에 주목해야 한다. 특히 eGFR 감소 속도 개선과 장기적인 신부전 진행 억제 여부가 차별화된 경쟁력을 판단하는 핵심 지표가 될 전망이다. 글로벌 빅파마가 IgAN을 중심으로 APRIL · BAFF 표적치료제와 신장질환 파이프라인 확보에 적극적으로 나서고 있다는 점은 국내 기업에도 기술이전 및 공동개발 기회가 확대될 수 있음을 시사한다. 향후 투자 매력은 임상적 유효성의 재현성, 기존 치료제 대비 차별화된 작용기전, 장기 투여 안전성 및 글로벌 개발 · 사업화 역량에 의해 결정될 것으로 판단한다. 특히 임상 초기 단계에서는 바이오마커 개선을 넘어 eGFR 등 신기능 지표의 일관된 개선 여부를 확인하고, 후기 임상에서는 경성 신장 평가변수로 이어질 수 있는지를 검증하는 과정이 기업가치 상승의 중요한 변수가 될 것이다.

도표 63. 인제니아테라퓨틱스 IGT-303 임상 결과

약물	단백뇨 감소 효과
IGT-303(TIE2 수용체 직접 활성화)	58%의 단백뇨 감소 (영장류 실험)
기존 표준치료제	평균 약 30%내외 단백뇨 감소 (임상시험)

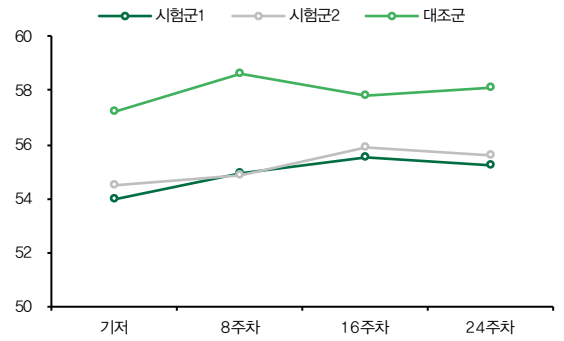
자료: 인제니아테라퓨틱스, DB증권

도표 64. 큐라클 CU01 2b상 결과 (24주차 uACR 변화율)



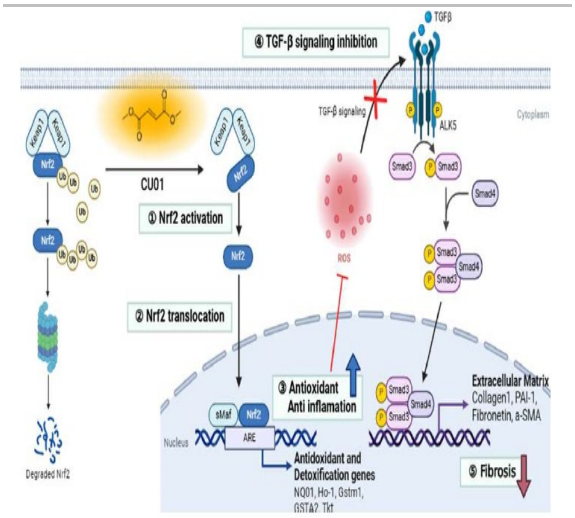
자료: 큐라클, DB증권

도표 65. CU01 기저치 대비 투여 eGFR 값



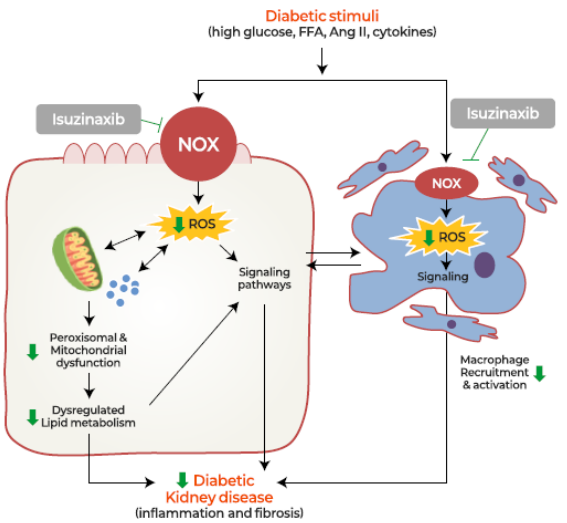
자료: 큐라클, DB증권

도표 66. 큐라클 CU-01 기전



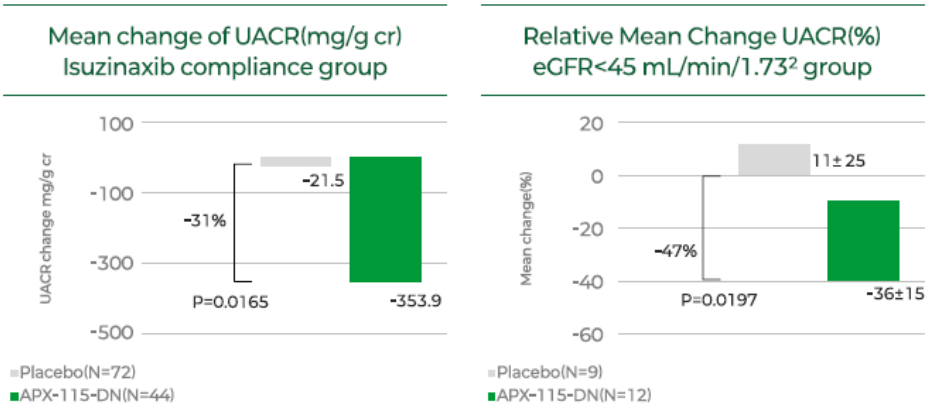
자료: 큐라클, DB증권
주: 항산화 alc 항염증을 조절하는 역할을 하는 1)Nrf2 단백질을 활성화하여 2) Nrf2가 세포핵으로 이동하면 3) 항산화 및 항염증 반응을 촉진하고, 4) TGF-b 신호 전달을 억제해 5) 신장의 섬유화 진행을 저해시킴

도표 67. 압타바이오 APX-115_DN



자료: 압타바이오, DB증권

도표 68. 압타바이오 APX-115-DN 임상 2a상 결과 (기저치 대비 일반 및 중증 환자 uACR 변화율)



자료: 압타바이오, DB증권

도표 69. 국내비만 또는 대사질환 관련 임상연구 현황

기업명	성분명/프로젝트명	작용기전 or 타겟	적응증(임상기준)	개발단계	약물특성	임상시작/종료일
한미약품	HM15211		MASH	임상 2상		20.07.31/26.07.15
	HM15275		제2형 당뇨병	임상 2상	주 1회 주사	26.05.18/27.10
	HM15275		당뇨병이 없는 비만, 과체중 환자	임상 2상	주 1회 주사	25.12.02/27.01
	HM17321		비만	임상 1상	주 1회 주사	25.11.06/27.03
	Efinopegdutide		MASH	임상 2상	주 1회 피하주사 투여	23.06.23/25.12.29
	Efinopegdutide		MASH	임상 2상	주 1회 피하주사 투여	24.07.12/26.08.03
	Efinopegdutide		MASH	임상 2상	2주 1회 or 1주 1회	24.07.29/25.06.27
동아에스티/metavia	DA1726		비만	임상 1상	주 1회 주사	24.03.25/26.11.09
	DA1241		MASH	임상 2상		23.09.14/24.10.30
	DA1241		제2형 당뇨병	임상 1상	1일 1회 투여	18.08.27/20.05.07
	DA2811		제2형 당뇨병	임상 2상	1일 1회 경구 투여	25.11/27.06
	DA2811		제2형 당뇨병	임상 4상		23.04.25/25.03.10
hk이노엔	Ecnoglutide	cAMP based GLP-1	비만, 과체중	임상 2상	주 1회 경구 투여	25.11.25/26.07.23
	Ecnoglutide		비만, 과체중	임상 2상	주 1회 경구 투여	26.06.12/26.12.31
	Ecnoglutide		비만, 과체중	임상 3상	주 1회 피하주사 투여	26.10.31/28.09.30
	Ecnoglutide		비만, 과체중	임상 1b/2a상	일 1회 or 주 1회 경구 투여	25.11.18/27.04.28
중외제약	Bofanglutide	GLP-1	제2형 당뇨병	임상 3상	2주 1회 주사제	26.09/27.10
	Bofanglutide		비만, 과체중	임상 3상	2주 1회 주사제	26.07/27.12
일동제약	ID110521156		비만	임상 1상	1일 1회 경구 투여	24.11.13/25.06.19
디앤디파마텍	DD01		MASLD/MASH	임상 2상		24.06.13/26.04.21
지투지바이오	GB-7001		-	-	-	-
프로젠	PG-102		제2형 당뇨병	임상 2상	4주간 주 1회, 다음 4주간 2주 1회, 나머지 24주간 4주 1회	26.10/27.06
	PG-102		제2형 당뇨병	임상 2상	주 1회 주사	24.12.05/25.10.30
	PG-102		제2형 당뇨병	임상 2상	주 1회 주사	26.01/26.12
압타바이오	APX-115		당뇨병성 신장 질환	임상 2상	1일 1회 경구 투여	25.05.26/28.06.30
	APX-115		제2형 당뇨병, 신장 질환	임상 2상	1일 1회 경구 투여	20.08.24/21.07.26
	APX-115		조영제 유발 급성 신장 질환	임상 2상	1일 1회 경구 투여	23.12.27/26.07.22
인제니아	IGT-303		만성 신장 질환	임상 1/2a상		25.10.30/27.04
큐라클	CU01		-	-	-	-

자료: DB증권

APPENDIX, 용어 설명

eGFR(추정 사구체여과율): 신장의 사구체가 1분 동안 걸러내는 혈액의 양을 혈중 크레아티닌, 나이, 성별로 추정한 값임(단위: mL/min/1.73m²). 신장 기능을 가장 직접적으로 보여주는 대표 지표로, 수치에 따라 만성콩팥병을 1기(90 이상)부터 5기(15 미만)까지 5단계로 구분함. 병기가 높아질수록 노폐물이 혈액에 쌓이고, 5기에 이르면 투석이나 신장이식이 필요한 말기신부전이 됨. 만성 신장질환에서는 eGFR이 천천히 변해 12주나 24주 같은 짧은 기간에는 차이를 확인하기 어려워, 신약 임상에서는 대개 1년 이상 장기간에 걸친 변화율을 주요 평가지표로 봄

혈중 크레아티닌: 근육에서 만들어져 신장을 통해 배설되는 노폐물임. 신장 기능이 떨어지면 몸 밖으로 빠져나가지 못해 혈중 농도가 올라감. 정상 범위가 1mg/dL 안팎으로 작아 작은 변화도 신기능 변화를 반영하며, eGFR 계산과 급성 신손상 진단의 기준이 됨

UACR(소변 알부민-크레아티닌 비율): 소변 속 알부민과 크레아티닌의 비율임(단위: mg/g). 사구체가 손상되면 걸러져야 할 알부민이 소변으로 새어 나오는데, 그 정도를 보여줌. 30 미만은 정상, 30~300은 중등도, 300 초과는 고도 증가로 분류함. 알부민뇨가 줄어들면 신기능 악화 속도도 늦어지는 것으로 알려져 있어, 당뇨병성 신증 신약의 임상 2상에서 약효를 확인하는 주요 평가지표로 쓰이며, 이후 3상에서는 eGFR 등 장기 신기능 지표로 최종 효과를 확인함

KIM-1(신장 손상 분자-1): 신장 세뇨관이 손상되면 세포 표면에 나타나 소변으로 배출되는 단백질임. 혈중 크레아티닌보다 먼저 변화해 세뇨관 손상을 이른 시점에 확인할 수 있는 바이오마커로, 미국 FDA가 약물에 의한 신장 손상을 평가하는 지표로 인정한 바 있음.

AKI(급성 신손상): 신장 기능이 갑자기 떨어지는 상태. 국제 진료지침(KDIGO) 기준으로는 48시간 안에 혈중 크레아티닌이 0.3mg/dL 이상 오르거나, 7일 안에 기저치의 1.5배 이상 증가하는 경우 등으로 진단함

CI-AKI(조영제 유발 급성 신손상): 관상동맥 중재술(PCI)이나 CT 촬영처럼 혈관에 조영제를 넣는 시술 · 검사 뒤에 생기는 급성 신손상임. 신기능이 떨어진 환자, 당뇨병 환자, 고령 환자에게서 위험이 높음. 현재 예방 약물로 승인된 치료제가 없어, 시술 전후 수액을 공급하는 것이 사실상 유일한 대응법임

AKD(급성 신질환): 급성 신손상 이후 7일에서 90일까지 신기능이 회복되지 않고 저하된 상태가 이어지는 것을 말함. AKI와 만성콩팥병 사이의 중간 단계로, 90일을 넘기면 정의상 만성콩팥병으로 분류됨. 초기 검사에서 AKI 기준에 해당하지 않았던 환자도 이후 신기능이 계속 떨어져 AKD로 진행할 수 있어, AKI 발생 여부만으로는 신장 손상을 충분히 평가하기 어려움. 이 때문에 초기에 AKI가 생겼는지보다 이후 AKD로 이어지는지가 장기적인 신기능 저하, 만성콩팥병 진행, 사망 위험과 더 밀접하게 연관된 것으로 보며, 급성 신손상 이후의 회복을 평가하는 핵심 지표로 주목받고 있음. KDIGO도 2026년 급성 신손상 지침 개정안에서 AKD 단계의 관리를 중요하게 다룸

AKI–AKD–CKD 연속성(Continuum): 급성 신손상(AKI), 급성 신질환(AKD), 만성콩팥병(CKD)을 별개의 질환이 아니라 하나로 이어지는 경과로 보는 개념임. 손상 직후의 급성기(AKI)와 7~90일의 회복기(AKD)를 거쳐, 90일 이후에도 회복되지 않으면 만성콩팥병(CKD)으로 넘어감. 이 관점에서는 손상이 생겼는지보다 손상 이후 신기능이 회복되는지가 장기 예후를 좌우하므로, 회복기에 신기능 저하를 막는 것이 만성화를 막는 치료 목표가 됨. 기존 급성 신손상 예방 임상은 주로 시술 후 48~72시간 안에 AKI가 생겼는지를 평가해 왔음

CKD(만성콩팥병): 신장 손상이나 신기능 저하(eGFR 60 미만)가 3개월 이상 이어지는 상태임. 당뇨병과 고혈압이 주요 원인이며, 진행되면 말기신부전으로 이어짐. 미국에서는 만성콩팥병과 말기신부전 관련 지출이 공공의료보험(Medicare) 지출의 20% 이상을 차지할 만큼 의료비 부담이 큰 질환으로, 질환 진행을 늦춰 투석으로 넘어가는 환자를 줄이는 것이 주요 보건 과제로 꼽힘

KDIGO(Kidney Disease: Improving Global Outcomes): 신장질환 분야의 국제 진료지침을 만드는 비영리 국제기구임. 만성콩팥병과 급성 신손상의 진단 기준, 병기 분류, 치료 원칙을 제시함. 2026년 급성 신손상 지침 개정안에서는 AKI · AKD · CKD를 하나의 연속된 경과로 보고, 손상 이후 90일까지의 신기능 회복을 중요하게 강조함



Coverage Recommendation

》 삼성바이오로직스(207940)
》 한미약품(128940)
》 HK이노엔(195940)
》 압타바이오(293780)

BUY(유지)

삼성바이오로직스

207940

목표주가(유지)	2,100,000원	현재주가(11/02)	1,422,000원	Up/Downside	+47.7%	투자의견(유지)	Buy

2026. 11. 03

폴리펩타이드 그룹 인수로 GLP-1 시장 진입

파업 가운데 견조한 실적 개선: 3분기 실적은 매출액 14,953억원(+18.5%YoY), 영업이익 6,401억원(+1%YoY, OPM 43%)으로 시장기대치 대비 각각 10%, 5% 상회하였다. 국내 공장의 1-4공장 Full 가동과 5공장 Ramp-up 효과, 더불어 미국 공장의 매출이 본격 인식되면서 호실적을 기록하였다. 현재 5공장 수주는 60% 수준으로 예상되며 연내 대형 수주가 나온다면 내년초에는 6공장 증설에 대한 발표를 기대할 수 있다.

27년에도 inorganic M&A 효과로 실적 개선: 내년에는 폴리펩타이드 그룹 인수 및 미국 락빌 공장의 실적이 온전히 반영됨에 따라 매출액 72,392억원(+30%YoY), 영업이익 30,856억원(+25.2%YoY, OPM 42.6%)이 전망된다. 폴리펩타이드 그룹의 높은 매출원가율로 인하여 영업이익률 개선은 어려우나 모달리티 확장과 GLP-1 시장의 성장성을 고려할 때 긍정적으로 평가한다.

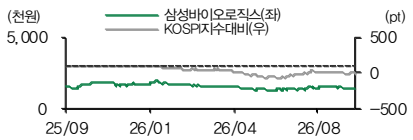
폴리펩타이드 그룹 인수는 모달리티 확장 그 이상의 의미: 폴리펩타이드 그룹은 페링의 펩타이드생산사업부가 독립하면서 설립되었다. 25년 매출은 389백만 유로(+15.6%YoY)로 대부분의 매출액은 대형 바이오텍 기업(25년 기준 매출액의 63%), 상업화 물량(61%)이고, 대사질환 펩타이드 의약품(약 57%)으로 부터 나온다. GLP-1 치료제에 대한 대사질환에 대한 시장 성장과 함께 폴리펩타이드 그룹도 21년부터 연평균 37%씩 매출이 증가하고 있다. 3개 대륙에 걸쳐 5개국 6개 생산 사이트를 보유하고 있고, 최근 삼성바이오로직스 유럽 영업소가 개소되었다는 점에서 글로벌 영업망 구축과 함께 실적으로 시너지를 기대할 수 있을 것으로 예상된다.

Investment Fundamentals (IFRS개별) (단위: 십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	3,497	4,557	5,569	7,239	8,557
(증가율)	19.0	30.3	22.2	30.0	18.2
영업이익	1,321	2,068	2,465	3,086	3,699
(증가율)	9.7	56.5	19.2	25.2	19.9
지배주주순이익	1,051	1,586	1,896	2,355	2,821
EPS	14,643	23,424	40,415	50,201	60,133
PER (H/L)	111.9/72.5	79.5/58.1	36.8	29.6	24.7
PBR (H/L)	12.7/8.2	11.7/8.6	7.8	6.2	5.0
EV/EBITDA (H/L)	47.8/31.8	35.8/27.1	21.0	17.1	14.1
영업이익률	37.8	45.4	44.3	42.6	43.2
ROE	12.0	19.0	22.7	22.4	21.6

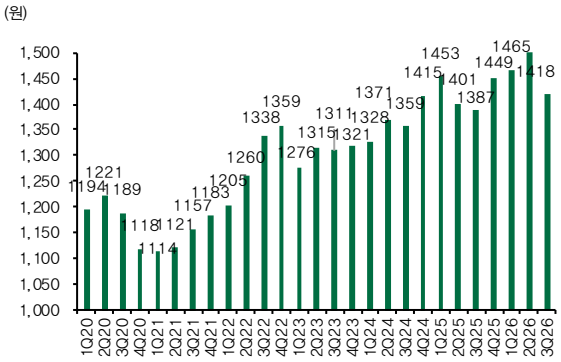
Stock Data

52주 최저/최고	1,182,000/1,949,875원
KOSDAQ /KOSPI	734/5,859pt
시가총액	658,257억원
60日-평균거래량	54,925
외국인지분율	12.7%
60日-외국인지분율변동추이	-0.2%p
주요주주	삼성물산 외 5 인 73.6%



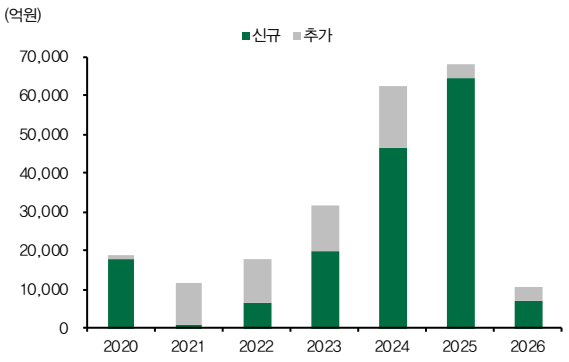
주가상승률	1M	3M	12M
절대기준	5.0	-3.5	17.4
상대기준	25.5	8.6	-17.7

도표 70. 분기별 달러환율 변동



자료: Bloomberg, DB증권

도표 71. 삼성바이오로직스 수주계약 추이(26년은 10월까지 누적)



자료: DART, DB증권

도표 72. 삼성바이오로직스 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출	**999.5**	**1,014.2**	**1,257.5**	**1,285.7**	**1,257.1**	**1,320.9**	**1,490.3**	**1,500.3**	**4,557.0**	**5,568.6**	**7,239.2**
YoY	49.3	25.2	17.8	35.3	25.8	30.2	18.5	16.7	30.3	22.2	30.0
매출총이익	**542.2**	**566.3**	**736.5**	**672.2**	**679.9**	**699.9**	**738.5**	**777.4**	**2,517.1**	**2,895.7**	**3,692.0**
YoY	80.5	39.7	41.2	38.5	25.4	23.6	0.3	15.7	46.9	15.0	27.5
매출총이익률	54.2	55.8	58.6	52.3	54.1	53.0	49.6	51.8	55.2	52.0	51.0
영업이익	**430.0**	**476.9**	**633.3**	**565.1**	**580.8**	**600.2**	**640.1**	**644.2**	**2,105.3**	**2,465.3**	**3,085.6**
YoY	84.8	44.8	42.4	79.6	35.1	25.9	1.1	14.0	59.3	17.1	25.2
영업이익률	43.0	47.0	50.4	44.0	46.2	45.4	43.0	42.9	46.2	44.3	42.6
당기순이익	**319.6**	**333.6**	**496.5**	**436.5**	**474.1**	**456.8**	**381.2**	**583.8**	**1,586.2**	**1,895.9**	**2,354.9**
YoY	9.3	9.7	10.1	7.0	8.9	7.6	5.4	5.7	50.9	19.5	24.2
당기순이익률	32.0	32.9	39.5	34.0	37.7	34.6	25.6	38.9	34.8	34.0	32.5

자료: 삼성바이오로직스, DB증권

삼성바이오로직스는 7월 펩타이드 CDMO 기업인 폴리펩타이드 그룹을 2.7조원에 공개매수를통해 100% 지분을 인수하기로 결정했다. 이를 위하여 8월에 3조원 규모(1차 발행가액 결정 이후 2.7조원으로 축소)의 주주배정 유상증자를 결정하였고, 인수는 11월 말 완료를 목표로 하고 있다.

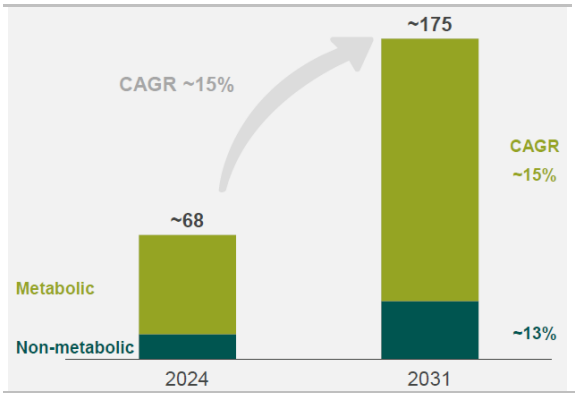
폴리펩타이드그룹은 1996년 페링의 펩타이드 생산사업부에서 분사한 70년 이상의 펩타이드 CDMO 사업을 영위한 전문기업으로 스위스 바르에 본사가 있다. 25년 기준 매출은 389백만 유로(+15.6%YoY)으로 약 250여 사의 고객사를 두고 있다. 1,000여개 의약품에 대한 생산 트랙 레코드와 2021년부터 펩타이드 의약품 성장에 맞추어 생산시설에 투자하면서 성장하고 있다. 제네릭 펩타이드 생산은 물론, 동물용 의료기기용 펩타이드까지 생산하고 있다.

대부분의 매출액은 대형 바이오텍 기업(25년 기준 매출액의 63%), 상업화 물량(61%), 그리고 대사질환에 대한 펩타이드 의약품(약 57%)로 부터 나온다. 최근 GLP-1 치료제에 대한 대사질환에 대한 시장 성장과 함께 폴리펩타이드 그룹도 21년부터 연평균 37%씩 매출이 증가하고 있다.

펩타이드 의약품 시장은 GlobalData에 따르면 연평균 15% 이상 성장하는 대사질환 치료제 시장 성장으로 31년 175십억 달러에 이를 것으로 전망된다. 그리고 대부분은 대사질환/Cadiovascular 및 종양 치료제에 대한 임상연구가 절반 이상을 차지하고 있다. 특허만료된 세마글루타이드의 출시가 인도, 브라질, 캐나다 등에서 승인되면서 폴리펩타이드 그룹이 타겟할 수 있는 시장도 커지고 있다.

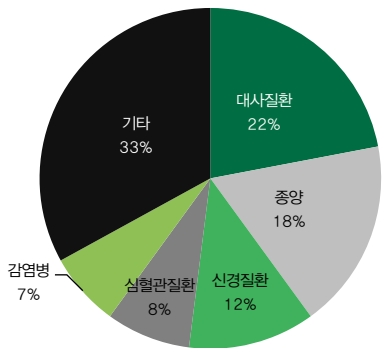
생산시설은 3개 대륙에 걸쳐 5개국 6개 생산 사이트, 미국에 샌디에고와 토런스, 프랑스 스트라스부르, 스웨덴 말뫼, 벨기에 브레인-알레우드, 인도 암베르나트에 있다. 2021년부터 24년까지 약 1억 유로를 투자해 상업용 GLP-1 관련 생산계약을 지원하는 대규모 생산능력을 구축하였다. 24년말부터 생산은 시작되었고, 25년말 목표 가동률에 도달하고 있다. 2028년까지 2023년 대비 2배에 해당되는 매출 6억 유로 달성 목표, EBITDA 마진 25% 달성, CAPEX 매출의 15-20% 목표로 하고 있다.

도표 73. 글로벌 치료용 펩타이드 시장 성장 (단위: 십억 달러)



자료: GlobalData, Polypeptide Group, DB증권

도표 74. 임상개발 중인 펩타이드 의약품 분야



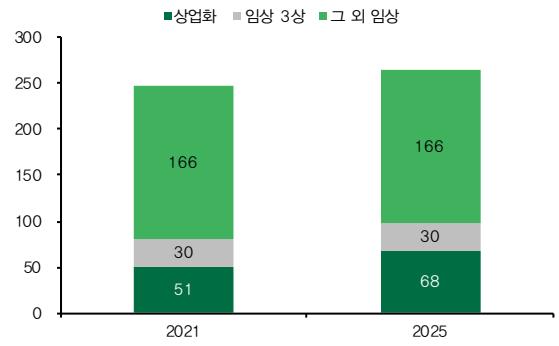
자료: GlobalData, Polypeptide Group, DB증권
주: 임상 1-3상, 또는 인허가 전인 약물 571개에 대한 분석 내용

도표 75. 폴리펩타이드 그룹 생산 글로벌 사이트



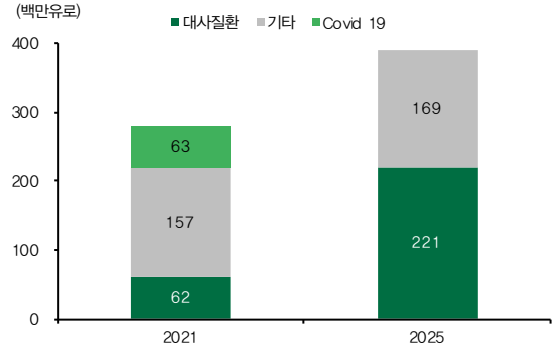
자료: Polypeptide Group, DB증권

도표 76. 폴리펩타이드 그룹 진행중인 프로젝트 수



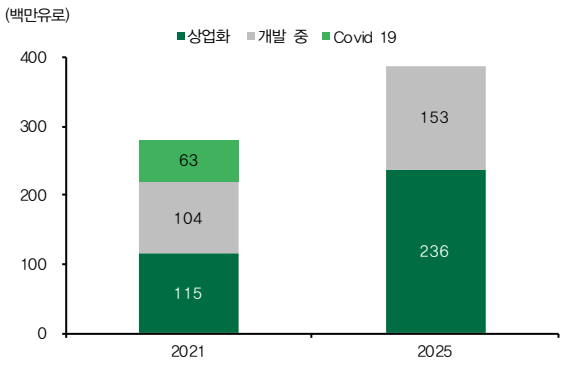
자료: Polypeptide Group, DB증권

도표 77. 폴리펩타이드그룹 매출액 성장



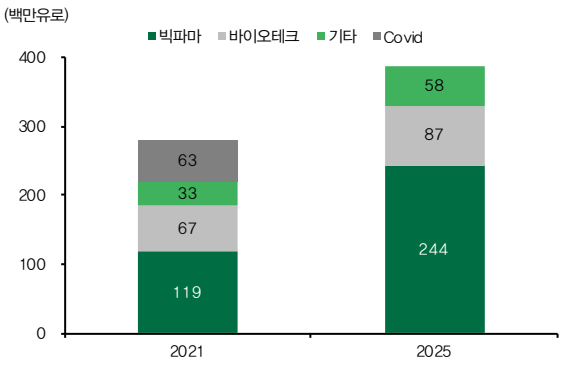
자료: Polypeptide Group, DB증권
주: CAGR은 코로나 매출 제외하고 산출한 결과, Metabolic은 GLP-1 작용제를 포함한 매출

도표 78. 폴리펩타이드 그룹의 개발단계별 매출 비중



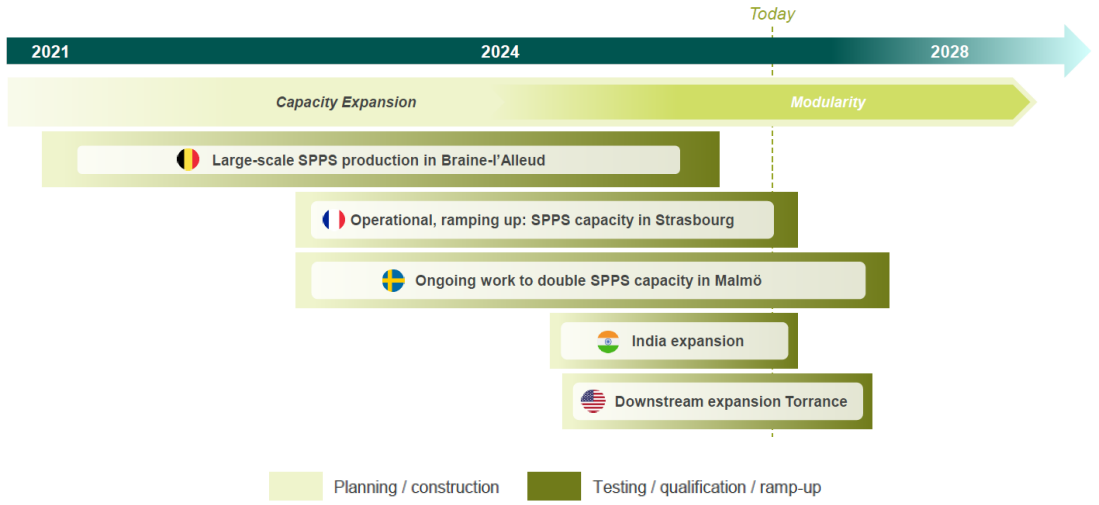
자료: Polytpeptide Group, DB증권

도표 79. 폴리펩타이드 그룹의 고객사 매출 비중



자료: Polypeptide Group, DB증권

도표 80. 폴리펩타이드 그룹 생산시설 투자 계획



자료:Polypeptide Group, DB증권

도표 81. 폴리펩타이드 그룹 실적 추이

(단위: 백만 유로)

구분	2024	2025	1H26
매출액	336.8	389.3	236.6
EBITDA	25.4	46.8	49.1
EBITDA 마진	7.5	12	20.7
EBIT	-7.4	8.7	21.9

자료: Polypeptide Group, DB증권

도표 82. 삼성바이오로직스 Polypeptide Group 인수 및 자금조달 공시

구분	내용
양수 회사	PolyPeptide Group AG
양수 주식 수(주 수)	33,016,411
양수 지분율	100.00%
양수 금액(억원)	27,061
양수 목적	펩타이드 CDMO 기업 인수를 통한 사업 경쟁력 강화
양수 예정 일자	2026-11-30
주요 사항	PolyPeptide Group의 최대주주인 Draupnir Holding B.V.의 보유 주식 18,375,000주(지분율 55.65%) 공개매수 응모 확약
자금조달 방식	유상증자 등을 통한 조달 자금

자료: DART, DB증권

대차대조표

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**3,992**	**4,393**	**5,501**	**5,971**	**6,690**
현금및현금성자산	300	141	859	309	199
매출채권및기타채권	786	677	639	925	1,083
재고자산	1,883	2,128	2,674	3,437	3,973
비유동자산	**9,325**	**6,630**	**7,660**	**9,494**	**11,713**
유형자산	5,048	6,028	7,382	9,227	11,455
무형자산	65	60	45	33	25
투자자산	3,353	56	56	56	56
자산총계	**13,317**	**11,024**	**13,161**	**15,465**	**18,403**
유동부채	**2,679**	**2,533**	**2,568**	**2,517**	**2,435**
매입채무및기타채무	1,135	497	533	482	400
단기차입금및단기사채	0	0	0	0	0
유동성장기부채	0	320	320	320	320
비유동부채	**1,357**	**1,076**	**1,276**	**1,276**	**1,476**
사채및장기차입금	918	599	799	799	999
부채총계	**4,036**	**3,609**	**3,844**	**3,793**	**3,911**
자본금	178	116	121	121	121
자본잉여금	5,672	3,392	3,392	3,392	3,392
이익잉여금	3,450	5,036	6,932	9,287	12,108
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	**9,281**	**7,415**	**9,317**	**11,672**	**14,493**

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동현금흐름	**1,383**	**1,953**	**2,170**	**2,140**	**3,187**
당기순이익	1,051	1,586	1,896	2,355	2,821
현금유출이없는비용및수익	**641**	**912**	**1,332**	**1,647**	**2,037**
유형및무형자산상각비	299	369	766	920	1,162
영업관련자산부채변동	**-65**	**-108**	**-464**	**-1,111**	**-785**
매출채권및기타채권의감소	-367	117	37	-286	-158
재고자산의감소	-261	-265	-546	-763	-536
매입채무및기타채무의증가	210	-131	35	-51	-83
투자활동현금흐름	**-1,181**	**-1,770**	**-1,936**	**-2,657**	**-3,461**
CAPEX	-1,297	-1,376	-2,103	-2,753	-3,381
투자자산의순증	-13	3,296	0	0	0
재무활동현금흐름	**-154**	**-337**	**176**	**-33**	**164**
사채및차입금의 증가	-164	-141	200	0	200
지분금및지분잉여금의증가	0	-2,343	6	0	0
배당금지급	0	0	0	0	0
기타현금흐름	21	-4	308	0	0
현금의증가	**69**	**-158**	**718**	**-550**	**-110**
기초현금	**231**	**300**	**141**	**859**	**309**
기말현금	**300**	**141**	**859**	**309**	**199**

손익계산서

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**3,497**	**4,557**	**5,569**	**7,239**	**8,557**
매출원가	1,784	2,040	2,673	3,547	4,107
매출총이익	**1,713**	**2,517**	**2,896**	**3,692**	**4,450**
판관비	392	449	430	606	751
영업이익	**1,321**	**2,068**	**2,465**	**3,086**	**3,699**
EBITDA	**1,620**	**2,437**	**3,231**	**4,005**	**4,861**
영업외손익	**81**	**11**	**24**	**21**	**8**
금융손익	82	14	27	24	11
투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-1	-3	-3	-3	-3
세전이익	**1,402**	**2,079**	**2,489**	**3,107**	**3,707**
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**1,051**	**1,586**	**1,896**	**2,355**	**2,821**
지배주주지분순이익	1,051	1,586	1,896	2,355	2,821
비지배주주지분순이익	0	0	0	0	0
총포괄이익	**1,042**	**1,583**	**1,896**	**2,355**	**2,821**
증감률(%YoY)					
매출액	19.0	30.3	22.2	30.0	18.2
영업이익	9.7	56.5	19.2	25.2	19.9
EPS	11.1	60.0	72.5	24.2	19.8

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

주요 투자지표

12월 결산(원, %, 배)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
주당지표(원)					
EPS	14,643	23,424	40,415	50,201	60,133
BPS	129,310	158,856	191,862	240,356	298,445
DPS	0	0	0	0	0
Multiple(배)					
P/E	95.4	72.4	36.8	29.6	24.7
P/B	10.8	10.7	7.8	6.2	5.0
EV/EBITDA	41.6	32.0	21.0	17.1	14.1
수익성(%)					
영업이익률	37.8	45.4	44.3	42.6	43.2
EBITDA마진	46.3	53.5	58.0	55.3	56.8
순이익률	30.1	34.8	34.0	32.5	33.0
ROE	12.0	19.0	22.7	22.4	21.6
ROA	8.4	13.0	15.7	16.5	16.7
ROIC	19.7	24.9	24.3	23.1	21.5
안정성및기타					
부채비율(%)	43.5	48.7	41.3	32.5	27.0
이자보상배율(배)	38.8	71.0	82.1	93.7	103.1
배당성향(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 삼성바이오로직스, DB증권 주: IFRS 개별기준

Compliance Notice

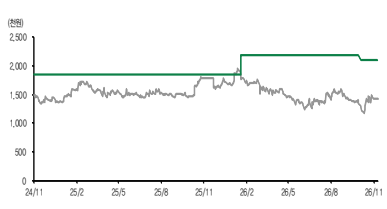
- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 자난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

1년간 투자의견 비율 (2026-10-01 기준) – **매수**(95.3%) **중립**(4.7%) **매도**(0.0%)

기업 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Buy**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Hold**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underperform**: 초과 상승률 -10%p 미만

업종 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Overweight**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Neutral**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underweight**: 초과 상승률 -10%p 미만

삼성바이오로직스 현주가 및 목표주가 차트



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경

일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저	일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저
24/10/24	Buy	1,260,000	-17.8	-6.0					
25/10/24		1년경과	-4.9	6.0					
26/01/22	Buy	2,200,000	-31.5	-17.9					
26/10/06	Buy	2,100,000	-	-					

BUY(유지)

한미약품

128940

목표주가(상향)	670,000원	현재주가(11/02)	422,500원	Up/Downside	+58.6%	투자의견(유지)	Buy

2026. 11. 03

이제 기대감은 에피노페그듀타이드로

바이오마린 기술이전 공시: 지난 30일 녹십자와 공동연구개발 중이던 HM15421(파브리병 치료제)은 바이오마린과 총 4.5억 달러에 기술수출계약(계약의 50%만 동사 지분)이 체결되었다. 현재 글로벌 임상 1/2상으로 지속형 플랫폼 기술을 적용해 월 1회 피하투여로 효소대체요법 효능을 유지하도록 설계되었다. 바이오마린은 올해 야미쿠스를 인수하여 경구용 파브리병 치료제 갈라폴드를 확보하였고, 보다 다양한 환자군을 확보하기 위하여 본 계약을 체결한 것으로 예상된다.

올해 총 규모 5.4조원 3번의 기술계약 체결. 계약금만 4천억원: 올해 3번의 기술계약은 희귀의약품 2건, 그리고 대사질환 약물이 1건으로 빅파마의 가장 큰 관심 분야에서의 성과였다. 본 계약으로 R&D 역량 가치는 상향되어야 하나 주가로 반영되지 못한다는 점에서 아쉬움이 있다. 아직 삼중작용제 HM15275(LA GLP/GCG/GIP)은 릴리와 노보만이 보유한 타겟이라는 점과 현존하는 가장 체중감량이 큰 레타트루타이드의 잠재적인 시장 영향력을 고려했을 때 시장에서 추가적인 기술 계약을 기대하는 에셋이다.

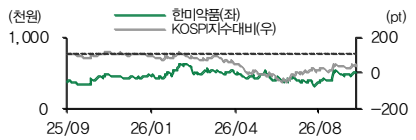
글로벌 R&D 역량에 대한 가치 상향으로 목표주가 67만원 상향: 머크의 3분기 실적 발표에 AASLD(미국간학회, 11/5-9)에서 에피노페그노타이드의 임상 2상 결과를 late-breaking 구두 발표 계획을 밝혔다. 이번 발표는 MASH 해소 및 섬유화 개선 비율로 성공적인 임상결과를 발표하게 된다면 HM12521(LAPS GLP/GCG/GIP)도 기대해볼 수 있겠다. 북경한미의 실적 부진에도 파이프라인 가치를 7800억원 상향 조정하여 목표주가를 상향하였다.

Investment Fundamentals (IFRS연결) (단위: 십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	1,496	1,548	1,903	1,685	1,752
(증가율)	0.3	3.5	23.0	-11.5	4.0
영업이익	216	258	542	286	293
(증가율)	-2.0	19.2	110.4	-47.2	2.2
지배주주순이익	121	170	375	206	217
EPS	9,470	13,235	29,303	16,066	16,972
PER (H/L)	39.8/25.7	37.3/16.2	14.4	26.3	24.9
PBR (H/L)	4.5/2.9	5.1/2.2	3.4	3.0	2.7
EV/EBITDA (H/L)	16.2/11.5	18.5/8.9	8.2	13.3	12.9
영업이익률	14.5	16.7	28.5	17.0	16.7
ROE	11.9	14.5	26.3	12.2	11.6

Stock Data

52주 최저/최고	311,500/626,000원
KOSDAQ /KOSPI	734/5,859pt
시가총액	54,126억원
60日-평균거래량	133,179
외국인지분율	11.9%
60日-외국인지분율변동추이	-3.3%p
주요주주	한미사이언스 외 6 인 49.6%



주가상승률	1M	3M	12M
절대기준	-16.5	26.7	-0.6
상대기준	-0.2	42.6	-30.3

도표 83. 한미약품 실적 추이 및 전망

(단위: 억원)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26P	4Q26E	2024	2025	2026E	2027E
매출액	**3,909**	**3,613**	**3,623**	**4,330**	**3,929**	**4,672**	3,774	6,659	**14,955**	**15,475**	**16,280**	**16,312**
yoy	-3.2	-4.4	0.1	23.1	0.5	29.3	4.2	53.8	0.3	3.1	5.2	0.2
한미약품	2,950	2,764	2,691	3,061	2,852	4,070	2,915	5,757	11,141	11,466	12,727	12,575
yoy	7.3	-1.9	-2.8	9.1	-3.3	47.3	8.3	88.1	1.6	2.7	11.0	-1.2
북경한미	965	867	941	1,251	1,064	607	793	956	3,856	4,024	3,481	3,662
yoy	-24.4	-12.2	11.6	67.0	10.3	-30.0	-15.7	-23.5	-3.0	4.0	-13.5	5.2
한미정밀화학	228	230	172	283	217	240	228	285	1,089	913	960	991
yoy	-8.1	-32.9	-40.9	36.7	-4.8	4.3	32.6	0.6	-2.0	-15.7	5.2	3.2
매출총이익	2,136	2,047	2,055	2,606	2,173	3,032	2,015	5,628	8,170	8,844	9,442	9,135
yoy	0.1	-8.7	-4.1	3.6	-1.0	4.8	12.2	-40.2	12.0	0.3	3.1	5.2
매출총이익률	54.6	56.7	56.7	60.2	55.3	64.9	53.4	84.5	54.6	57.2	58.0	56.0
판관비	1,091	1,003	959	1,255	1,065	1,200	1,097	1,777	4,220	4,308	4,233	4,600
경상개발비	454	435	545	524	571	521	540	652	1,788	1,958	2,116	1,925
영업이익	**591**	**609**	**551**	**827**	**537**	**1,311**	378	3,199	**2,162**	**2,654**	**3,093**	**2,610**
yoy	-22.9	4.8	8.0	171.5	-9.1	116.9	-31.4	284.6	-2.0	22.8	16.5	-15.6
영업이익률	15.1	16.9	15.2	19.1	13.7	28.1	10.0	48.0	14.5	17.2	19.0	16.0

자료: 한미약품, DB증권

도표 84. 한미약품 SOTP 밸류에이션

(단위:십억원, 배, 천주, 원)

구분		수정 후	수정 전	비고
영업가치	**제약사업**	4,628	4,628	
	2026E EBITDA	309	309	2026E 중 기술료제외
	EV/EBITDA	15	15	상위제약사 5개 평균 12ME
비영업가치	**자회사 가치**	118	118	
	한미정밀화학	32	32	73.7% 지분 보유
	북경한미	86	86	63.0% 지분 보유
	파이프라인 가치	3,004	2,224	
	HM12525A(LAPS GLP/GCG)	802	802	
	HM125211(LAPS GLP/GCG/GIP)	530	530	
	소네페글루타이드(LAPS GLP-2)	482	482	
	HM15275(LA GLP/GCG/GIP)	220	220	
	HM17321	820	190	
	HM15421	150		
2026E 순부채		-343	-221	2026E
유통주식수(천주)		12,680	12,680	자기주식 130,777제외
주당가치(원)		670,829	567,109	
목표주가(원)		**670,000**	**570,000**	

자료: DB증권

HM17321, 로슈의 품으로

지난 8월 로슈의 자회사 제넨텍과 기술계약을 체결한 HM17321(LA-UCN2)은 중추신경계 관련 Off-target인 CRFR1(Corticotropin-Releasing Factor)을 배제하고, CRF2 수용체를 선택적으로 작용하도록 설계된 urocortin-2(UCN2) 유사체로 체지방 감소 및 근육량 증가를 동시에 달성가능한 차세대 비만치료제 물질이다. 지속형 기술이 적용되어 있어 주 1회 주사제 제형으로 개발되고 있다. 작년 11월 미국 임상 1상 승인을 받아 SAD를 완료하고 연내 MAD 결과를 확인할 수 있다. 이후 임상부터는 제넨텍에서 후속 개발을 맡을 예정이다.

2024 Obesity Week 발표에 따르면, HM17321 단독으로 세마글루타이드 수준의 체중감량 및 지방감량(-17.3%)를 보였으며 제지방량(lean mass)는 유의미하게 증가, 골격근내 지방(TG) 함량을 감소시켜 근육의 양적 질적 개선을 입증하였다. 인크레틴 약물(세마글루타이드 또는 HM15275(GLP-1/GIP/Glucagon)과의 병용투여에서는 체지방감소율이 최대 70%까지 나타나며, 근육손실을 방지하며 제지방 및 골격근량을 보존, 증가시키는 시너지 효과를 보여주었다. 비만 원숭이에서도 체중>25%, fat mass>70% 감소와 함께 lean mass가 보존되거나 증가하는 경향을 보였다.

로슈는 Carmot Therapeutics 인수로 주 1회 투여 GLP-1/GIP 이중작용제 CT388과 경구용 GLP-1인 CT-996을 확보하여 임상 3상과 2상을 진행하고 있다. 그 뿐만 아니라 질랜드파마와의 협업으로 아말린 유사체 petrelintide과 함께 근육 감소를 저해하는 항미오스타틴 계열의 항체의약품 emuglobart 등을 보유하고 있었다. Emuglobart는 단독 투여시 체중 감소 효과가 낮고, GLP-1 병용 투약 편의성이 좋지 않고, 근기능 개선 여부 또한 불확실하다는 점에서 HM17321 인수 이후 개발을 중단하였다.

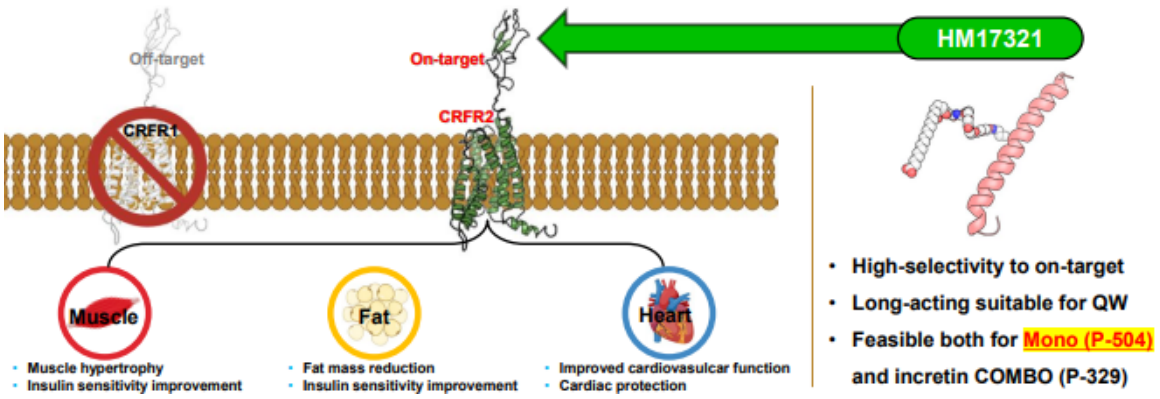
도표 85. 한미약품 HM17321 기술이전 계약 내용

계약 내용	장기 지속형 UCN2 유사체 HM17321(비만, 대사질환 치료제) 기술이전 계약 체결
계약파트너	Genentech
계약 체결일	2026-08-24
계약 기간	로열티 기간 만료일까지
대상 지역	전 세계 (대한민국 제외)
계약금액	총 23억 500만 달러 (약 3조 1,892억원)
계약금액	1억 9,000만 달러 (약 2,629억원)
마일스톤	총 21억 1,500만 달러 (약 2조 9,263억원)

자료: 한미약품, DB증권

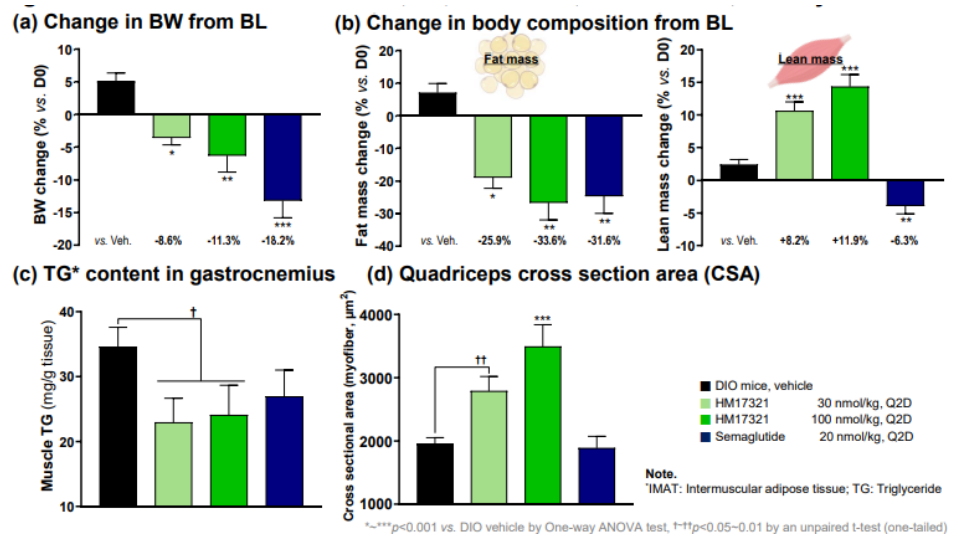
한미약품은 HM1732외에도 세계 최초로 펩타이드 기반 선택적 마이오스타틴 억제제인 HM50097(LA-MSTN)을 개발 중에 있다. 이 약물은 인크레틴에 의한 골격근 감소 예방 및 병용을 통한 양질의 체중관리 가능한 비만치료제로 개발하고 있다.

도표 86. HM17321 작용기전: Off-target 리스크를 해소하기 위해 CRFR-1이 아닌 CRFR2를 선택적이고 편향적으로 작용



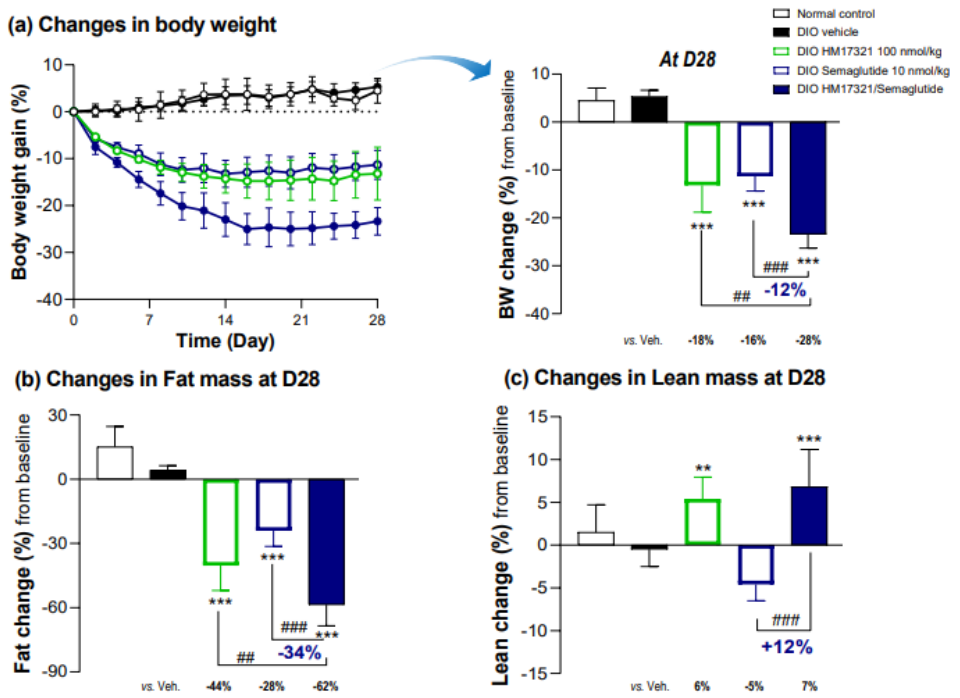
자료: ObesityWeek2024, DB증권
주: CRFR1은 주로 중추신경계 및 스트레스 반응축에 깊이 관여할 수 있어 장기 투여시 중추신경계 부작용을 일으킬 수 있음(Off-Target 차단)

도표 87. HM17321, 세마글루타이드 대비 체중, 지방량, 제지방 감소율 뿐 아니라 근육 질도 개선



자료: ObesityWeek2024, DB증권

도표 88. HM17321 단독 및 세마글루타이드와의 병용요법에서의 체중감량, 지방감량, 제지방량 변화



자료: ObesityWeek2024, DB증권

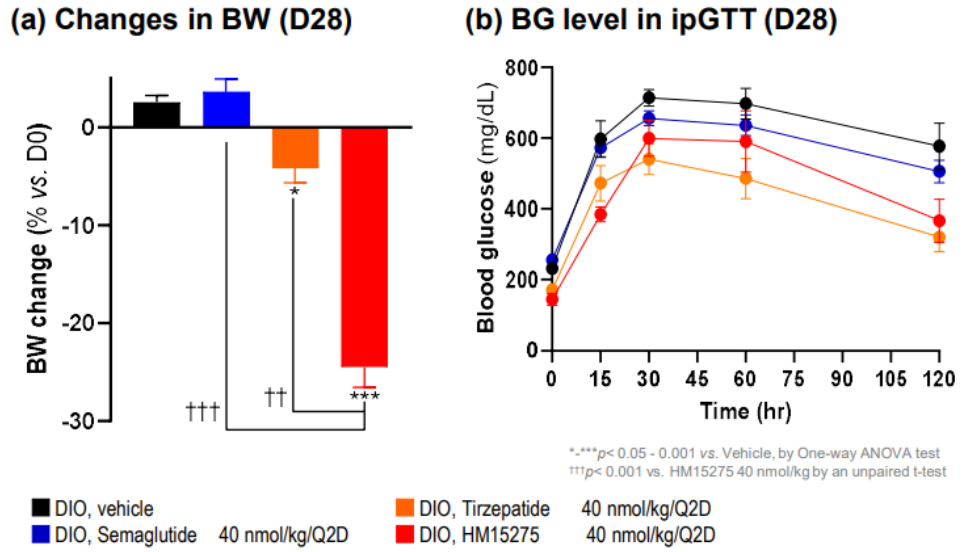
HM15275, 추가적인 기술계약을 기대

HM15275는 지속형 GLP-1, GIP 및 글루카곤 삼중작용제로 고도비만 및 이와 관련된 대사 장애인 이상지질혈증 및 제 2형 당뇨 등으로 적응증을 확장 개발하고자 하는 약물이다. 실제 비임상 연구에서 비만, 심혈관, 신장, 대사(CVRM) 질환 치료를 위한 Best-in Class의 잠재력을 갖추고 있다. 현재 임상 1상 연구를 완료하였고, 미국 임상 2상은 2건으로 나누어 진행하고 있다. 당뇨 미동반의 비만 및 과체중 환자를 대상으로 6주간 스크리닝 이후 36주간 장기 투여를 통해 위절제술 수준인 25% 이상의 체중감량 검증 4월에 환자 모집을 완료하였고고 2027년 1월 완료를 목표로 하고 있다(NCT07205900). 또 다른 임상은 당뇨동반(HbA1c 수치, 메트포르민 투약여부)의 비만 및 과체중 환자를 대상으로 내년 10월까지 진행할 계획(NCT07527650)이다.

EASD2025 전임상 결과에 다르면, HM15275는 GLP-1R 결핍 모델에서도 강력한 체중감량 효과를 유지해 GLP-1R 비의존적 작용기전, 특히 glucagon pathway의 기여 가능성을 뒷받침하였다. DIO 모델에서는 레타트루타이드 대비 더 큰 체중 및 지방량 감소를 보이면서 제지방량 감소는 유사한 수준으로 나타나 지방량 중심의 체중감량입증하였다. 건강인 및 과체중

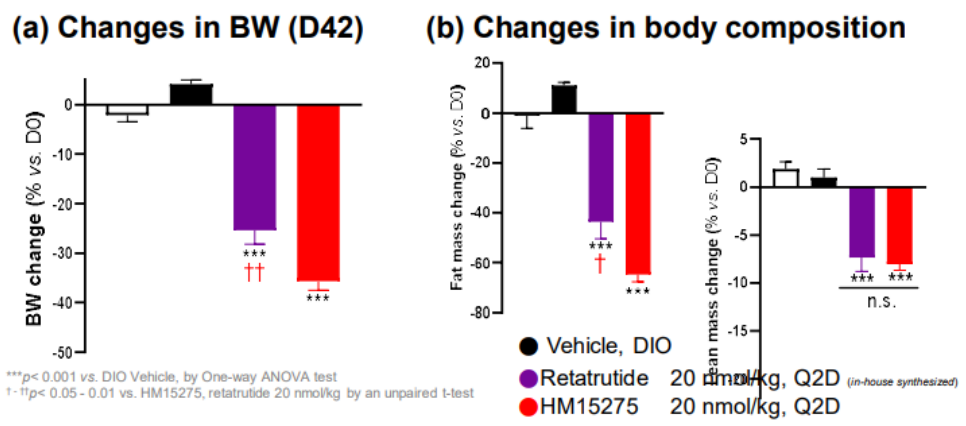
비만환자 대상으로 진행된 임상 1상을 통해 HM15275의 안전성, 내약성 뿐 아니라 약동학(PK) 및 약역학(PD)를 평가하여 인체내 체중감량 효과에 대한 임상적 개념증명 가능성을 확인한바 있다.

도표 89. HM15275, GLP-1R KO DIO 모델에서 체중감량 및 당뇨조절 능력 비교



자료: EASD2025, DB증권

도표 90. HM15275, DIO 모델에서 체중감량 및 제지방율 변화 비교



자료: EASD2025, DB증권

동사는 HM15275 개발 목표를 체중감소율 약 25% 이상으로 제시하는 만큼 이번 임상 2상에서 공개될 36주차 체중감소율은 최대 체중감소를 기록 중인 자랑하는 레타트루타이트(68주차 약 28.3% 체중감소)와 경쟁력이 중요한 것으로 보인다.

현재 삼중작용제는 일라이릴리 레타트루타이드, 노보 UBT251를 제외하면 Roche 등이 보유하고 있지 않다. 높은 체중감소율에 대한 니즈는 항상 존재한다는 점, 보다 안전한 다중 인크레틴 약물을 시장이 원한다는 면에서 기술수출 계약을 기대해볼 수 있는 약물이라고 생각된다.

에페오토인젝터주 탄생

국내 개발 제 44호 신약으로 허가받은 첫번째 토종 비만치료제이다. 당뇨병을 동반하지 않은 성인 비만 환자(초기 체질량지수 BMI 30kg/m2이상) 및 고혈압, 이상지질혈증, 심혈관 질환 등 체중 관련 동반질환을 최소 하나 이상앓고 있는 과체중 환자(BMI 27-30kg/m2 미만)의 만성 체중 관리를 위한 식이/운동요법의 보조제로 투여되는 피하주사 제형. 용량은 2,4,6,8,10 밀리그램 등 초 5개 함량에 대한 제조판매 품목허가를 승인 받았다.

사노피로부터 반환되기 전 약 4,000명 대상으로 진행한 대규모 글로벌 3상 심혈관계 안전성 임상(CVOT)을 통해 확인된 주요 심혈관 사건 위험 감소 와 신장보호 효능도 입증되었기 때문에 추가적인 대사질환 적응증 추가도 기대해볼 수 있겠다.

국내 GLP-1 치료제 시장은 약 2조원 규모. 수입의약품에서 토종의약품으로 대체할 수 있다는 점, 원료부터 완제품까지 평택 바이오플랜트에서 전량 자체 생산되는 만큼 안정적인 공급망을 갖추었고, 합리적인 가격 정책이 가능함. 또한 매출원가율 개선에 도움이 될 것으로 예상된다.

현재 제품 가치를 극대화하는 생애주기관리(LCM) 전략을 통해 2028년 허가 목표로 SGLT-2 저해제 및 메트포르민 병용 당뇨임상 3상 진행중. 프리필드시린지(PFS), 멀티펜 제형 개발, 디지털치료기기와 결합 등을 고려하고 있겠다

올해 벌써 2번째 기술이전, 희귀의약품 치료제 HM15421

10월 30일 녹십자와 공동으로 개발하고 있는 파브리병 치료제인 HM15421/GC1134A를 미국 바이오마린에 4.75억 달러(계약금 0.7억 달러, 마일스톤 4.05억 달러, 로열티 별도) 규모로 기술수출 계약이 발표되었다. 바이오마린은 한국을 제외한 전 세계에서 이 후보물질을 개발하고 판매할 권리를 갖는다. 현재 진행 중인 임상 1/2상 이후의 임상과 생산, 해외 상업화는 바이오마린이 단독으로 맡는다. 국내 판매 권리는 GC녹십자와 한미약품이 그대로 유지한다.

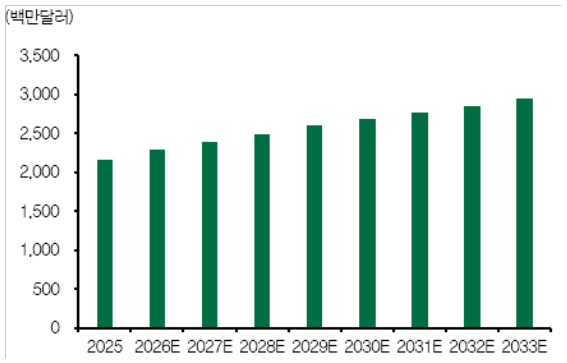
파브리병은 당지질을 분해하는 효소가 유전자 변이로 제 기능을 하지 못해 신장 · 심장 · 신경 등에 지방 성분이 쌓이며 장기가 손상되는 희귀 유전질환이다. 현재 표준 치료는 부족한 효소를 외부에서 넣어 주는 효소 대체요법으로 기존 치료제는 2주마다 정맥주사제이다. 최근에는 이지만, 환자가 2주마다 병원을 찾아 몇 시간씩 정맥주사를 맞아야 해 부담이 컸다.

HM15421/GC1134A는 효소가 몸속에 오래 머물도록 설계해 환자의 투여 간격을 늘리고, 정맥이 아닌 피하주사로 맞을 수 있도록 개발 중이다. 월 1회 투여를 목표로 하고 있다.

두 회사는 2020년 리소좀축적질환 신약 공동개발 계약을 맺은 뒤 2024년 미국 식품의약국(FDA)에서 임상 1/2상 시험계획 승인과 희귀의약품 지정을 받았다. 국내에서는 지난해 1월 임상 1/2상 승인을 받아 5월 첫 환자 투여를 시작했다.

바이오마린은 2026년 4월 Amicus를 약 48억 달러에 인수하면서 경구용 파브리병 치료제 galafold를 확보하였고, HM15421을 추가 확보하며 사업 영역을 효소대체요법(ERT)으로 확장했다. Galafold는 격일 1회 경구투여 약물로 사노피 Fabrazyme와 같은 효소대체요법(ERT)이 아닌 환자 체내에 남아있는 변이 a-Gal-A 효소를 안정화시키는 치료제로 전체 환자의 35-50% 수준만이 대상이 가능하다. 기존 치료제보다 환자 대상 범위가 넓어지며, 투약편의성까지 개선되었다는 점에서 기존 제품과의 차별성이 있다.

도표 91. 파브리병 치료제 시장 전망



자료: DB증권

도표 92. 파브리병 치료제 제품 현황

회사	제품명	제형	첫 출시
Sanofi	Fabrazyme	2주마다 정맥주사	2001.08
BioMarin Pharmaceutical	Galafold	격일 경구용	2016.05
Takeda	Replagal		2001.09
JCR Pharmaceuticals	Agalsidase Beta BS		2018.11

자료: DB증권

대차대조표

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**746**	**894**	**1,300**	**1,459**	**1,673**
현금및현금성자산	192	108	692	895	1,047
매출채권및기타채권	239	342	270	256	281
재고자산	301	339	307	272	305
비유동자산	**1,275**	**1,244**	**1,191**	**1,169**	**1,129**
유형자산	796	760	720	709	679
무형자산	94	113	101	89	80
투자자산	172	124	124	124	124
자산총계	**2,021**	**2,138**	**2,492**	**2,628**	**2,802**
유동부채	**683**	**605**	**595**	**535**	**494**
매입채무및기타채무	213	198	248	213	177
단기차입금및단기사채	371	320	250	230	215
유동성장기부채	31	14	24	19	29
비유동부채	**97**	**110**	**85**	**80**	**80**
사채및장기차입금	86	92	67	62	62
부채총계	**780**	**715**	**680**	**615**	**574**
자본금	32	32	32	32	32
자본잉여금	411	411	411	411	411
이익잉여금	681	836	1,186	1,367	1,559
비지배주주지분	156	173	212	233	256
자본총계	**1,241**	**1,423**	**1,812**	**2,014**	**2,228**

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동현금흐름	**193**	**173**	**667**	**313**	**207**
당기순이익	140	187	414	227	240
현금유출이없는비용및수익	**179**	**198**	**191**	**119**	**108**
유형및무형자산상각비	97	99	95	93	88
영업관련자산부채변동	**-90**	**-150**	**161**	**11**	**-95**
매출채권및기타채권의감소	-61	-87	72	13	-24
재고자산의감소	2	-37	32	35	-33
매입채무및기타채무의증가	-10	12	50	-35	-36
투자활동현금흐름	**25**	**-159**	**41**	**-43**	**-12**
CAPEX	-39	-43	-43	-70	-48
투자자산의순증	-128	49	0	0	0
재무활동현금흐름	**-94**	**-97**	**-125**	**-68**	**-42**
사채및차입금의 증가	-76	-62	-85	-30	-5
자본금및자본잉여금의증가	0	0	0	0	0
배당금지급	-13	-31	-25	-25	-25
기타현금흐름	13	0	0	0	0
현금의증가	**137**	**-84**	**584**	**203**	**153**
기초현금	**55**	**192**	**108**	**692**	**895**
기말현금	**192**	**108**	**692**	**895**	**1,047**

손익계산서

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**1,496**	**1,548**	**1,903**	**1,685**	**1,752**
매출원가	678	663	619	724	768
매출총이익	**817**	**884**	**1,285**	**960**	**984**
판관비	601	627	742	674	691
영업이익	**216**	**258**	**542**	**286**	**293**
EBITDA	**314**	**357**	**638**	**379**	**380**
영업외손익	**-45**	**-44**	**-30**	**-15**	**-7**
금융손익	-19	-5	3	18	26
투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-26	-39	-33	-33	-33
세전이익	**171**	**213**	**513**	**272**	**286**
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**140**	**187**	**414**	**227**	**240**
지배주주지분순이익	121	170	375	206	217
비지배주주지분순이익	19	18	39	21	23
총포괄이익	**175**	**194**	**414**	**227**	**240**
증감률(%YoY)					
매출액	0.3	3.5	23.0	-11.5	4.0
영업이익	-2.0	19.2	110.4	-47.2	2.2
EPS	-17.0	39.8	121.4	-45.2	5.6

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

주요 투자지표

12월 결산(원, %, 배)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
주당지표(원)					
EPS	9,470	13,235	29,303	16,066	16,972
BPS	84,685	97,553	124,874	138,957	153,947
DPS	1,250	2,000	2,000	2,000	2,000
Multiple(배)					
P/E	29.6	34.2	14.4	26.3	24.9
P/B	3.3	4.6	3.4	3.0	2.7
EV/EBITDA	12.9	17.4	8.2	13.3	12.9
수익성(%)					
영업이익률	14.5	16.7	28.5	17.0	16.7
EBITDA마진	21.0	23.0	33.5	22.5	21.7
순이익률	9.4	12.1	21.8	13.5	13.7
ROE	11.9	14.5	26.3	12.2	11.6
ROA	7.2	9.0	17.9	8.9	8.8
ROIC	13.8	17.3	34.5	20.9	21.2
안정성및기타					
부채비율(%)	62.9	50.2	37.5	30.5	25.8
이자보상배율(배)	8.9	15.2	37.9	23.5	25.3
배당성향(%)	11.3	13.6	6.1	11.2	10.6

자료: 한미약품, DB증권 주: IFRS 연결기준

Compliance Notice

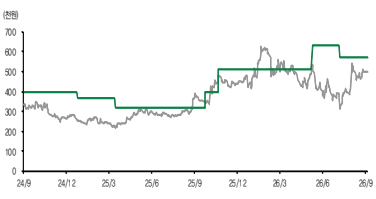
- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 자난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

1년간 투자의견 비율 (2026-10-01 기준) – **매수**(95.3%) **중립**(4.7%) **매도**(0.0%)

기업 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Buy**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Hold**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underperform**: 초과 상승률 -10%p 미만

업종 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Overweight**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Neutral**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underweight**: 초과 상승률 -10%p 미만

한미약품 현주가 및 목표주가 차트



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경

일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저	일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저
25/01/15	Buy	365,000	-31.7	-26.2					
25/04/07	Buy	320,000	-8.8	22.8					
25/10/15	Buy	400,000	-0.3	14.8					
25/11/12	Buy	510,000	-4.6	22.7					
26/06/01	Buy	630,000	-34.9	-19.5					
26/07/29	Buy	570,000	-22.3	-5.3					
26/11/03	Buy	670,000	-	-					

BUY(유지)

HK이노엔

195940

목표주가(유지)	57,000원	현재주가(11/02)	34,450원	Up/Downside	+65.5%	투자의견	Buy

2026. 11. 03

올해보다는 내년에 더 기대된다

선진국에 대한 케이캡 가치 반영은 내년에 본격적으로: 국내 및 중국 케이캡의 견조한 성장과 수액등 전문의약품의 매출 성장으로 올해 매출 10,808억원(+1.7%YoY), 영업이익 1,264억원(+13.9%YoY, OPM 11.7%) 전망된다. 최근 성공적인 미국 케이캡의 임상 3상 결과 발표는 내년 1분기 FDA의 신약승인 기대감을 높인다. 만약 미국 신약승인이 된다면 승인 또는 출시 마일스톤 및 판매 로열티가 내년에 반영될 것이다. 이미 미국 경쟁사인 Phathom의 보퀘즈나는 올해 출시 3년만에 매출 4200억원 이상을 전망하고 있다. 임상결과로 우수성을 입증한 만큼 파트너사의 판매역량에 따라 추가적인 성장도 가능할 것으로 예상된다. 일본, 한국, 중국에서 보았듯 위식도역류성식도염 시장 성장과 함께 PPI를 P-CAB으로 대체하면서 성장은 계속될 것으로 예상된다. 특히 올해는 특별한 호소식이 없었던 만큼 내년 케이캡의 글로벌 성과에 따른 신규 기술료 유입으로 인한 주가 반등을 기대해볼 수 있겠다.

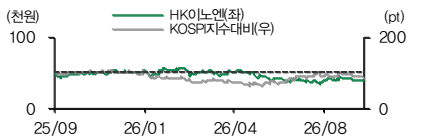
에크노글루타이드 중국 출시와 함께 28년 국내 출시 기대: 24년 4월 사이윈드 바이오사이언스로부터 unbiased cAMP GLP-1 RA인 에크노글루타이드의 국내 판권을 확보하였다. 현재 체중감량과 당뇨병 치료제로 임상 3상 중으로 27년 종료예정이다. 지난 4월 화이자 중국법인 또한 에크노글루타이드의 중화권 독점판권을 확보하여 올해 5월 정식 승인받아 출시하였다. 이미 ADA 학회 등을 통해 위고비보다 우수한 지방감량 및 안전성 데이터를 보여주었고, 소아대상 적응증 확장을 위한 긍정적인 임상 2상 결과 발표을 하였다. 이미 출시한 에페글레나타이드는 아직 당뇨동반 비만환자 대상으로 승인을 획득하지 못하였다는 점에서 후발주자지만 매출 성장을 기대해볼만 하다.

Investment Fundamentals (IFRS개별) (단위: 십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	897	1,063	1,081	1,157	1,218
(증가율)	8.2	18.5	1.7	7.0	5.2
영업이익	88	111	126	134	170
(증가율)	33.8	25.7	14.0	6.1	26.7
지배주주순이익	62	76	95	95	129
EPS	2,174	2,672	3,345	3,371	4,537
PER (H/L)	23.9/15.8	20.3/11.8	10.3	10.2	7.6
PBR (H/L)	1.2/0.8	1.2/0.7	0.7	0.7	0.6
EV/EBITDA (H/L)	14.0/10.4	11.9/8.1	7.1	6.3	4.6
영업이익률	9.8	10.4	11.7	11.6	14.0
ROE	5.0	5.9	6.9	6.6	8.3

Stock Data

52주 최저/최고	32,750/57,600원
KOSDAQ /KOSPI	734/5,859pt
시가총액	9,760억원
60日-평균거래량	109,534
외국인지분율	11.4%
60日-외국인지분율변동추이	-2.1%p
주요주주	한국콜마 외 9 인 43.1%



주가상승률	1M	3M	12M
절대기준	-14.2	-4.6	-30.3
상대기준	4.4	-6.5	-14.5

도표 93. HK이노엔 3Q26 실적

(단위: 억원, %, %p)

구분	3Q26	3Q25	YoY	2Q26	QoQ	컨센서스	%차이	기존 DB추정	괴리율
매출액	2,604	2,608	-0.2	2,672	-2.5	2,679	-2.8	2,696	-3.4
영업이익	260	259	0.6	300	-13.3	276	-5.8	256	1.6
영업이익률	10.0	9.9	0.1	11.2	-1.2	10.3	-0.3	9.5	0.5

자료: 에프앤가이드, DB증권

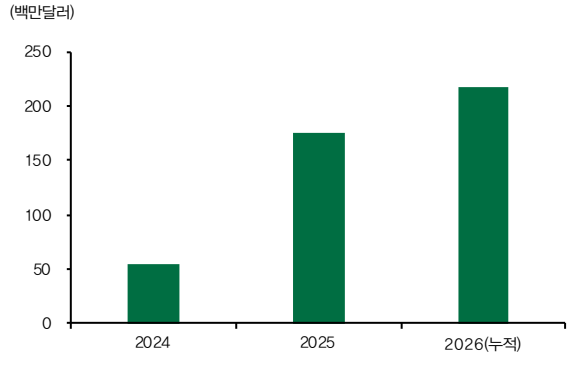
도표 94. HK이노엔 실적 추이 및 전망

(단위: 억원, %)

구분	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26E	2025	2026E	2027E
매출	**2,474**	**2,631**	**2,608**	**2,919**	**2,587**	**2,672**	**2,604**	**2,853**	**10,632**	**10,808**	**11,568**
YoY%	16.3	20.0	13.7	23.8	4.6	1.6	-0.2	-2.3	18.5	1.7	7.0
ETC사업	**2,259**	**2,432**	**2,456**	**2,707**	**2,391**	**2,467**	**2,397**	**2,634**	**9,854**	**9,987**	**10,712**
YoY%	17.5	25.4	19.1	27.4	5.8	1.4	-2.4	-2.7	16.1	9.8	11.0
수액제	335	339	388	355	371	385	405	405	1,417	1,556	1,727
순환기계	665	688	698	648	730	721	719	693	2,699	2,850	3,010
소화기계	488	504	477	538	470	506	441	527	2,007	2,005	2,500
- 케이캡	475	492	464	526	456	493	428	520	1,957	1,963	2,179
당뇨/신장	213	272	253	235	202	204	196	162	973	769	785
기타	226	189	193	516	213	205	214	313.9	1,124	989	989
H&B사업	**214**	**200**	**151**	**212**	**196**	**206**	**206**	**217**	**777**	**821**	**856**
YoY%	4.8	-21.6	-34.9	-8.9	-8.4	3.4	36.3	2.5	-15.9	5.7	4.2
매출총이익	1,146	1,131	1,187	1,412	1,172	1,194	1,133	1,495	4,877	5,036	5,437
매출총이익률	46.3	43.0	45.5	48.4	45.3	44.7	43.5	52.4	45.9	46.6	47.0
영업이익	**254**	**195**	**259**	**401**	**332**	**300**	**260**	**376**	**1,109**	**1,264**	**1,341**
YoY%	47.0	-19.8	16.4	64.5	30.8	53.6	0.6	-6.2	25.7	13.9	6.1
영업이익률	10.3	7.4	9.9	13.7	12.8	11.2	10.0	13.2	10.4	11.7	11.6

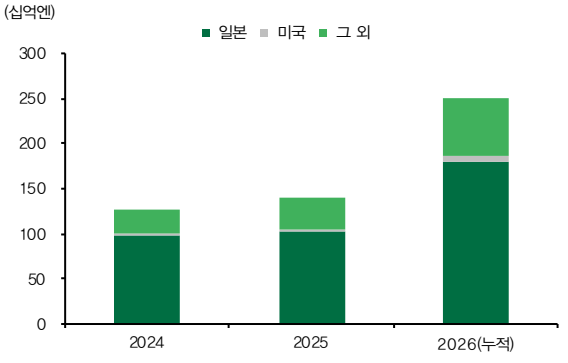
자료: DB증권

도표 95. Phathom Pharmaceuticals 연간 매출액



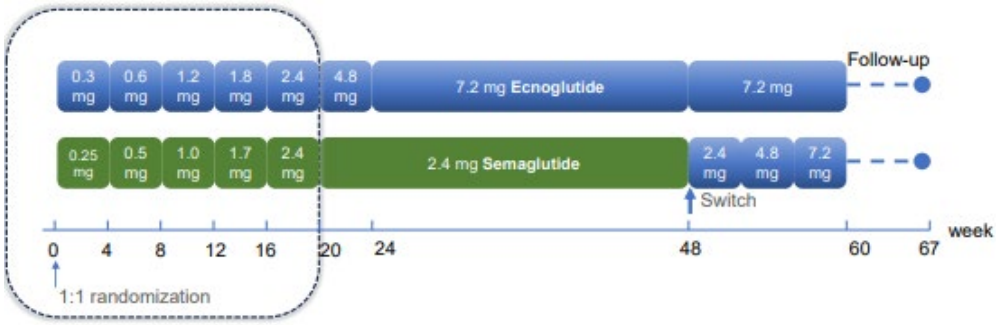
자료: DB증권

도표 96. 다케캡 국가별 연간 매출액



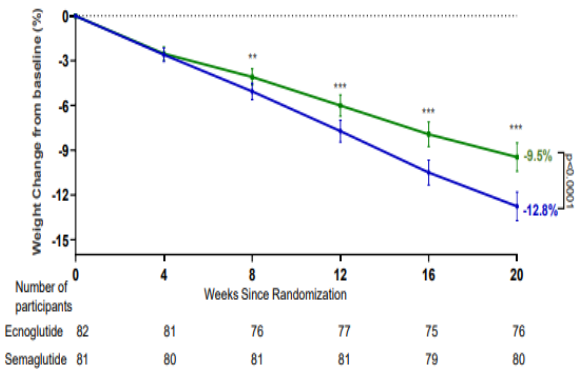
자료: DB증권

도표 97. 중국 사이윈드 에크노글루타이드 vs. 노보 세마글루타이드 비교 임상

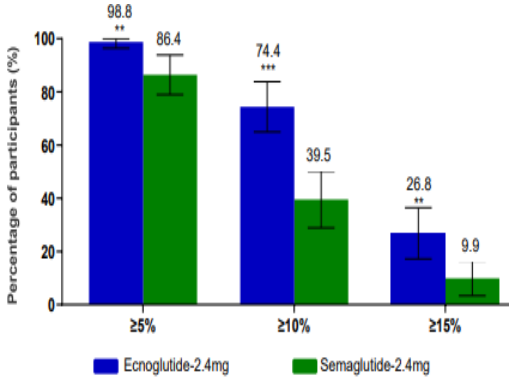


자료: ADA2026, HK이노엔, DB증권

도표 98. 에크노글루타이드 vs. 세마글루타이드 체중감량

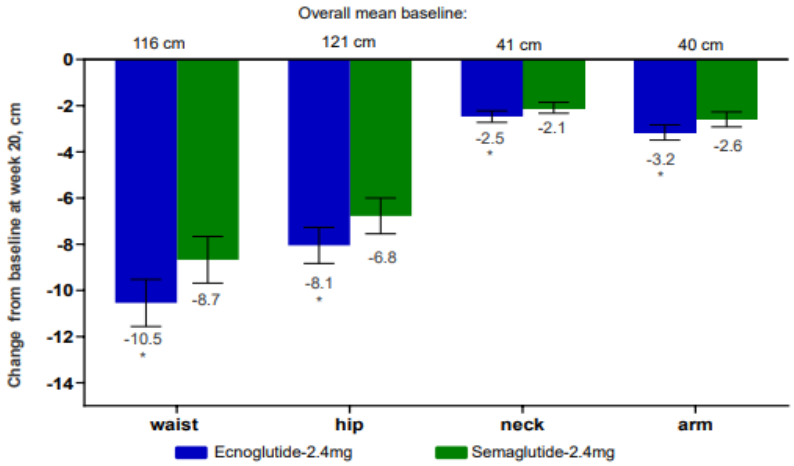


자료: ADA2026, HK이노엔, DB증권



자료: ADA2026, HK이노엔, DB증권

도표 99. 에크노글루타이드 vs. 세마글루타이드 신체 부위별 감량 정도



자료: ADA2026, HK이노엔, DB증권

대차대조표

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	**385**	**486**	**482**	**489**	**563**
현금및현금성자산	45	91	80	82	203
매출채권및기타채권	124	157	133	127	128
재고자산	177	168	180	195	148
비유동자산	**1,504**	**1,611**	**1,654**	**1,722**	**1,775**
유형자산	378	404	459	536	598
무형자산	1,071	1,069	1,059	1,050	1,041
투자자산	24	100	100	100	100
자산총계	**1,890**	**2,097**	**2,136**	**2,211**	**2,338**
유동부채	**464**	**593**	**585**	**592**	**611**
매입채무및기타채무	177	213	219	232	251
단기차입금및단기사채	250	310	302	302	302
유동성장기부채	23	53	48	42	42
비유동부채	**174**	**176**	**140**	**123**	**115**
사채및장기차입금	150	144	108	91	83
부채총계	**638**	**769**	**725**	**715**	**726**
자본금	14	14	14	14	14
자본잉여금	466	466	466	466	466
이익잉여금	208	275	358	442	559
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	**1,251**	**1,328**	**1,412**	**1,495**	**1,612**

손익계산서

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	**897**	**1,063**	**1,081**	**1,157**	**1,218**
매출원가	462	576	577	613	616
매출총이익	**435**	**488**	**504**	**544**	**601**
판관비	347	377	377	410	432
영업이익	**88**	**111**	**126**	**134**	**170**
EBITDA	**128**	**157**	**182**	**200**	**244**
영업외손익	**-16**	**-20**	**-22**	**-23**	**-21**
금융손익	-11	-12	-16	-14	-12
투자손익	0	0	0	0	0
기타영업외손익	-5	-8	-6	-9	-9
세전이익	**72**	**91**	**104**	**110**	**148**
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	**62**	**76**	**95**	**95**	**129**
지배주주지분순이익	62	76	95	95	129
비지배주주지분순이익	0	0	0	0	0
총포괄이익	**53**	**87**	**95**	**95**	**129**
증감률(%YoY)					
매출액	8.2	18.5	1.7	7.0	5.2
영업이익	33.8	25.7	14.0	6.1	26.7
EPS	30.8	22.9	25.2	0.8	34.6

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동현금흐름	**106**	**162**	**184**	**180**	**280**
당기순이익	62	76	95	95	129
현금유출이없는비용및수익	**73**	**90**	**81**	**96**	**106**
유형및무형자산상각비	40	46	55	66	74
영업관련자산부채변동	**-19**	**6**	**17**	**4**	**65**
매출채권및기타채권의감소	29	-21	24	5	-1
재고자산의감소	-36	9	-12	-15	47
매입채무및기타채무의증가	-2	21	5	14	18
투자활동현금흐름	**-130**	**-171**	**-115**	**-125**	**-122**
CAPEX	-117	-75	-100	-134	-128
투자자산의순증	1	-76	0	0	0
재무활동현금흐름	**-38**	**55**	**-81**	**-53**	**-37**
사채및차입금의 증가	-12	83	-49	-23	-8
자본금및자본잉여금의증가	-50	0	0	0	0
배당금지급	-6	-10	-12	-12	-12
기타현금흐름	0	0	0	0	0
현금의증가	**-62**	**46**	**-11**	**2**	**120**
기초현금	**108**	**45**	**91**	**80**	**82**
기말현금	**45**	**91**	**80**	**82**	**203**

주요 투자지표

12월 결산(원, %, 배)	2024	2025	2026E	2027E	2028E
주당지표(원)					
EPS	2,174	2,672	3,345	3,371	4,537
BPS	44,172	46,890	49,825	52,786	56,913
DPS	350	410	410	410	410
Multiple(배)					
P/E	16.5	18.5	10.3	10.2	7.6
P/B	0.8	1.1	0.7	0.7	0.6
EV/EBITDA	10.7	11.2	7.1	6.3	4.6
수익성(%)					
영업이익률	9.8	10.4	11.7	11.6	14.0
EBITDA마진	14.3	14.7	16.8	17.3	20.1
순이익률	6.9	7.1	8.8	8.3	10.6
ROE	5.0	5.9	6.9	6.6	8.3
ROA	3.3	3.8	4.5	4.4	5.7
ROIC	4.9	5.8	7.1	7.0	8.8
안정성및기타					
부채비율(%)	51.0	57.9	51.3	47.8	45.0
이자보상배율(배)	6.0	7.1	6.3	7.3	9.5
배당성향(%)	16.1	15.3	12.3	12.2	9.0

자료: HK이노엔 DB증권 주: IFRS 개별기준

Compliance Notice

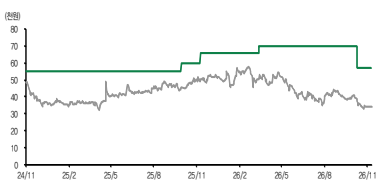
- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 자난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

1년간 투자의견 비율 (2026-10-01 기준) – **매수**(95.3%) **중립**(4.7%) **매도**(0.0%)

기업 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Buy**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Hold**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underperform**: 초과 상승률 -10%p 미만

업종 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Overweight**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Neutral**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underweight**: 초과 상승률 -10%p 미만

HK이노엔 현주가 및 목표주가 차트



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경

일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저	일자	투자의견	목표주가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저
24/01/17	Buy	55,000	-26.7	-8.2					
25/01/17		1년경과	-25.3	-10.7					
25/10/02	Buy	60,000	-18.9	-13.3					
25/11/12	Buy	66,000	-21.7	-12.7					
26/03/17	Buy	70,000	-37.4	-22.1					
26/10/13	Buy	57,000	-	-					

NR

압타바이오

293780

목표주가	–	현재주가(11/02)	5,290원	Up/Downside	NR	투자의견	NR

2026. 11. 03

APX115, 세계 최초 급성 신손상 치료제로 거듭 나는 순간

APX115, CI-AKI(조영제 유발 급성 신손상) 임상 2상 유효성 결과 미국신장학회에서 구두 발표: APX115는 경구용 pan-NOX 저해제로 당뇨병성 신증과 CI-AKI로 임상 2상임. 최근 CI-AKI 임상 종료에 따라 ASN(미국신장학회) 2026에서 2차 평가지표인 유효성 탑라인 결과를 발표함. 급성 신손상에 대한 치료제는 부재한 가운데 최근 CKD(만성신질환)로 진행 가능성을 예방하기 위한 치료의 중요성이 강조되며 치료가이드라인도 변경되고 있음. APX115는 AKD 발생률이 위약 대비 절반 수준으로 감소하였고, 12주(84일) 신손상 지표인 크레아티닌과 eGFR 수치 개선에서 통계적 유의성을 확보하면서 학회에서 주목을 받았다.

AKI 부터 DKD(만성당뇨병성신증) 임상결과로 APX-115의 패키지 기술 계약 기대: APX115는 활성산소 생성에 관여하는 NADPH oxidase(NOX) 효소군을 억제하는 경구용 pan-NOX 저해제로 산화 스트레스와 염증 반응을 조절하여 신장 손상을 완화하는 시키는 기전을 보유하고 있다. CI-AKI의 성공적인 임상결과로 내년 FDA에 Fast Track 신청예정이고, 27년 임상종료 예정인 당뇨병성 신증(DN) 중증환자 대상 임상 2b상의 성공 가능성도 높아졌다고 할 수 있다. 만약 신손상에 대한 예방부터 치료 효과까지 입증된다면, 높아진 글로벌 신증 치료제 관심으로 기술계약을 기대해볼 수 있다. 특히 기존 당뇨병성 신증 치료제들은 신기능 개선보다 보존적 요법이거나 케렌디아의 고칼륨혈증 등에 대한 안전성 문제를 고려할 때 글로벌 제약사의 관심이 높을 것이라 판단된다.

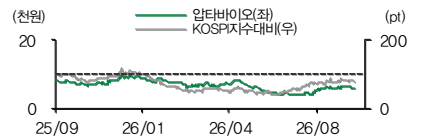
APX115를 제외한 CAF 표적 면역항암제 APX343A 등의 임상결과에도 관심 필요: MSD와의 공급계약을 통해 진행성 고형암 대상 키트루다 병용 임상이 순항 중인 APX343A, 점안액과 경구용으로 개발 중인 황반변성치료제 ABF101/1013 등의 연구결과 발표에 관심 필요하다.

Investment Fundamentals (IFRS연결) (단위: 십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	NA	0	0	3	4
(증가율)	NA	NA	NA	NA	33.3
영업이익	NA	-10	-16	-19	-16
(증가율)	NA	NA	적지	적지	적지
지배주주순이익	NA	-11	-12	-29	-16
EPS	NA	-474	-541	-1,247	-607
PER (H/L)	NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
PBR (H/L)	NA / NA	16.1/4.5	5.2/2.8	7.7/2.4	7.1/3.6
EV/EBITDA (H/L)	NA / NA	NA/NA	NA/NA	NA/NA	NA/NA
영업이익률	NA	-19,661.2	-5,055.6	-561.0	-428.4
ROE	NA	-20.2	-21.2	-50.8	-32.2

Stock Data

52주 최저/최고	4,000/10,420원
KOSDAQ /KOSPI	734/5,859pt
시가총액	1,486억원
60日-평균거래량	61,923
외국인지분율	1.5%
60日-외국인지분율변동추이	-0.2%p
주요주주	이수진 외 3 인 27.2%



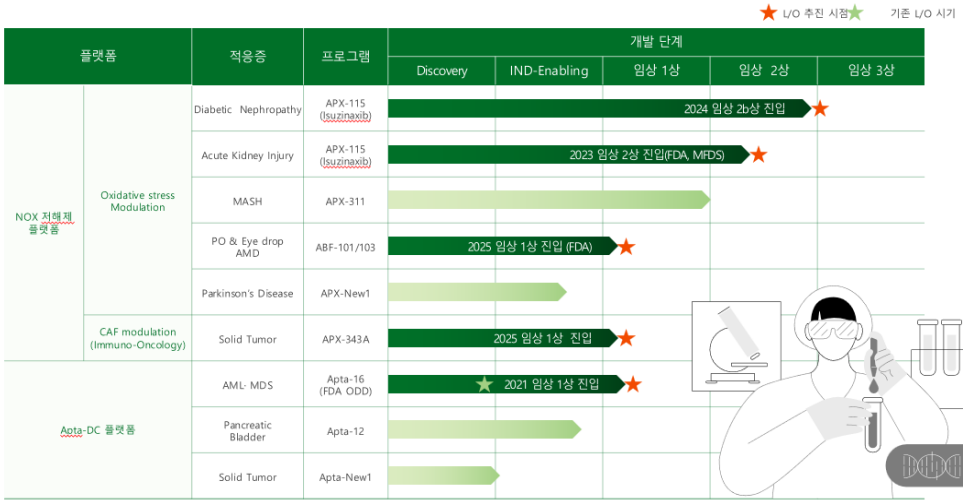
주가상승률	1M	3M	12M
절대기준	-32.2	15.1	-24.5
상대기준	-17.5	12.8	-7.5

도표 100. 아이수지낙시브, 당뇨병성 신증 및 조영제 유발 급성 신손상 임상 2상 개발

플랫폼		적응증	프로그램	개발 단계				
				Discovery	IND-Enabling	임상 1상	임상 2상	임상 3상
NOX 저해제 플랫폼	Oxidative stress Modulation	Diabetic Nephropathy	APX-115 (Isuzinaxib)	임상 2b상 진행 중(MFDS)				
		Acute Kidney Injury	APX-115 (Isuzinaxib)	2026 임상 2상 종료(FDA, MFDS)				

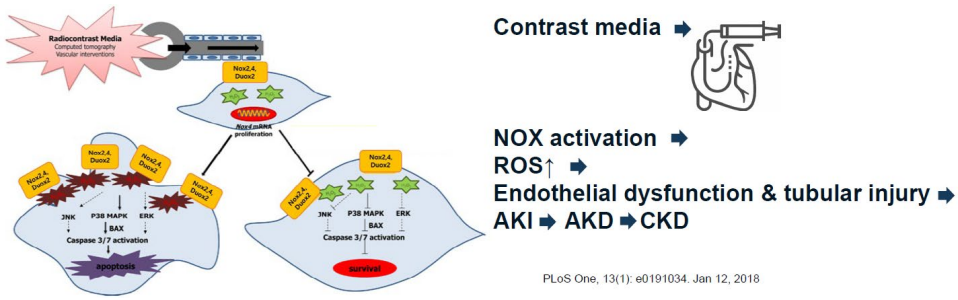
자료: 압타바이오, DB증권

도표 101. 압타바이오 신약 파이프라인 개발 현황



자료: 압타바이오, DB증권

도표 102. 아이수지낙시브 작용기전



자료: ASN2026, 압타바이오, DB증권

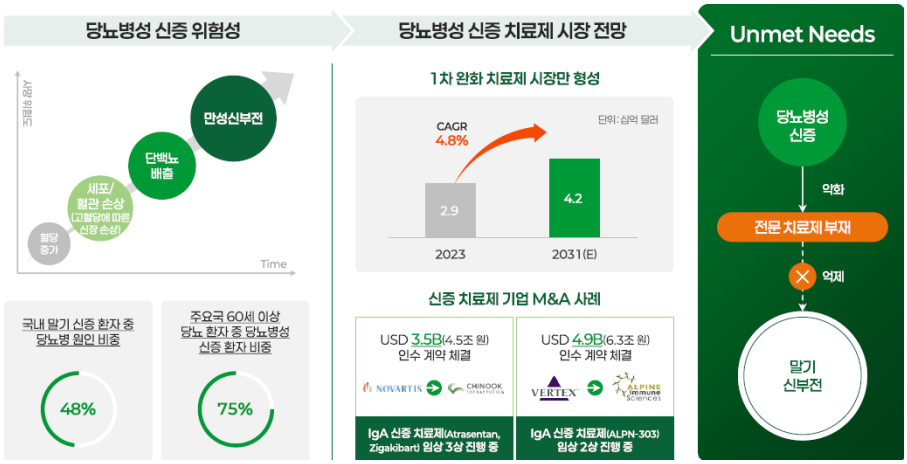
도표 103. AKI to AKD CKD로 진행되는 과정



발생 ~7일	발생 7-90일	발생 90일 이상
serum creatinine	persistent eGFR decline Kidney damage markers	eGFR decline albuminuria (UACR)

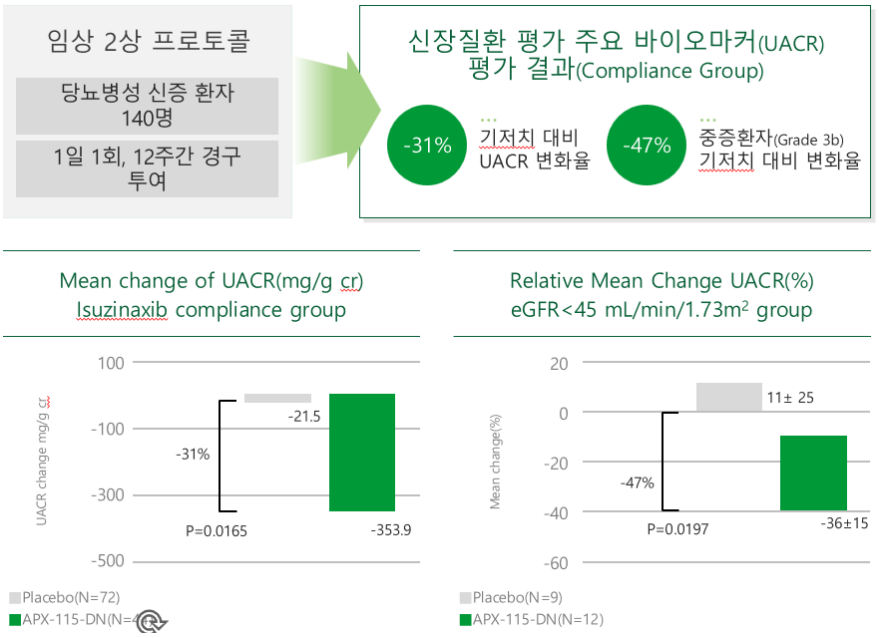
자료: ASN2026, 압타바이오, DB증권

도표 104. 아이수자낙시브, 당뇨병성 신증 시장



자료: 압타바이오, DB증권

도표 105. 아이수지낙시브 당뇨병성 신증에 대한 유럽 임상 2a 결과: 중증환자에서 UACR 개선도 높음



자료: 압타바이오, DB증권

도표 106. 만성 신장질환에 대한 기술계약 사례

(단위: 억 달러)

인수 기업	일자	피인수기업	파이프라인	작용 기전	계약 규모
Akebia	2021	Cyclerion	Praliciguat	경구 sGC 자극제	L/O, 5.85
AstraZeneca	2023.01	CinCor	Baxdrostat	SGLT2 억제제 병용	M&A, 18
Novartis	2023.06	Chinook Therapeutics	Astrasentan, Zigakibart	최초의 선택적 ETAR 길항제, 항-APRIL 단일클론항체	M&A, 35
Novartis	2025.05	Regulus Therapeutics	Farabursen	miR-17 타깃, 올리고뉴클레오타이드 기반 약물	M&A 8, CVR 9
Novartis	2025.10	Avidity Biosciences	신경근육질환	RNA 타깃 전달 플랫폼 AOC 기술	M&A, 120
Vertex	2024.04	Alpine Immune Sciences	Povetacicept	BAFF와 APRIL 사이토카인 2중, IgA 신증 2상에서 최고 수준의 효능 가능성	M&A, 49
Asahi Kasei	2024.05	Calliditas Therapeutics	Tarpeyo, Setanaxib	IgA 신증 치료제, NOX1/4 저해제	M&A, 11
Asahi Kasei	2019.11	Veloxis Pharmaceuticals	Envarsus XR	신장이식 환자 면역반응 억제제	M&A, 13
Biogen	2026.03	Apellis	APL-3007	siRNA 치료제, 지리위축 환자 Syfovre 병용 투여	M&A, 56

자료: 각 사, DB증권

대차대조표

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
유동자산	NA	20	57	35	25
현금및현금성자산	NA	2	25	26	16
매출채권및기타채권	NA	0	0	1	1
재고자산	NA	0	0	0	1
비유동자산	NA	36	35	42	35
유형자산	NA	5	5	5	6
무형자산	NA	0	0	0	1
투자자산	NA	28	26	34	26
자산총계	NA	56	93	77	60
유동부채	NA	1	1	20	10
매입채무및기타채무	NA	1	1	5	3
단기차입금및단기사채	NA	0	0	7	4
유동성장기부채	NA	0	0	0	0
비유동부채	NA	3	30	4	3
사채및장기차입금	NA	0	14	0	0
부채총계	NA	4	31	23	13
자본금	NA	11	12	13	14
자본잉여금	NA	109	130	150	158
이익잉여금	NA	-68	-81	-110	-126
비지배주주지분	NA	0	0	0	0
자본총계	NA	52	61	54	47

손익계산서

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
매출액	NA	0	0	3	4
매출원가	NA	0	0	3	2
매출총이익	NA	0	0	0	1
판관비	NA	3	4	5	7
영업이익	NA	-10	-16	-19	-16
EBITDA	NA	-9	-16	-18	-15
영업외손익		-1	1	-9	0
금융손익	NA	-1	2	-7	3
투자손익	NA	0	0	0	1
기타영업외손익	NA	0	-1	-2	-4
세전이익	NA	-11	-15	-28	-15
중단사업이익	NA	0	0	0	0
당기순이익	NA	-11	-12	-29	-16
지배주주지분순이익	NA	-11	-12	-29	-16
비지배주주지분순이익	NA	0	0	0	0
총포괄이익	NA	-10	-12	-29	-16
증감률(%YoY)					
매출액	NA	NA	569.8	937.8	10.0
영업이익	NA	NA	적지	적지	적지
EPS	NA	NA	적지	적지	적지

주: K-IFRS 회계기준 개정으로 기존의 기타영업수익/비용 항목은 제외됨

현금흐름표

12월 결산(십억원)	2021	2022	2023	2024	2025
영업활동현금흐름	NA	-7	-14	-12	-15
당기순이익	NA	-11	-12	-29	-16
현금유출이없는비용및수익	NA	5	8	22	21
유형및무형자산상각비	NA	0	1	1	0
영업관련자산부채변동	NA	0	-1	3	-4
매출채권및기타채권의감소	NA	0	0	-1	0
재고자산의감소	NA	0	0	0	0
매입채무및기타채무의증가	NA	0	0	3	-2
투자활동현금흐름	NA	2	-13	13	6
CAPEX	NA	1	0	0	0
투자자산의순증	NA	-28	2	-8	9
재무활동현금흐름	NA	0	50	0	-1
사채및차입금의 증가	NA	0	27	-12	-8
자본금및자본잉여금의증가	NA	120	21	22	9
배당금지급	NA	0	0	0	0
기타현금흐름	NA	0	0	0	0
현금의증가	NA	-5	23	1	-9
기초현금	NA	7	2	25	26
기말현금	NA	2	25	26	16

주요 투자지표

12월 결산(원, %, 배)	2021	2022	2023	2024	2025
주당지표(원)					
EPS	NA	-474	-541	-1,247	-607
BPS	NA	2,349	2,630	2,016	1,680
DPS	NA	0	0	0	0
Multiple(배)					
P/E	NA	NA	NA	NA	NA
P/B	NA	4.5	3.4	3.2	5.6
EV/EBITDA	NA	NA	NA	NA	NA
수익성(%)					
영업이익률	NA	-19,661.2	-5,055.6	-561.0	-428.4
EBITDA마진	NA	-18,659.0	-4,889.1	-545.2	-415.4
순이익률	NA	-21,849.3	-3,724.2	-874.1	-442.0
ROE	NA	-20.2	-21.2	-50.8	-32.2
ROA	NA	-18.8	-16.2	-34.6	-23.8
ROIC	NA	-147.0	-125.6	-148.7	-159.0
안정성및기타					
부채비율(%)	NA	7.1	50.8	42.9	27.2
이자보상배율(배)	NA	-	-13.8	-5.5	-7.5
배당성향(%)	NA	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 압타바이오, DB증권 주: IFRS 연결기준

Compliance Notice

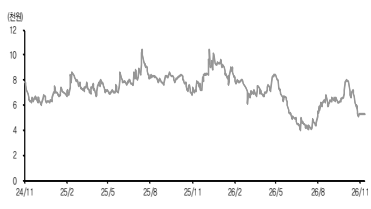
- 자료 발간일 현재 본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 자난 1년간 위 조사분석자료에 언급한 종목들의 IPO 대표주관업무를 수행한 사실이 없습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 자료 발간일 현재 조사분석자료에 언급된 법인과 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제2조 제3호에 따른 계열회사의 관계에 있지 않습니다.
- 동 자료내용은 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.
- 본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 발행주식수 변동 시 목표주가와 괴리율은 수정주가를 기준으로 산출하였습니다.

1년간 투자의견 비율 (2026-10-01 기준) – **매수**(95.3%) **중립**(4.7%) **매도**(0.0%)

기업 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Buy**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Hold**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underperform**: 초과 상승률 -10%p 미만

업종 투자의견은 향후 12개월간 당사 KOSPI 목표 대비 초과 상승률 기준임
- **Overweight**: 초과 상승률 10%p 이상
- **Neutral**: 초과 상승률 -10~10%p
- **Underweight**: 초과 상승률 -10%p 미만

압타바이오 현주가 및 목표주가 차트



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경

일자	투자의견	목표가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저	일자	투자의견	목표가	괴리율(%) 평균	괴리율(%) 최고/최저

DB Securities

MEMO

DB Securities

MEMO

DB증권

애널리스트 현황

DB증권 리서치센터



[리서치센터장/보험]
이병건
02)369-3381
pyrrhon72@dbsec.co.kr



[채권/FX전략]
문홍철
02)369-3436
m304050@dbsec.co.kr



[통신/지주/인터넷]
신은정
02)369-3458
ej.shin@dbsec.co.kr



[에너지/케미칼]
한승재
02)369-3921
sjhan@dbsec.co.kr



[주식전략/자산배분]
강현기
02)369-3479
hygkang@dbsec.co.kr



[은행/증권/핀테크]
나민욱
02)369-3746
minwook.na@dbsec.co.kr



[제약/바이오]
이명선
02)369-3425
mslee@dbsec.co.kr



[중국전략]
김선영
02)369-3438
tjs00dud@dbsec.co.kr



[자동차/자동차부품]
남주신
02)369-3924
jsnam@dbsec.co.kr



[유통/뷰티/패션]
허제나
02)369-3367
jnh@dbsec.co.kr



[경제]
박성우
02)369-3441
p3swo@dbsec.co.kr



[반도체]
서승연
02)369-3387
sy.seo@dbsec.co.kr



[이차전지/철강금속]
안회수
02)369-3429
hoesoo@dbsec.co.kr



[퀀트]
설태현
02)369-3709
thseol@dbsec.co.kr



[전기전자]
조현지
02)369-3457
hyunji96@dbsec.co.kr



[의료기기]
김지은
02)369-3455
kje7335@dbsec.co.kr



[크레딧]
박경민
02)369-3446
gmpark@dbsec.co.kr



[연구원]
김수한
02)369-3757
ksh929799@dbsec.co.kr



[방산/조선/기계]
서재호
02)369-3431
wogh7082@dbsec.co.kr



[해외주식]
이진경
02)369-3442
true113@dbsec.co.kr



[연구원]
이정호
02)369-3758
jungholee9@dbsec.co.kr



[연구원]
정준우
02)369-3717
wnsdnwjd98@dbsec.co.kr

DB증권

본 사

본사 영업부	02) 369-3200	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32(DB증권빌딩 1~2층)

서울지역

강남금융센터	02) 3474-9000	서울특별시 서초구 강남대로 343 신덕빌딩 10층
DB Alpha+ Club	02) 3011-5000	서울특별시 강남구 테헤란로 432 (DB금융센터 27층)
목동금융센터	02) 2636-6000	서울특별시 양천구 목동서로 159-1 (CBS기독교방송 1층)
을지로금융센터	02) 753-9000	서울특별시 중구 남대문로 113 (DB다동빌딩 9층)
잠실금융센터	02) 419-6200	서울특별시 송파구 올림픽로 35다길 42 (한국루터회관 1층)

경기지역

분당	031) 718-7000	경기도 성남시 분당구 성남대로 151 (엠코헤리츠 2층)

대전 · 충청지역

대전	042) 522-6600	대전광역시 서구 둔산서로 59 (고운손빌딩 2층)

부산 · 경상지역

남천	051) 242-6000	부산광역시 수영구 수영로 410 (정암빌딩 2층)
부산	051) 515-6200	부산광역시 동래구 충렬대로 353 2층
해운대마린금융센터	051) 741-7200	부산광역시 해운대구 마린시티2로 38 업무동 9층
대구금융센터	053) 476-4000	대구광역시 수성구 무학로 99 (호연빌딩 2층)

광주 · 전라지역

광주	062) 655-3400	광주광역시 남구 봉선로 164 (삼환빌딩 4층)
전주	063) 229-2211	전라북도 전주시 완산구 홍산로 254 (코트빌딩 6층)

강원지역

원주	033) 765-9400	강원도 원주시 서원대로 406 (리더스타워 3층)

본 조사자료는 고객의 투자참고용으로 작성된 것이며, 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 어떠한 경우에도 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사자료는 당사의 허락없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.